

中医诊断学

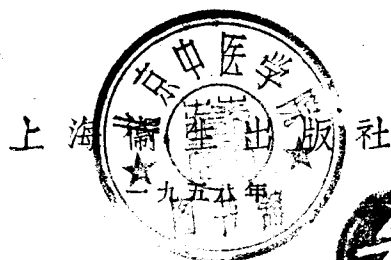
江苏省中医学校 編 著
診 断 教 研 組

上海衛生出版社

样 本 库

中 医 診 断 学

江苏省中医学学校
診 断 教 研 組 編 著



24045



內 容 提 要

本書的主要內容是介紹中醫的診斷方法,分上下兩篇:上篇總論,敘述中醫診斷學的重要性及其基本精神,闡明有關理論問題;下篇各論,分述“八綱”“四診”等中醫診斷學的基本內容,尤其對“望聞問切”的具體方法,作了詳細的闡述和分析。

本書系依據中醫理論體系編寫而成的,簡明扼要,還附有複習題;可作中醫進修和西醫學習中醫的教材,並可供臨床醫師的參考。

255P/18

中 醫 診 斷 學

江蘇省中醫學校
診 斷 教 研 組 編著

*

上海衛生出版社出版

(上海南京西路2004號)

上海市書刊出版業營業許可證出080號

上海中和印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 1/27 印張 4 22/27 字數 108,000

1958年7月第1版 1958年7月第1次印刷

印數 1—15,000

統一書號 14120·514

定價 (9) 0.55 元

序

祖国医学，几千年来，在广大劳动人民与疾病作斗争的过程中，积累了很丰富的宝贵经验。无论是“脉因证治”，或者是“理法方药”，从诊断到治疗，都有其系统的理论指导，遵循着这些法则，就可以获得预期的效果。不过，正如大家所知道的，没有正确的诊断，就没有正确的治疗，因此，诊断学就显得特别重要。

祖国医学有关诊断的资料，散见于经典著作和各家著述中，而且在这浩瀚的中医书籍中，占着相当大的比重，因此，要进行系统的整理，还是一项比较艰巨的工作。本书的编著，只是我们在这方面的一个初步尝试。

我校建立之初，为了教学工作的需要，编写了一本诊断讲义，经过几次的试用和修改，而逐渐形成本书。其编写要求，主要是理论结合实践，因此，着重指出“八纲”“四诊”在临证中不但是同样的重要，而且有着密切的相互关系，并说明其具体运用的灵活性，以便于学者能深入领会，从而更好地进行辨证论治。由于我们的水平所限，其中难免还存在着很多缺点，现在将其整理出版，希望读者多多提供宝贵意见，以便再版时修正。

伟大的“七一”即将到来，谨以此书向党的生日献礼！

江苏省中医学校诊断教研组

1958年6月

目 录

上篇 总 論

第一章 中医诊断学的重 要意义	1
第二章 中医诊断学的基 本精神	3
第一节 整体观念	3
第二节 辨证論治	5

一、五藏六府	6
二、十二經絡与奇經八脉	6
三、六經	9
四、三焦	10
五、营卫气血	11

下篇 各 論

第一章 八綱概要	13
第一节 阴阳	14
一、阴症和阳症	15
二、阴厥和阳厥	16
三、真阴不足和真阳不足	18
四、亡阴和亡阳	18
五、阴阳生死辨	19
第二节 表里	20
一、表里的寒热虚实証	21
二、表里同病	22
三、半表半里証	23
四、表証入里和里証出表	23
第三节 寒热	24
一、寒証和热証	24
二、寒热的上下	25
三、寒热的真假	25
第四节 虚实	27

一、虛証和实証	28
二、气血的虚实	29
1. 气虚和血虚(29) 2. 气实和 血实(29)	
三、虚实的真假	30
小結	31
第二章 四診概要	32
第一节 望診	33
甲、望診的一般情况	34
一、望神色	34
二、望形态	38
乙、望診的分部观察	39
一、头面	39
1. 面部望診(39) 2. 目部望診 (41) 3. 鼻部的望診(42)	
4. 耳部的望診(42) 5. 口唇的 望診(43) 6. 牙齿的望診(43)	
7. 舌和苔的望診(43)	

二、四肢	58
1. 手足(58)	2. 掌腕(58)
3. 爪甲(58)	4. 魚际(58)
5. 小儿指纹(58)	
三、皮肤	59
1. 腫脹(59)	2. 发黃(60)
3. 出痘(60)	4. 麻疹(61)
5. 斑疹(62)	6. 爛喉痧痧(62)
7. 白痞(63)	
四、二便	63
1. 大便(63)	2. 小便(63)
小結	63
第二节 聞診	64
甲、声音	65
一、声音的一般情况	65
二、語言	67
三、呼吸	67
四、咳嗽	69
五、嘔吐	70
六、呃逆	70
七、噯气(噫)	71
八、噎欠	71
九、呻吟	71
乙、气味	72
一、伤寒与溫疫	72
二、痰与涕	72
三、口臭、汗臭、血腥臭	72
四、二便	72
五、月經与帶下	72

小結	73
第三节 問診	73
甲、問診綱要	74
一、注意工作时的环境	74
二、問籍貫、职业	74
三、問平日生活習慣	75
四、問精神环境	76
五、問起病、轉变及医 疗經過	77
六、問現在症狀	78
乙、脉案記錄	85
小結	90
第四节 切診	91
甲、脉診	91
一、診脉的意义	92
二、診脉的部位和配合 藏府	93
三、診脉的方法和要求	95
四、診脉的注意点	96
五、脉象的認識	100
六、脉与病的关系	107
小結	114
乙、触診	116
一、診尺肤	116
二、診肌表	117
三、診手足	118
四、診胸腹	119
小結	121

上篇 总 論

第一章 中医诊断学的重要意义

诊断学是研究診察病情判断疾病方法的一門學問。治疗任何疾病，必先正确地辨証，才能正确地論治。要能正确地辨証，則必須以診斷为依据。

中医诊断学的内容，主要是“四診”和“八綱”。所謂“四診”，就是“望聞問切”；用望診以觀察病人的神色形态，用聞診以听取病人的声音气息和嗅取病人身上与排泄物的气味，用問診以探知与疾病有关的情况，用切診以触知病人的脉象及身体某些部分的变化。所謂“八綱”，就是“阴阳、表里、寒热、虚实”；这是証候分类的大綱，也就是把通过“四診”所了解到的病情症狀，运用“八綱”进行分析归納，以知疾病的原因、病情的属性、病位的淺深、病机的进退，以及邪正的盛衰等等，从而进一步作出判断和处理。

由此可知，四診是了解症狀的具体方法，八綱是分析病情的理論指導。如果只凭四診了解病情，而沒有八綱来分析归納，便不可能从复杂的病变中，掌握主次，辨别真假。因此，清代程鍾齡曾說：“病有总要，寒热虚实表里阴阳八字而已。”而八綱之所以称綱，亦足体现其重要意义。四診与八綱，必須密切联系，而这种联系，也正是理論和实践的結合。我們在临証中，能正确地处理各种复杂的病变，是与这种诊断方法分不开的。

再从中医临証工作中“脉因証治”这一体系来看，更可理解診斷的重要性。因为“治”病之前，必先掌握其“脉因証”等情况；而“脉因証”等情况，是必須通过診斷来体现的。也就是說，必須运用四診、八綱的診斷方法，来了解和分析其“脉因証”，然后始可言“治”。由此可知，不通过診斷，便不可能真正地認識疾病，而使治疗上的立法用方、藥物配伍等等，都失去了依据。因此“汗吐下和

溫清補消”八法的运用，就是以八綱的歸納來確定的；而藥物的寒熱溫涼、升降浮沉、酸苦辛甘等不同的性味，更要通過八綱，才能正確運用。所以診斷是臨証工作的基礎。

診斷既是非常重要的，那末，怎樣才能正確地掌握和運用呢？我們認為要做好診斷工作，應該掌握幾個環節：首先是具備理論基礎。所謂理論，是指中醫的學術理論，也就是以陰陽五行、天人合一為基礎的一個獨特的理論體系，這是整個中醫學的理論指導，診斷學當然也不例外，如四診八綱、辨証論治、五臟六腑、十二經絡、奇經八脈、六經三焦、營衛氣血等等，無不貫串着這種精神。如果我們離開這種理論指導，單憑一些片斷的經驗或單純地從表現的症狀來治療疾病，那就只能頭痛醫頭，腳痛醫腳，而在錯綜複雜的病變面前，必然胸無主宰，動手便錯。因為沒有理論指導，便會迷失方向，無所適從。其次是聯繫實際。當我們明確了理論和方法以後，就必須進一步運用到實踐中去。從每一個病症中，深刻體驗，使書本的知識，成為自己的知識，使古人的經驗，成為自己的經驗。所以聯繫實際，也就是理論與實踐相結合的問題，只有理論和實踐相結合，才能真正地做好工作，並在實際鍛煉中，得到不斷地提高。第三是靈活運用。診斷雖有其一定的規矩准繩，但在臨証上必須靈活運用。因為不但疾病的本身會有很大的變化，而且由於客觀環境的影響，更會造成了複雜的情況。因此，我們既不能隨着書本而“按圖索驥”，又不能泥於成法而“刻舟求劍”。費伯雄說：“巧不離乎規矩，而實不泥乎規矩”。所以我們在实际工作過程中，必須隨機應變，靈活運用，做到病情千變，醫亦千變。前人有“標本緩急，輕重先後”以及“舍脈從症，舍症從脈”等說，都是靈活運用的很好例子。如果缺乏機動靈活，機械的處理疾病，必難得到良好的效果。

第二章 中医诊断学的基本精神

诊断学是中医学术的重要组成部分，它的基本精神，完全体现着中医的学术观念和方法。这就是说，中医在临证时对观察某一症候，或判断某一病情，必须根据客观的情况，作全面考虑，从各方面辨别证候，作出治疗的方针。这种基本精神，也就是所谓“整体观念”和“辨证论治”。

第一节 整体观念

祖国医学，通过长期的实践，积累了极其丰富的内容。整体观念，正是古人在实践中所体会到的一个重要的原则，因而成了后世中医理论的主要部分。从诊断的角度来讲，所谓整体观念，就是在临证之际，对于观察病情，辨别症状，判断问题，乃至对疾病的处理等，必须从整体出发。不管什么疾病，当进行诊断时，对四时气候的变化、人事环境的变迁、病人禀赋的强弱，以及表现于神气、色泽、声音、脉搏的异常等，都必须作全面的了解，而不是孤立地看“人”，孤立地看“病”，孤立地看“症”。所以诊断疾病，不但应该明确人体内部的整体统一性，更必须明确外界环境与人体之间的密切关系。因为人类不能离开自然界而生存，自然界的变化，不能不时刻影响着人体。在正常的状况下，人体常与外界的一切变化相适应，而发挥其正常的生理功能。如果遇到了剧烈的变化，或人体机能对外界环境不能相适应时，便会因内外失去平衡而发生病变。这说明致病的原因，与外界的环境是分不开的。除了四时六淫之外，即使是情志的病变，虽属内因，但触发的原因，未尝不是客观的环境所造成。再从人体本身来看，凡发生了病变，从一点可以影响到全面，或者病于内而表现于外，或病于外而影响及内，五脏六腑，气血表里，都可相互转移传变，所以前人尝说，人与天地相参、人身一小天地、十二藏之相使不得相失等等，也就是把一个人的活动与整个环境联系起来看，故诊断一个疾病，也必须以环境影响和本身变化联系起

來看。為了進一步闡發這種精神，再舉內經之文演繹如下：

素問疏五過論說：“聖人之治病也，必知天地陰陽、四時經紀，五臟六腑、雌雄表里，刺灸砭石、毒藥所主；從容人事，以明經道，貴賤貧富，各異品理，問年少長、勇怯之理；審于分部，知病本始，八正九候，診必副矣。”

這一節經文，具體地說明了診斷學的整体觀念精神。它明確地告訴我們，作為一個良醫，診治疾病，必須知道自然界陰陽四時的變化，對於疾病的發生與發展，有着密切的關係。如四時六淫之傷人，就是最明顯的事實。其次應注意臟府內外表里之間的相互影響，以及病之在臟在府在經在絡，以確定用刺、灸、砭石或藥物等不同的治療方法。再次是了解其人事情況，如生活環境、年齡性格等，它不但直接影響着病變，且對立方用藥、預後吉凶，亦有很大關係。如七情感傷、五志過竭，以及年齡的老少、性格的勇怯，在治法上都應有所分別。此外還須審察神色脈象，了解病情的始終本末，從而進行全面性的綜合分析。這樣的全面診斷才能正確的指導治療。故前人以診斷疾病所應掌握的“天時氣候、人事環境、臟府盛衰、神色脈象”，稱之為“四德”，這也說明了整体觀念在臨証上的重要意義。

素問脈要精微論說：“切脈動靜，而視精明，察五色，觀五臟有余不足，六腑強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。”

這是以另一種方式，來表達診斷的整体性精神。它告訴我們，診斷時必須診察脈息變動，觀察神色形態，辨別臟府表里的虛實強弱，互相參合，加以分析，然後才能知道病情的发展趨勢，從而測知其預後的吉凶。這也就說明了四診雖有望聞問切四種不同的方法，但決不能把它們孤立地運用。如果單凭一方面的了解，切了脈就不觀氣色，審察了表面不再去注意內部，都不足以掌握全面，更不可能辨別疑似，明察異同，而作出正確的診斷。

綜上所述，我們可以理解，診斷疾病，必須从整体出發。對任何病症的認識，只有从多方面來診察和研究，才是正確的方法，絕對不能把它機械地、孤立地或簡單化地對待，如果忽視了整体觀念這一精神，就會犯片面性的錯誤。

第二节 辨証論治

中医診斷的另一特点，就是“辨証論治”。

人体疾病的产生，既与周圍环境有密切关系，因此，任何疾病，都会随着环境的不断变化而表现出錯綜复杂的症狀。我們要正确地認識这些錯綜复杂的症狀，就必须运用“辨証論治”的方法，进行多方面的了解，从而掌握它的各种演变发展的規律，从不同的变化中，得出不同的概念；按不同的情况，施以不同的治法，这便是“辨証論治”的精神實質。內經素問玉版論要篇說：“黃帝曰：余聞揆度奇恒，所指不同，用之奈何？岐伯曰：揆度者，度病之淺深也；奇恒者，言奇病也。”这一段經文即包含了辨証論治的意义。所謂“度病之淺深”，也就是用診斷的方法，以了解疾病的情况；所謂“奇恒”，是說明疾病的复杂性，它既有一般的情况，又有特殊的变化，因此，必須加以細致的辨別。例如同一頭痛，有外感內傷之分；同一煩躁，有屬陰屬陽之別；同一熱病，有傷寒溫熱之異；同一厥逆，有寒熱真假之辨。如果不掌握辨証論治，不对疾病作反复的辨別，那么，便容易造成毫厘千里之錯。

运用辨証論治，不但可以辨別病情，以便进行正确的治疗，同时通过这个法則，又可以使我們掌握疾病的傳变和預后，及时作出預防措施，从而制止疾病的发展。例如金匱說：“見肝之病，知肝傳脾，当先实脾”，素問刺熱篇說：“心熱病者顏先赤，脾熱病者鼻先赤，肺熱病者右頰先赤，腎熱病者頤先赤。病虽未发，見赤色者刺之，名曰治未病”，这就說明很多疾病的发生和傳变，有其一般的規律，我們如能根据辨証的法則，掌握了它的发展趋势，就可以預为防范。对疾病的預后，也是这样，例如傷寒論說：“下利脉沉弦者下重也，脉大者为未止，脉微弱数者为欲自止；虽发热不死。”又說：“下利后脉絕，手足厥冷，辟时脉还，手足溫者，生。脉不还者，死。”通过辨証，掌握預后的好坏，处理时便可心中有数，这也是診斷工作中重要的环节。

总的來說，运用辨証論治的法則，能使变化多端的症狀，变为条理化，使錯綜复杂的病情，得到恰当的治疗，并能掌握傳变，預測

病机。但是辨証論治在具体运用中，还有各种不同的形式，茲举例簡述如下：

一、五藏六府

以藏府来分別証候的方法，是根据五藏六府的藏象和病能，进行分析归納，來說明藏府的寒热虛实，各有主要的病变和主要的症狀，作为辨証論治的依据。例如素問宣明五气篇說：“五气所病：心为噫，肺为咳，肝为語，脾为吞，腎为欠、为嚏，胃为气逆、为噦、为恐，大腸小腸为泄，下焦溢为水，膀胱不利为癃、不約为遺溺”，灵樞本神篇說：“肝藏血，血舍魂，肝气虛則恐，实則怒；脾藏营，营舍意，脾气虛則四肢不用、五藏不安，实則腹脹經洩不利……”等。五藏六府的病变，又能互相移易，如素問气厥論說，心移热于肺，傳为鬲消；膀胱移热于小腸，鬲腸不便，上为口糜。咳論篇說，五藏之久咳，乃移于六府，等等。这就是說明人体的藏府表里相关，并按照五行生剋变化的道理。自有一种規律可以作为依据。这种藏府分証的方法，普遍运用于一般疾病，而杂病尤多采用。

二、十二經絡与奇經八脉 (表 1、2、3)

經絡是藏府与軀表的通路，外在的病变可以通过經絡影响于所属的藏府，而各个藏府的病变亦必表現于所主經絡循行的部位。故以經絡为辨証的方法，根据疾病表現的部位，我們就可以了解病在何經何藏，再分別其属寒属热，有余不足，而予以适当的治疗。所以經絡学說，不但是針灸治疗的依据，同时也是一切疾病辨証論治的依据。灵樞經脉篇所論經脉的循行部位及病候，就是根据藏府經絡的病变作出的总结。例如：

“肺手太阴之脉，起于中焦，下絡大腸，还循胃口，上膈，属肺，从肺系横出腋下，下循臑內，行少阴、心主之前，下肘中，循臂內上骨下廉，入寸口，上魚，循魚际，出大指之端；其支者，从腕后直出次指內廉，出其端。是动則病肺脹滿膨膨而喘咳，缺盆中痛，甚則交两手而瞀，此为臂厥；是主肺所生病者，咳上气，喘渴，煩心胸滿，臑臂內前廉痛厥，掌中热。气盛有余則肩背痛，风寒，汗出中风，小便

数而欠；气虚则肩背痛寒，少气不足以息，溺色变”。这里面就把肺手太阴经所发生的一系列病变，进行了系统的归纳，当我们看到肺膨喘咳、缺盆中痛，或喘咳上气、肩背痛等症状，便知道这是病在手太阴肺经，而予以对症用药。所以根据经络辨证论治，对我们临证诊断，有着极大的方便。

至于十二经络与脏腑阴阳五行的关系、十二经络的病候及奇经八脉循行和病候，附表说明如下：

表 1 十二经络阴阳五行表里对照表

阴 阳 五行 藏府经络	阴（内、里）		阳（外、表）	
	藏	经 络	府	经 络
金	肺	手（内侧）太阴经	大肠	手（外侧）阳明经
水	肾	足（内侧）少阴经	膀胱	足（外侧）太阳经
木	肝	足（内侧）厥阴经	胆	足（外侧）少阳经
火	心	手（内侧）少阴经	小肠	手（外侧）太阳经
土	脾	足（内侧）太阴经	胃	足（外侧）阳明经
火	心包	手（内侧）厥阴经	三焦	手（外侧）少阳经

说明：心包是心的外围，它能代表心藏，所以在五行也属火。三焦遍布体腔之内，与其他藏府不同，其功能与心包阴阳表里相配，所以也属火。

表 2 十二經脈病候分類簡表

經 脈	全 身 症 狀	頭 部 症 狀	胸 部 症 狀	腹 部 症 狀	四 肢 症 狀	二 便	神 志	其 他
手太陰肺經	汗 出		缺盆中痛，肺脹滿，膨膨而喘咳，上氣，胸滿		肩，臑，臂內前廉痛，臑脈，掌中熱	小便數而欠，溺色變	煩	甚則交两手而蒼，少氣不足以息，渴，背脊痛
手少陰心經		噤干，目黃	心痛，脇痛		臑，掌中熱痛			渴而欲飲
手厥陰心包絡經		面赤，目黃	胸脇支滿，心中憊憊大動，心痛		掌中熱		喜笑不休，煩心	
手太陽小腸經		眩痛，耳聾，頸項痛，不可忍，頸項痛，不可忍，耳聾，耳痛，耳后痛，耳痛，耳后痛			肩似拔，臑似折，肩，臑，臂外后廉痛，小指次指不用			
手少陽三焦經	汗 出	目黃，口干，軀軀，舌本強，痛，食則不化，耳鳴，食不下			肩前痛，大指次指不用			氣有余則當脈所過者熱腫，虛則寒慄不復
手陽明大腸經		黃疸，身體皆重，不能動搖，不能強立	腹脹		股膝內腫，臑，足大趾不用	溺澀泄，水閉	煩心	飢不欲食
足太陰脾經		黃疸，身體皆重，不能動搖，不能強立	心下急痛，胃脘痛		有股內后廉痛，足下熱而痛，痿厥		心惕惕如人將捕之，氣不足則喜恐，煩心	
足少陰腎經		面如赭，口熱，舌干，目眩，腰膝痛，見，咽腫，乾干痛	心如火，若虛狀，心痛，喝喝而喘，坐而欲起，上氣，咳，唾則有血		丈夫遺精，婦人少腹腫			
足厥陰肝經	腰痛，不可以俛仰	噤干，面生脫色	胸滿嘔逆		臑如結，臑如裂小趾不用	遺精，遺溺，閉澀	狂，煩	痛，項，背，腰，尻，臑，臑，脚皆痛
足太陽膀胱經	脊痛，腰似折，髀不可以曲	頭痛，目黃，目赤，目眩，目似脫，項似拔，頸項痛	心痛，胸脇痛，脇刀俠臑，缺盆中腫痛，善太息，脇下腫		膝腠外至臑絕骨外，臑前及膝節皆痛，小趾次趾不用			
足少陽胆經	不能轉側，汗出	頭痛，目銳眦痛，口苦	心欲動，脅、乳痛		膝腠外至臑絕骨外，臑前及膝節皆痛，小趾次趾不用			
足陽明胃經	酒洒振寒，溫溫汗出，氣盛則身以前熱，不足則身以前寒	面黑，目黃，口喎，唇腫，唇乾，喉痺		胃中寒則腹脹滿	膝腠外至臑絕骨外，臑前及膝節皆痛，小趾次趾不用	溺色黃	病至則惡人與火，聞水聲則惕然而驚，上高而歌，棄衣而走，狂，獨閉戶塞牖而處	其有余于胃，則消谷善飢，癰

表 3 奇經八脉循行及病候表

經 脉	起 止	病 候
任 脉	起于中極之下，以上毛際，循臍里，上关元，至咽喉，上頤、循面入目。	男子內結七疝，女子帶下瘕聚。
冲 脉	起于气冲，至少阴之經，俠臍上行，至胸中而散。	逆气里急
督 脉	起于少腹以下骨中央，女子入系廷孔，其孔，溺孔之端口。其絡循阴器，合篡間，繞篡后，別繞臀至少阴与巨阳中絡者合少阴上股內后廉，貫脊属腎。与太陽起于目內眥，上額交頤，上入絡腦，还出別下項循肩髃內，俠脊抵腰中，入循臂，絡腎。其男子循莖，下至篡，与女子等。其少腹直上者，貫臍中央，上貫心，入喉上頤，环唇，上系两目之下中央。	为病脊强反折。生病从少腹上冲心而痛，不得前后为冲疝，其女子不孕，瘕痔遺溺眩干。
帶 脉	橫絡于腰間，足少阳之正，主腦中，別走太陽而合，上至腎，当十四椎，出属帶脉，連于足少阴太陽。	腰痛不可以俯仰，仰則恐仆。
阳 蹻	起于跟中循外踝上行入风池与阴蹻回还而濡潤于目，足太陽之別。	阳气盛則瞋目，苦腰背痛。
阴 蹻	少阴之別，起于然骨之后，上內踝之上，直上循阴股，入阴，上循胸里，入缺盆，上出人迎之前，入頤，属目內眥，至咽喉交貫冲脉。	阴气盛則瞋目，气不荣，則目不合。苦頸痛，少腹痛，里急，阴中痛。
阳 維	足太陽外踝，循膝外廉，上髀关，抵少腹。側循肋肋，斜上肘，会手足太陽之蹻于臑俞，上循耳，会督脉于风府，上腦空，下至风池。	苦寒热，腰痛不可以咳，咳則筋縮急。肌肉痺痒，皮膚痛，下部不仁，汗出而寒，或顛仆如羊鳴。
阴 維	足少阴內踝，循股內廉，上行入少腹，会足三阴，上臍里，循肋，会足厥阴于期門，上胸脇挾咽，与任脉会于頤。	苦心痛，动若癲，僵仆羊鳴，失音，肌肉痺痒，汗出惡风，胸中痛，脇下支滿，男子两肋下实，女子阴中痛，如有瘡狀。

三、六 經 (表 4)

六經是太陽、少阳、阳明、太阴、少阴、厥阴的总称，是就外感病的整个发展过程所出現的各种症狀，按照病情輕重、邪正消長等情況，进行分析归納，定出的六个分証类型，用以說明疾病傳变的一般順序和相互之間的关系，以便于臨診时的辨証論治。

凡外感病变，大多由表入里，从实轉虛。六經証候中的三阳

証，即表示病之属表，是邪气方張的現象，所表現的症狀大多为实証、热証；三阴症，則是正气已衰，属里，所表現的症狀大多为虛証、寒証。这种六經分証，对疾病的表里内外、寒热虚实和预后好坏，都分辨得非常明确。根据六經辨証，我們就能更好地掌握各个阶段的病情，及其发展演变的发展趋势，而作出正确的診斷与治疗。

表 4 六經辨証簡表

辨証 分經	寒 热	头身胸腹四肢	口 渴	二 便	神志	舌苔	脉象
太 阳	发热惡寒	头項强痛，身疼腰痛	不 渴			薄白	浮
阳 明	发热不惡寒	身热汗出	口渴引飲	大便秘結	心煩，譫妄或昏糊	舌赤苔黃	大或滑或沉实
少 阳	寒热往来	目眩耳聾，胸胁苦滿，喜嘔	口苦咽干		心煩	白	浮弦或細弦
太 阴	身无热	手足溫，腹滿而吐，食不下	口不渴	自 利		淡黃而潤或黑潤	緩而弱
少 阴	惡 寒	身踴，四肢逆冷	口中和或咽干口燥	下利清谷	但欲寐	舌厚或舌潤或舌圓	微細或細數
厥 阴	厥熱交錯	气上冲胸，心中疼热，飢而不欲食，有时吐衄	消 渴	厥利，厥止則利亦止，或便膿血	煩躁		微或促或細或數

四、三 焦 (表 5)

三焦即上焦、中焦、下焦之总称，是分別証候的又一种方法。前人根据疾病发生和发展的一般規律，將人体軀干划分为上、中、下三区，而定名为“三焦”。上焦概括胸中，所以胸中之病責之上焦；中焦概括脘腹，所以脘腹之病，責之中焦；下焦概括小腹与二阴，所以小腹部及二便之病責之下焦。同时三焦又代表着疾病的发展过程和病情的輕重。如外感初起，大多始于上焦，病輕而淺；漸次发展，入于中焦，就比較严重；再繼續发展，由邪盛而致正伤，由实証轉为虛証，这时病入下焦，病情也就更加严重了。这种以三焦分証的方法，与六經的意义和作用相同，不过，六經是从外至內，三焦是由上而下，虽縱橫不同，而辨証的目的則并无二致。在临証中，三焦多用于杂病，对于溫病的辨証，应用尤多。

表 5 溫病三焦辨証簡表

辨証 分部	經 絡	主 証	主 脉
上 焦	手太陰(肺)	发热惡寒, 自汗头痛而咳。	
	手厥陰(心包)	舌質紅絳, 神昏譫語或舌蹇肢厥。	
中 焦	足陽明(胃)	发热不惡寒, 汗出口渴, 脉大。	
	足太陰(脾)	身熱不揚, 体痛且重, 胸悶嘔吐, 苔膩脉緩。	
下 焦	足少陰(腎)	身熱面赤, 手足心熱, 心躁不寐, 唇裂舌燥。	
	足厥陰(肝)	熱深厥深, 心中懊憹, 手足蠕動, 甚則瘵癰。	

五、營 衛 氣 血 (表 6)

營衛氣血之說, 導源于內經, 而隨着后世傷寒、溫病學說的發展, 得到更多的闡發, 因而在診斷上, 也以此作為區別疾病淺深輕重的一種分証方法。如疾病初起, 病勢輕淺, 多屬衛分, 如果不及時治療或治療不當, 便可入于氣分, 再次則傳入營分, 最後則傳入血分。衛分、氣分, 病勢為輕; 營分、血分, 病勢為重。衛、氣、營、血, 各有不同的症狀, 其歸納的方法, 與六經、三焦異曲同工, 其運用則尤以溫病為多。

表 6 溫病營衛氣血辨証簡表

辨証 分類	症 狀	舌 苔	脉 象
衛	发热, 微惡寒或不惡寒, 无汗或少有汗, 头痛身疼, 鼻塞, 声音重濁, 咳嗽微渴。	薄 白	浮
氣	不惡寒, 反惡熱, 口渴, 小便黃赤, 汗出, 气粗。或潮熱譫語, 腹滿且痛, 大便閉結; 亦有自利灼肛熱結旁流。	由白轉黃 或黃糙	洪大或數 實或沉實
營	神昏煩躁, 夜寐不安, 譫語, 反不渴; 甚則舌蹇肢厥。	舌絳而干	數或寸脉 大
血	神昏譫語, 瘵癰抽搐, 外有斑疹透露, 內有吐血, 衄血, 便血。	舌深絳少 苔	脉气虛弱 或細數或 弦數

以上所介紹的辨證方式，是辨證論治中的几个不同的綱領，各有各的特点，我們如能掌握了這些方式，就可以進行正確的診斷，來更好地指導治療。

但是辨證論治的運用，應該有其切實的根據，這就是必須以四診來了解症狀，用八綱來分析歸納，從而得出病情在陰陽、表里、寒熱、虛實諸方面究竟誰屬的結論。無論那一種辨證方式，都不能離開四診八綱這個最基本的診斷法則，否則，就無法達到辨證論治的目的。

在臨証工作中，辨證論治必須與整體觀念相緊密結合。只有把整體觀念貫串在整個辨證論治的工作中，我們才能全面地認識疾病，對錯綜複雜的病情進行正確的分析和判斷，從而作出恰當的處理。因此說整體觀念與辨證論治，是中醫診斷學的基本精神。

下篇 各 論

第一章 八 綱 概 要

八綱——阴阳、表里、寒热、虚实，是中医学术的理論体系之一，是研究疾病、处理疾病的方法和工具。在整个中医学术中，如病因、証候、診斷、治法等等，都运用到它。而且也凭借了它，把全部中医学术的各个环节，構成一个整体。研究中医学术，如果不能掌握这些理論，就无法把整个中医学术精神融会貫通，临症工作就沒有理論指导，因此也就不能分析綜合，不能掌握其发展規律，結果就难免“头痛医头，脚痛医脚”。今天我們在“系統学习，全面掌握，整理提高”的号召下，更應該深入地钻研这些祖国医学的理論体系，使它的作用得充分的发挥。

至于我們在这里所討論的八綱，主要是从診斷的角度出发，用以对复杂的病情进行分析归納，并根据它作出判断。

一个疾病往往出現多种不同的症狀，如头痛、发热、身疼、腹痛、吐利等等，再加以體質有强弱，邪正有盛衰，以及內因、外因等各方面的影响，因此，同是一个疾病，其所出現的症狀，却不一定完全相同，何况这些不同的症狀，又是在不断地变化的。所以，我們对待这許多錯綜复杂的病証，如果沒有提綱来賅括，就会感到茫无头緒，无从措手。至于如何才能找到疾病的关键，掌握其要領，使得虽是很为复杂的現象，能够达到条理化，并从这个条理化的基础上，看到整个病情的发展趋势，从而指导整体的統一疗法，那么，运用八綱，就是一个最好的方法。事实也是如此，任何一个疾病，都离不开八綱的范围。因为疾病的性質，不属于阴，就属于阳；病变的部位，不属于表，就属于里；症狀的表現，不属于热，就属于寒；邪正的盛衰，不属于实，就属于虛。因此，病变多端，大致不出八綱的范围。

但是，这仅是对八綱的一个大概的認識，至于八綱之間，还有其相互的联系。如表里与寒热、虛实的联系，寒热与表里、虛实的联系，虛实与表里、寒热的联系，以及阳中有阴、阴中有阳，由表入里、由里出表，寒热錯杂，虛实并見等等。因此，我們的認識，必須随着病情变动的具体反映，了解它的規律，而灵活运用，所以八綱之間又是相互关联随时发展的。

这里还須說明，八綱中的阴阳两綱，是綱領中的綱領，其他六綱，都是从阴阳演繹而来，阴阳两綱，又可以赅括表里、寒热、虛实。所以，綱虽分八，并不能并列看待，其中实含有一个統属的关系。

总之八綱的运用，并不是孤立的，而是相互联系的，它是依据邪正斗争的全面情况，給以一个有一定准則的概念，来表达病情的整个趋向，同时亦表达出医生的一个診斷結論，这是前人在長期實踐中總結出来的理論經驗，这里面积累了很多知識，我們應該很好地学习，并熟練运用，进一步的加以整理发揚。这里为了熟习八綱的具体运用起見，再分別予以討論。

第一节 阴 阳

阴阳是一个对待的名詞，是观察和分析事物对立統一的变化的总綱，在祖国医学中应用非常广泛。在診斷方面，就以阴阳为八綱之首，而赅括表里、寒热、虛实。如表、热、实可属于阳的范围，里、虛、寒可属于阴的范围。因此，阴阳便成为分析和辨别証候类型的綱領。中医典籍和历代医家对此都非常重視，如內經說：“善診者察色按脉，先別阴阳。”从“先別”两字来看，便可見阴阳在診斷上的重要性了。伤寒論中也說：“病有发热惡寒者发于阳也，无热惡寒者发于阴也。”張仲景就从发热惡寒、无热惡寒的两个不同証候上辨别出病发于阳、病发于阴的两大类型，而作为伤寒論的全篇大綱。以后張景岳更特別指出：“凡診病施治，必須先审阴阳，乃为医道之綱領。阴阳无謬，治焉有差。医道虽繁，可以一言以蔽之，曰‘阴阳而已’。”在临床上把千变万化、錯綜复杂的病情，分为阴阳两大綱領，在处理时可以提綱挈領，执簡馭繁。前人所說“知其要者，一言而終；不知其要，流散无穷”，就是这个意思。

现就阴阳两綱在診斷上的具体运用举例如下：

一、阴症和阳症(表7)

难經五十一难說：“病欲得寒，而欲見人者，病在府也；病欲得溫，而不欲得見人者，病在藏也。何以言之？府者阳也，阳病欲得寒而見人；藏者阴也，阴病欲得溫，又欲閉戶独处，惡聞人声，故以別知藏府之病也。”这是以阴阳来辨藏府之病的，同时藏府又含有表里的意思。

李士材說：“身輕足煖，开目喜見人，皮肤潤澤，煩而多言属阳症；惡寒，好向壁臥，閉目惡明，懶見人，靜而少言，属阴症。”这是以阴阳来辨病人的精神状态的。

严則菴說：“阴症二便清白，不煩不渴，脉沉微；阳症身热，体痛咽干，脉急洪長。”这是以二便、脉象等辨别阴阳。

張景岳說：“以証而言，則表为阳，里为阴；热为阳，寒为阴；上为阳，下为阴；气为阳，血为阴；多言者为阳，无声者为阴；喜明者为阳，欲暗者为阴；阳微者不能呼，阴微者不能吸；阳病者不能俯，阴病者不能仰。以脉而言，則浮、大、滑、数之类皆阳也，沉、微、細、澀之类皆阴也。”这是較广泛地从病症的各方面来辨别阴阳。

表7 阴証阳証鑑別表

四診 阴阳	望 診	聞 診	問 診	切 診
阴	好向壁臥，閉目惡明，不欲見人，身寒肢冷，神靜无声	少言，呼吸微	欲得溫，不渴，二便清白	脉沉或迟，身寒，膚枯澀，足冷
阳	好向外臥，开目望明，喜見人，身仰肢撒，身輕，神煩	多言，呼吸粗	欲得寒，口渴，引飲，便秘澀赤	脉浮或数，身热，膚潤澤，足煖

中医診斷主要是綜合全面的症狀，反复觀察，并进行分析归納，辨識証候的属阴属阳，从而了解阴阳的偏胜或偏衰。如阳偏胜，則属阳証；阴偏胜，則属阴証。此外还有阴衰而致阳盛、阳衰而致阴盛、或阴阳俱虛的現象。掌握了这些关键問題，对于辨証論治

就能起到一定的指导作用。

二、阴厥和阳厥

四肢凉而不温，名为“厥逆”。但厥逆之中，还有寒热之分。如内藏虚寒，阳气不能布达于四肢，因而逆冷的为“阴厥”，治宜温中回阳；如内藏温热，阳气郁而不伸，四肢反逆冷的为“阳厥”，治宜急下存阴，或宣通郁阳。如或相反，危险立至，必须细心体认，才可免于胎误。

李士材说：“阴厥之症，初得病时，无身热头疼，而面寒肌冷，引衣踰臥，脉沉而弱，指头常冷；轻则理中汤，重则四逆汤。阳厥之症，初得病时，身热头疼。以后传入三阴，大便闭，小便赤，谵语烦乱，脉沉而滑，指头常温。热微厥亦微，宜四逆散；热深厥亦深，宜承气汤（按：府气未实者，可用白虎汤）。”这就是阴厥和阳厥的一般鉴别。

吴又可对于阳厥的论述，很值得参考。他说：“阴症世间罕有，（注：这是他仅就瘟疫而言的。）方书阴阳二症，皆对待言之，读者以为均有之症，临床未免狐疑。盖伤寒瘟疫，传入胃家，阳气内郁，即便四逆，所谓阳厥也。又曰‘厥微热亦微，厥深热亦深’，其厥深者，甚至冷过肘膝，脉沉而微，剧则通身冰冷，脉微欲绝。以上脉证，悉见纯阴，犹以为阳证何也？盖审内证，气喷如火，齕烂口臭，烦渴谵语，口燥舌干，舌苔黄黑，或生芒刺，心腹痞满，小腹疼痛，小溲赤澀，涓滴作痛，非大便燥结，即大便胶闭，非协热下利，即热结旁流，三焦悉是阳症，所以为阳厥也，粗工不察内多下证，但见表证脉体纯阴，误服温剂，祸不旋踵。”

吴鞠通对于阳厥也说：“须细辨其系火极似水、热极而厥之证……全在目赤、小便赤、腹满坚、喜凉饮定之。”

一般来讲，阴厥比较容易认，因有一派阴寒现象；而阳厥比较难认，症状错综，内外相掩，往往疑惑。所以援引吴又可、吴鞠通之言，以便进一步的理解。兹再摘录吴又可医案一则如下：

“阳症阴脉身冷如冰为体厥 施幼声，卖卜颇行，年四旬，禀赋肥甚。六月患时疫，口燥舌干，胎刺如锋，不时太息，咽喉肿痛，心

腹脹滿，按之痛甚，渴思冰水，日晡益甚，小便赤澀，得涓滴則痛甚；此下証悉備，但通身肌表如冰，指甲青黑，六脈如絲，尋之則有，稍按則無。医者不究里証熱極，但引陶氏全生集，以為陰症：但手足厥冷，若冷過于肘膝，便是陰症。今已通身冰冷，比之冷過肘膝更甚，疑其為陰証一也；且陶氏以脈分陰陽二証，全在有力、無力中分，今已脈微若絕，按之如無，比之無力更甚，疑其為陰証二也；陰証而得陰脈之至，有何說焉，以內諸陽証竟置不問，遂定附子理中湯。未服，延子至，以脈相參，表里互較，此陽証之最者，下証悉具，但嫌下之晚耳。蓋因內熱之極，氣道雍閉，乃至脈微欲絕，此脈厥也。陽郁則四肢厥逆，況素稟肥盛，尤易雍閉，今亢陽已極，以至通身冰冷，此體厥也，六脈如無者，群龍無首之象，証亦危矣，急投大承氣湯，囑其緩緩下之，脈至厥回，便得生矣。其妻聞一曰陰証，一曰陽証，天地懸隔，疑而不服。更請一醫，指言陰毒，須灸丹田；其兄迭延三醫續至，皆言陰証，妻乃惶惑。病者自言，何不卜之神明，遂卜得從陰則吉、從陽則凶，更惑于醫之議。陰証者居多，仍進附子湯，下咽如火，煩躁頓加，乃嘆曰：吾已矣，藥之所誤也。言未已，更加踴躍，逾時乃卒。嗟乎，向以卜謀生，終以卜謀死，誤人還自誤，可為卜巫之鑒。”

按 寒厥用四逆湯，熱厥用白虎湯或四逆散，凡研究傷寒論的都能知道；至于怎樣來辨別的，其關鍵何在，則大有研究的价值。一般來講，陰厥比較易認，因有一派陰寒現象；陽厥比較難識，因其症狀複雜，內外相掩，往往使人疑惑。如若辨別不清，危險立至，所以以上介紹了三家的論述，幫助我們分析鑑別。李士材說明了陰厥陽厥的辨証關鍵，在于傳經和直中方面的區別，同時說明陰厥和陽厥都有輕重的分別。在這方面前賢成無己、喻嘉言都有精湛的辨証經驗。成無己說：“凡厥若始得之，手足便厥而不溫者，是陰經受邪，陽氣不足，可用四逆湯；若手足由熱而溫，從四逆而至厥者，傳經之邪也，四逆散主之。”喻嘉言說：“凡傷寒病初得發熱，煎熬津液，鼻干口渴便秘漸至發厥者，不問而知為熱厥也。若陽証忽變陰厥者，萬中无一；蓋陰厥得之陰証，一起便直中陰經，唇青面白，遍體冷汗，便利不渴，身倦多睡，醒則人事了了，與傷寒傳經之熱邪轉入轉深人事昏惑者，萬萬不同。”如此對陰厥和陽厥的辨別，則更為明晰。至若吳又可、吳鞠通都是以着重里症為主的，這些辨証經驗，都可作為臨床參考。

三、真阴不足和真阳不足

真阴不足和真阳不足，关系到病人的体质问题，人的秉赋如有不足，真阴真阳也就因之减弱。如果在真阴不足和真阳不足上辨别清楚，则肾家水火两病，就能得其要领。关于这一方面，在医学心悟上叙述得比较扼要：

真阴不足 脉数无力，虚火时炎，口燥舌焦，内热便秘，气逆上冲。（按：脉数无力是真阴不足的主证，所有热象，都是阴虚阳旺所致。）

真阳不足 脉大无力，四肢倦怠，唇淡口和，肌冷便溏，饮食不化。（按：脉大无力是真阳不足的主证，便溏饮食不化，是火不腐谷。）

此外，沈氏尊生书更指出了诊治的要点：

“阳虚阴虚皆属肾。阳虚者，肾中真阳虚也，真阳即真火也。审是火虚，右尺必弱，只宜大补元阳，亦不可伤阴气。忌凉润，恐助阴邪也。尤忌辛散，恐伤阴气也。惟喜甘温益火之品，补阳以配阴，宜附桂八味丸。沉阴自斂，阴从乎阳矣，所谓‘益火之源，以消阴翳’也。”

“阴虚者，肾中真阴虚也，真阴即肾水。审是水虚，脉必细数，只宜大补真阴，亦不可伐阳气。忌辛燥，恐助阳邪也。尤忌苦寒，恐伐元阳也。惟喜纯甘壮水之剂，补阴以配阳，宜六味丸加枸杞鱼鳔，虚火自降，而阳归于阴矣，所谓‘壮水之主，以制阳光’也。”

四、亡阴和亡阳

亡阴亡阳都是急剧变化，是一个危险的证候，一般在高热薰蒸、发汗过多或吐瀉过度、失血过多的情况下出现。特别是因汗出过多而引起的亡阴亡阳，临床上尤须注意。因为汗出过多，容易消耗阴液，亦易散越阳气；同时亡阴汗出过多，六气散越，每易亡阳，其中机转，即在顷刻。至其治法，则大不相同，必须辨别清楚。亡阴之药一般宜凉，亡阳之药一般宜热，一凉一热，不容差误。至于辨别的方法，徐灵胎论得很详，爰引其说明供参考。

徐灵胎亡阴亡阳論：

“經云：夺血者无汗，夺汗者无血。血属阴，是汗多乃亡阴也，故止汗之法必用凉心斂肺之药。何也？心主血，汗为心之液，故当清心火；汗必从皮毛出，肺主皮毛，故又当斂肺气，此正治也。惟汗出太甚，则阴气上竭，而肾中龙雷之火，随水而上，若以寒凉折之，其火愈熾。惟用大剂参附，佐以咸降之品，如童便牡蛎之类，冷饮一碗，直达下焦，引其真阳下降，则龙雷之火，反乎其位，而汗随止，此与亡阴之汗，真大相悬绝。亡阴亡阳，其治法截然，而转机在顷刻。当阳气之未动也，以阴药止汗；及阳气之既动也，以阳药止汗。而龙骨、牡蛎、黄耆、五味收涩之药，则两方皆可随宜用之。医者能于亡阴亡阳之交，分其界限，则用药无误矣。

“其亡阴亡阳之辨法何如？亡阴之汗，身畏热，手足温，肌热，汗亦热，而味咸，口渴喜凉饮，气粗，脉洪实，此其验也；亡阳之汗，身反恶寒，手足冷，肌凉汗冷，而味淡微粘，口不渴，而喜热饮，气微，脉浮数而空，此其验也。至于寻常之正汗、热汗、邪汗、自汗，又不在二者之列。”

总之，阳未亡以凉药止汗，阳已亡以热药止汗，此中关键，必须掌握。王孟英所谓热渴汗泄而脉虚者，宜甘药以养肺胃之津，汪切菴谓若大汗脉虚，身凉不热，口润不渴，则为亡阳脱证，非参附回阳不能挽救，亦属扼要之语，学者宜多留意。

五、阴阳死生辨

阴阳是相对存在的，而且是在相对的基础上相互依存、相互制约的，所以前人說：“阳生阴长”“阴阳互根”就是这个道理。如果一旦有阳无阴，或者是有阴无阳，势必“独阳不生”“孤阴不长”，造成“阴阳离决，精气乃绝”的后果。因此观察阴阳的盈虚消长，对于辨别生死的机宜，是有着重要的意义的。在临床上，尤其是对诊断虚寒证预后的良否，有阳无阳，实为重要关键；诊察温热证的预后，以有阴无阴，为决死生的重点。关于这方面的讨论，在伤寒论和温热诸书中，都有具体的叙述，这里不拟多赘。但总的说来，所谓辨别阴阳死生，在阴证方面，是候阳气的存亡，阳气尚存，病主可生，阳

气已亡，病当主死。如伤寒論少阴病諸条，症狀就比較显見突出，它是从四肢的溫与不溫、身之热与不热以及煩躁、脉象等各方面来加以判断的，这种辨証方法應該加以注意。至于热病方面是注意于有阴无阴，亦为重要关键。盖热病末有不耗阴液者，其耗之未尽，則生，尽則阳气无所依附，势必外脱而死。

以上所举的阴証和阳証、阴厥和阳厥、真阴不足和真阳不足、亡阴和亡阳、阴阳死生辨等五点，是通常运用阴阳于診斷上的大概情况，但这仅是举例而已，不能認為阴阳就只有这些道理。反复討論，引伸演繹，除以上所論以外，結合其余六綱，尙有待于作进一步的钻研。

第二节 表 里

表里二字，对人体是指内外而言，如皮毛經絡为表，五藏六府为里。在診斷上主要表示病变部位，借以测出病候的淺深。凡六淫之邪伤人，首先侵犯皮毛經絡，当藏府尙无显著变化的时候，如出現惡寒发热、头痛身痛等証，皆可称为表証。及至病邪內傳，侵及藏府，所发生症狀如壯热神昏、煩躁口渴、胸痞嘔吐、腹痛下利或二便閉塞者，皆可称为里証。又凡病自內生，或因七情，或因劳倦，或因飲食所伤，或因酒色所困，內藏首先发生病变，亦称里証。如病既不在表，又不在里，則称半表半里。这是前人在临床實踐中，观察到的規律。許多症狀的表現，或偏于外部，或偏于內部，或偏于上下，因此在証候的認識上，就把它划分为九个区域，如表、里、半表半里等。至如伤寒的六經、溫病的卫气营血，其意义莫不如此，这样的区分既便于辨証，又便于論治。

辨别表里，可以了解病势的輕重。一般說来，病在表者輕淺，其治較易，病在里者深重，其治較难。而更重要的是审察它的傳变趋势，以知病情的順逆，为临床上一大关键。因为任何一个疾病，总有它的发展趋势，有由表入里的，也有由里出表的。內属里，外属表，其病邪由內向外，即是由里出表，为疾病向愈的現象，其証为順；其趋势由外向內的，即是由表入里，为病进之征，其証为逆。辨析了表里，就可以掌握疾病的傳变規律，同时亦認識了病情的順

逆。假如表里辨別不清，必將影响到治疗的效果，特別在伤寒、溫病方面，如果誤表作里，或誤里作表，每易造成坏病。

此外，表里二綱，还必須和寒熱虛實联系起来。因为表証和里証，都有寒熱虛實的不同，并且还有表里俱寒、表里俱熱以及表熱里寒、表寒里熱等等的分別，都要我們密切注意，所以表里的辨別实屬相当重要。茲举其大要如下：

一、表里的寒熱虛實証（表8）

表寒 如发热头痛、惡寒无汗、項强腰痛、骨节煩疼、脉浮紧、舌苔薄白等証。

表熱 如发热惡风、有汗或无汗、口或渴、脉浮数、苔白舌尖紅等証。

表虛 如自汗、漏汗不止，或汗出惡风、脉弱无力、舌質淡等証。

表实 如发热无汗、身痛、脉浮有力等証。

里寒 如脉沉迟、舌苔白滑、不渴、肢冷、惡寒喜熱、噁心嘔吐、便溏腹痛等証。

里熱 如汗出不惡寒，反惡熱、口渴引飲，脉洪大有力等証。

表 8 表里的寒熱虛實証簡表

証候 表里	症 狀	脉 象	舌 苔
表 寒	头痛身疼，惡寒发热无汗	浮 紧	薄 白
表 熱	惡风身熱，或有汗或无汗	浮 数	舌边尖紅
表 虛	汗出(包括盜汗、自汗、漏汗等)惡风	浮弱或无力	舌 質 淡
表 实	无汗身痛	浮数有力	舌 質 紅
里 寒	畏寒，口和不渴，噁心嘔吐，腹痛泄瀉，肢冷	迟	舌青苔白
里 熱	发热，口渴少津，目赤唇赤，煩热扰乱	数 实	舌赤苔黃
里 虛	气弱，懶言，肢冷，大便自利，心跳头昏疲倦	弱	舌 胖 嫩， 苔 淡 白
里 实	气粗譫語，手足出汗，大便实，腹滿，心煩发狂	实	舌 堅 老 色 紫，苔黃腐

里虛 如便尿失禁、肛門脫出、泄瀉遺精，或氣弱懶言、食減倦怠、四肢冷、心跳、頭昏、舌胖嫩、苔淡白、脈沉弱等証。

里實 如手足出汗、發熱、不大便、腹脹滿、心煩、矢氣頻轉、脈沉實、苔黃燥、甚則譫語發狂等証。

二、表里同病

一個病既有表証，又有里証，就是表里同病。例如惡寒發熱頭痛等証與腹痛胸痞下利并見在临床上，就是經常可以見到的。表里同病同樣地要和寒熱虛實聯繫起來，更須注意它的“同氣”與“異氣”的差異。所謂同氣，是指熱則表里俱熱，寒則表里俱寒。所謂異氣，是指或表寒里熱，或表熱里寒。試分別舉例說明如下：

表寒里熱 是表寒未解，里熱已作；或里本有熱，表分又受寒邪。或無汗而煩躁，或有汗而喘促；或表寒少而里熱多，或表寒多而里熱少。

表熱里寒 如其人素屬中冷而新感風熱，或其人內傷生冷而外感風熱之類。

表虛里實 如新傷食滯、素昔表虛，或素有痰積、表氣不固，均系表虛里實。

表實里虛 如氣虛而感冒寒邪，或陰虛而感受風溫，或虽有太陽表証而尺中脈遲，均系表實里虛。

表里俱寒 如太陽表寒未解而里寒又作，或少陰里寒內起，而表寒外束，此為表里俱寒。

表里俱熱 如外有表熱，喘汗脈促，內有里熱，下利，或氣血兩燔，此為表里俱熱。

表里俱虛 如氣血兩虧或陰陽兩虛之証。

表里俱實 如外感寒邪未解，而里分或有積水，或有停痰，或有宿食，或有積熱，表實而里亦實，系表里俱實。

以上所舉例子，是說明表里同病的大致情況，從而也就可以知道，表里証有這樣錯綜複雜的變化。一般而論，表里同病，當分別其表里同氣與表里異氣。如表里同氣的，應重其里。同寒者，不溫其里，則虽用辛溫解肌，亦無作汗的機能；同熱者，不清其里，則恐

內外合邪，造成燎原之局。若表里異氣，應重其表，所謂先攻其異。若先攻里，非但表邪未解，更恐里邪未去，而表邪乘機陷入。這是臨床處理的大體情況。其次，表里同病，當標本同治。惟其標本同病，故臨床時，必須觀察疾病新久，權衡先後，掌握輕重緩急以施治，這是應該加以注意的。

三、半表半里証

凡病邪在表的，多見頭痛發熱、脈緊無汗等表証；病邪在里的，多見壯熱煩躁、腹滿便結等里証。如果病邪既不完全在表，又未完全入里，而在表里之間，則為半表半里証。其主要症狀為寒熱往來、胸脅苦滿、心煩喜嘔、噯噯不欲飲食，以及口苦、咽干、目眩、苔白邊紅、脈象弦細等等。在臨証處理上，表症宜汗，里症宜下，半表半里宜予和解。這是辨証施治的常規大法。

四、表証入里和里証出表

臨床上辨別表里出入，就是診察疾病的向內向外的發展趨勢。前面已經說過，病有從外到內的，也有從內到外的。內屬里，外屬表；從外到內，即是由表入里，病為重為逆。從內到外即是由里出表，病為輕為順。我們知道了這個關係，能掌握病勢的趨向，怎樣傳，怎樣變，就能心中有數，處理裕如了。茲舉例說明如下：

表証入里 凡病表証而小便清利的，可知邪未傳里。若見嘔噦口苦，或心胸滿悶，不食，是表邪傳至胸中而漸入于里了。若見煩躁不眠、干渴譫語或腹痛自利等症，更是邪入于里的症狀。

里証出表 由煩躁、咳逆、膈悶而發熱汗出，或見痧痘，或出癰疹，是為由里達表的症狀。

關於表里的討論，我們初步提出了以上四個方面，並分別地介紹了它們的病情變化和診斷方法。這裡還須提示的，就是不論表証或里証，其所表現的症狀都不會是很單純的，它每每具有複雜的征象，因為感邪的程度不同，各人的體質互異，所以在表証、里証和表里証中，又各有寒熱虛實的分別，這也是八綱相互關聯的重要精神。

第三节 寒 热

寒热两綱也是两种不同証候的表现。例如怕冷、身寒、喜溫、显现不足的为寒証，怕热、渴飲、身热、偏于过多的为热証。实际上寒热的变化，也就是阴阳消長的具体表现，所謂“阳胜則热，阴胜則寒”。因此，寒热两綱，在临証診斷中，主要是用来观察阴阳的盈虛消長，以作用药溫涼的依据。內經說：“寒者溫之，热者清之”，就是这个意思。

至于寒热的变化，在临床表现上亦是很复杂的。有的是全身性的寒証或热証，有的是部分寒、部分热，因此在一般寒热証之外，又有偏上偏下的寒热。我們在临床上，每每遇到某些病变是寒在于上，某些病变是寒在于下，又有热偏于上、热偏于下等等。这都是从病变部位表现出来的寒热参差現象，加以診斷的。

更应注意的，就是寒热的真假，如里真寒而外假热，或里真热而外假寒。此类病情非常复杂，是一种“病极則反”的現象，也是生死存亡的紧要关头，在診斷方面，更应細致慎重，密切注意。这里为了把問題說得更清楚些，試再分別举例討論如下：

一、寒証和热証

一般来講，寒証和热証的辨認，可以从口渴、二便、舌苔、脉搏、四肢、面色、气息等各方面去認識，例如口渴为热，不渴为无热；自利或小便清白为有寒，溲赤、热利或便結为有热；舌苔白滑为有寒，黃燥为有热；脉数或滑为有热象，脉迟或沉为寒象；手足躁扰为有热，四肢逆冷为有寒等等。如果把这些症狀同类地联系起来形成一个綜合的証候，我們就可以称之为寒証或热証。

寒証和热証的症狀表现，大致是这样的：

寒証 口不渴，或假渴不能消水，喜飲热湯，手足逆冷，面色蒼白，气冷息微，溺清長，大便溏，舌苔白滑，脉迟等等。

热証 口渴而能消水，喜冷飲，潮热煩躁，手足躁扰，面色紅赤，气热息粗，溺短赤，大便閉結，舌苔黃糙，脉数等等。

二、寒热的上下

寒在上者，多为吞酸，膈噎，飲食不化，噎腐脹噦等証。

寒在下者，多为清濁不分，驚漉痛泄，阳萎遺尿，肢寒足冷等証。

热在上者，多为头痛目赤，喉痛，牙痛，諸逆冲上，喜冷，舌黑等証。

热在下者，多为腰足腫痛，二便秘澀，溺痛遺精，溲渾便赤等証。

辨識寒热的上下，可以在施治用藥之时，运用直达病所、因勢利导的方法，做到寒热溫涼，恰如其分。此外尚有腸寒胃热、腸热胃寒，一时交病，寒热錯杂，在临床上亦每每見之；象黃連湯証、瀉心湯証、連理湯証之类，都是針對这些复杂病变而立方用藥的，临証时足可取法。

三、寒热的真假(表9)

真寒假热，真热假寒，亦即內經所謂“寒极生热，热极生寒”之意，是病本属于寒証，因寒到极点，反見热的假象；或者病本属于热証，因热到极点，反見寒的假象，以致形成了寒热真假的局面。关于这一方面，顧氏医鏡中叙述得很扼要，現介紹如下：

真热假寒 阳盛之极，往往发厥，手足逆冷，自汗发呃，身臥如塑，六脉細微，悉似阴証。但审其內証，必气噴如火，咽干口臭，舌苔芒刺，渴欲飲冷，譫語太息，喜凉惡热，心煩脹滿，按之痛甚，小便必黃赤短少，大便必臭穢殊常，若誤溫之，是以火济火也。（注：可与第一节阴阳中的“阳厥”条合参。）

真寒假热 阴盛之极，往往格阳，身热面紅，口渴喜冷，手足躁扰，言語譫妄，脉来洪大，悉似阳証，但身虽熾热而欲得衣被，口虽喜冷而不得下咽，手足虽躁扰，而神則靜，語言虽譫妄，而声則微，脉虽洪大而按之无力。若誤清之，是以水济水也。

在真寒假热方面，俞根初通俗伤寒論里，叙述得很为具体。他认为，这种病在临床上所表現的症狀有两种情况，即“寒水侮土”和

“肾气凌心”二証，茲节录如下：

寒水侮土証 吐瀉腹痛，手足厥逆，冷汗自出，肉瞤筋惕，語言无力，納少脘悶，兩足尤冷，小便清白，舌質胖嫩，苔黑而滑，黑色止見于舌中，脉沉微欲絕，此皆里真寒之証据。惟肌表浮熱，重按則不熱；煩躁而渴欲飲水，飲亦不多，口燥咽痛，索水至前，復不能飲。此為無根之陰火，乃陰盛于內，逼陽于外，外假熱而內真陰寒，格陽証也，法宜熱壯脾陽，附子理中湯救之。

表 9 寒熱真假辨別參考表

寒熱真假 四診		真寒假熱(陰証似陽)	真熱假寒(陽証似陰)
望診	面部	兩頰色紅如妝，嫩紅帶白，唇色淡白。	面色虽多晦滯，但目光炯炯有神，唇紅或焦。
	神情	有时煩躁，狀若陽証，但精神萎靡，形体倦怠。	神情昏昏，狀若陰証，但或时躁熱。揚手擲足，譫語，形強有力。
聞診	舌苔	1. 舌淡而滑。 2. 舌虽干而質淡。 3. 苔虽黑而滑潤。	1. 舌苔白厚干糙。 2. 舌苔黃燥起刺。 3. 舌苔黑而干燥，質紅。
	聞診	气冷息微，語声无力。身无穢臭气昧，大便无臭气。	气热息粗，声音响亮，热气臭穢噴人，大便穢惡難聞。
問診	問診	1. 口不渴，索水至前，復不能飲。或口渴喜熱飲。 2. 身熱反欲得衣。 3. 小便清白，大便自利，或便秘。 4. 咽喉或痛，但并不紅腫。	1. 口渴能消水，喜冷飲。 2. 身大寒，反不欲近衣被。 3. 小便赤混，大便燥結，矢气極臭，或稀水旁流，肛門灼熱。 4. 心烦，腹脹滿。
	切診	1. 脉虽数而不鼓搏于指下，按之无力，或微細欲絕。 2. 胸腹按之不蒸手，初按似熱，久按則不熱。	1. 脉滑数，按之鼓击于指下；或脉虽沉，按之有力。 2. 四肢虽厥冷，胸腹必灼熱，按之蒸手。

肾气凌心証 气短息促，头晕心悸，足冷溺清，大便溏瀉，气少不能言，強言則上气不接下气，苔虽黑色，直抵舌尖，舌質浮胖而嫩，此皆里真虛寒之証据。惟口鼻时或失血，口齿燥浮，面紅嬌嫩帶白，或煩躁欲裸形，或坐臥泥水中；脉則浮散，按之欲散，或浮大滿指，按之則豁豁然空。虽亦为無根之火，乃陰竭于下，陽越于上，上假熱而下真虛寒，戴陽証也，治宜滋陰納陽，加味金匱腎气湯救之。

按 格阳証为“阴盛于内，格阳于外”，内真寒而外假热，戴阳証为“阴被于下，阳越于上”，下真寒而上假热，細究之虽有内外上下之异，不过病情至此地步，瞬息变幻，两者症狀，每每互見，以往医家，亦常混同言之，此又不可不知。

总之，寒热真假的辨别，必須明确一个道理：寒热之显于表面的属标属假，寒热之隱藏于内的，属本属真。里之真寒或真热，为病候的本質，外之假寒或假热，乃病候的現象，本質和現象，有时是会不一致的。診病之际，当認識疾病的本質，不为假現象所惑。所以遇到这些情况，必須重視里証，着重在里証的推敲，研究表里不一致的所在，这是辨証的一大关键，所謂“詳察其因証，細审其病机”，則真象自見，假象自明。

摘录喻嘉言医案一則：

“徐国楨伤寒六七日，身热目赤，索水到前，复置不飲，异常大躁，將門牖洞启，身臥地上，輾轉不快，更求入井，一医洵涌，急以承气与服。余診其脉，洪大无倫，重按无力，謂曰：此用人参、附子、干姜之証，奈何認為下証耶？医曰：身热目赤，有余之邪，躁急若此，再以人参、附子、干姜服之，踰垣上屋矣。余曰：阳欲暴脱，外显假热，内有真寒，以姜附投之，尙恐不胜回阳之任，况敢純阴之药，重劫其阳乎？观其得水不欲嚥，情已大露，岂水尙不欲嚥，而反可用大黄、芒硝乎？天气燠热，必有大雨，此証頃刻一身大汗，不可救矣！且既謂大热为阳証，則下之必成結胸，更可慮也。惟用姜附，可謂补中有发，并可散邪退热，一举两得，至稳至当之法，何可致疑。吾在此久坐，如有差誤，吾任其咎。于是以附子、干姜各五錢，人参三錢，甘草二錢，煎成冷服，服后寒战，戛齿有声，以重綿和头裹之，縮手不肯与診，阳微之狀始著。再与前药一剂，微汗热退而安。”

第四节 虚 实

中医治病，是根据病人体質的強弱，邪气的盛衰，辨明虛实，投以或补或瀉的方剂，以祛除病邪，恢复健康的。早在內經里面，对于虛实就有很多的論述，如說：“邪气盛則实，精气夺則虛。”又說：“邪之所湊，其气必虛”等等，并且在治疗方面，特別提出“毋虛虛，

毋盛盛”的郑重告誡。可見虛實兩端，在診斷上有着重大意義。一般來說，體壯初病，症多屬實；體弱久病，症多屬虛。凡病者體質和証候，表現為有余、結實、強盛的，是實証；表現為不足、衰退、松馳的，是虛証。例如，發熱為邪在肌表，無汗即為表實，有汗即為表虛；見胃腸症狀則為邪在裏，腹滿便秘即是裏實，腹軟便溏即是裏虛。下面再來分別的予以說明：

一、虛証和實証

素問玉機真藏論：“脈細、皮寒、氣少、泄利前後、飲食不入，此謂五虛；脈盛、皮熱、腹脹、前後不通、悶瞖，此謂五實。”這是從五臟的病能來診斷的。

洄溪雜病源說：“心實多言多笑，小便黃赤澀少；心虛則神慘怛，志意怯慮多，悲愁不樂。肝實則多憤多怒，小腹兩肋疼痛；肝虛則目眈眈無所見，善恐，陰縮筋攣。脾實則痞滿腹脹，氣閉身重；脾虛則四肢不為我用，飲食不為肌膚。肺實則喘咳多痰，胸滿氣逆；肺虛則氣少息微，皮毛枯澀少津。腎實則氣壅穹閉，二便痛澀；腎虛則二便不禁，夜多夢泄遺精。”

醫學心悟說：“一病之虛實，全在有汗與無汗、胸腹脹痛與否、脹之減與不減、痛之拒按與喜按、病之新久、稟之厚薄、脈之虛實以分之。假如病中無汗，腹脹不減，痛而拒按，病新得，人稟厚，脈實有力，此實也；假如病中多汗，腹脹時減，復如故，痛而喜按，按之則痛止，病久稟弱，脈虛無力，此虛也。”這是從多方面的証候來診斷的。

醫學正傳說：“虛者，正氣虛也，為色慘形瘦，為神衰氣怯，或自汗不收，或二便不禁，或夢遺滑精，而嘔吐膈塞，或久病攻多，或短氣似喘，或勞傷過度，或暴困失志，雖症似實，而脈弱無力者，皆虛証之當補也；實者，邪氣實也，或外閉於經絡，或內結於臟府，或氣雍而不行，或血留而凝滯，此脈病俱盛，乃實証之當攻也。”這一節對虛實兩証，描寫得亦比較全面，足供臨床時的參考。

張景岳說：“實言邪氣實，則當瀉；虛言正氣虛，則當補。凡欲察虛實者，為欲知根本之何如，攻補之宜否耳。”

临床上辨别病証的虛实，即是攻邪补正的依据。如何攻补，主要是一个标本的道理。正气为本，邪气为标，若正气已虛，邪气虽盛，亦不可攻，攻之惟恐邪气未易尽去，而正气先脱。所以治虛証，宜先照顧正气，正气存則不致于害；且补中自有攻意，所謂养正則邪自去。但此为治虛而言，若正气未損，邪气亦微，自不宜补，补之則正气不但无益，且反助邪气，适足造成“实实”的弊病。所以治实証，必須以除邪为先，邪去則身安，所謂攻邪可以安正，此又为治实的說法。要之必須結合病人具体情况，根据当前需要，务使病体在抗病过程中，得到最有利的协助。

二、气血的虛实

1. 气虛和血虛

气虛：呼吸淺短，声音低怯，自汗，心悸，怔忡，头晕耳鳴，气弱懶言，疲倦食少，消化不良，脉微或虛大。

血虛：心煩少眠，躁急多怒，夜热盜汗，肌肤枯澀，唇淡色萎，脉細无力。

气虛的人，不仅一切工作能力大大降低，而且对内外环境变化的适应，也每欠正常。此外如某些素少劳动、体肥而肢軟乏力的人，或曾經强力持重的人，往往有脱肛，腸疝，以及妇人子宫脱出等病症，也是气虛的关系，应照气虛論治。

血虛的人，若血亏而見脉数、身热、苔少舌紅等証，此为“阴虛有火”，可用甘凉降火之品；若血亏而見形寒、脉弱、舌淡、便溏等証，此为“脾胃虛寒”，可用甘溫健脾之品。

2. 气实和血实

气实之証，多由痰热、湿热、食滯、郁結、伏火等因，通常可見胸痞脘悶，痰多喘滿，張口抬肩，腹脹吞酸噯腐，大便秘結，或瀉而不暢等証；治疗宜先其所因，伏其所主，直去其邪，以安其正。

血实之証，多因郁血、瘀血，如妇女經閉腹痛拒按，以及跌仆腫疼等証。瘀在腠理，常見乍寒乍热；瘀在肌肉，常見潮热盜汗；瘀在經絡，常見身痛筋掣。治疗都应以消瘀为主，輕者通絡，重則破血，寒瘀溫通，热瘀凉通，瘀去則新血自生。

三、虛实的真假

張景岳說：“虛者宜補，實者易瀉，此易知也，而不知實中復有虛，虛中復有實，故每以至虛之病，反見盛勢，大實之病，反有羸狀，此不可不辨也。如病起七情，或飢飽勞倦，或酒色所傷，或先天不足，及其既病，則每多身熱、便秘、戴陽、脹滿、虛狂、假斑等証，似為有余之病，而其因實不足。又如外感之邪未除，而留伏于經絡，食飲之滯不消，而積聚于臟府，或郁結逆氣，有所未散，或頑痰瘀血，有所留藏，病久致羸，似乎不足，不知病本未除，還當治本。”

顧氏醫鏡說：“積聚在中，按之則痛，色紅氣粗，脈來有力，實也；甚則嘿嘿不欲語，肢體不欲動，或眩暈昏花，或泄瀉不實，是大實有羸狀也，若誤補之，是謂盛盛。心下痞痛，按之則止，色粹聲短，脈來無力，虛也；甚則脹極而不得食，氣不舒，便不得利，是至虛有盛候也，若誤瀉之，是謂虛虛。”

徐靈胎說：“虛實之要，莫逃乎脈，如脈之真有力，真有神，才是實証；脈之假有力，假有神，便是虛証。”

按 大實有羸狀、至虛有盛候，與真寒假熱、真熱假寒同是一種“病極則反”的証候，不過一在于寒熱，用藥主乎溫清，一在于虛實，用藥主乎攻補，這個界限，必須明確。至于對虛實真假的辨別，李士材曾這樣說過：“大概症既不足凭，當參之脈理，脈又不足凭，當取之沉候。彼假症之發現，皆在表也，故浮取而脈亦假焉；真症之隱伏，皆在里也。故沉候脈而脈可辨耳。脈辨已真，猶未敢恃，更察裏之厚薄、症之久新、醫之誤否，夫然後濟以湯丸，可以十全。”這個說法啟示我們，在辨識病証上，必須脈証合參，作整體性的全面考慮，才能達到完全正確的地步。

摘錄李士材醫案二則：

“社友韓茂遠，傷寒八九日以來，口不能言，目不能視，體不能動，四肢俱冷，六脈皆無，以手按腹，兩手護之，眉皺作楚。按其趺陽，大而有力，乃知腹有燥屎也，遂下之，得燥屎六七枚，口能言，體能動矣。”

（按 此為真實假虛之例）

“休寧吳文哉，患傷寒，煩躁昏亂，悶絕，時索冷水，手揚足擲，

难以候脉，五六人制之，方得就診，洪大无倫，按之如絲。遂用理中湯加參附，煎成入井，冰冷与飲，甫及一时，狂躁定矣。”

(按 此为眞虛假实之例)

小 結

八綱的內容，大致已如上述。它在診斷範圍內的运用，主要是一种归納症狀的邏輯方法，也是一种病理变化的推理解說。但我們必須知道，八綱的相互之間，均有密切的关联，不能將某一个綱領孤立起来。例如阴阳二綱，寒化为阴，热化为阳；在里为阴，在表为阳；虛者为阴，实者为阳。这就說明了阴阳实貫串在其他六綱之中。換句話說，阴阳与其他六綱具有統属关系，它可以賅括六綱。表里二綱，和寒熱虛实也有相互的关联，如表有表寒、表热、表虛、表实之分，里有里寒、里热、里虛、里实之分。更有表热里寒、表寒里热、表虛里实、表实里虛、表里俱寒、表里俱热、表里俱虛、表里俱实等情况，都可說明它們之間，有其不可分割的关系。又如寒熱二綱，是一种病理征象，其出現情况，也常是很复杂的，因此在診斷上就有偏寒偏热，寒熱交杂，寒熱眞假之分。又如虛实二字，須要結合邪正来看，有邪盛而正不虛的，有邪不盛而正已虛的，又有正虛甚而邪留恋的，这些情况，都应作全面考虑。所以，在診斷領域內，八綱的应用，并不是孤立的，而是相互联系的。我們必須应用整体观点的辨証法則，然后在临床治疗上，才能充分發揮它的作用。

此外，尚有一个标本問題，也得注意，运用了它，辨証論治，可以更有秩序。它的意义也是多方面的，如先病为本，后病为标；受邪(病因)为本，見証(現象)为标；正气为本，病邪为标等等。这种学說，从診斷指导治疗，亦很重要，如有宜先治其本的，有宜先治其标的，也有宜标本同治的。如果标本混淆不分，虽能掌握了八綱，在治疗之間，仍不免要影响到全面疗效。所以內經上說：“知标本者，万举万当。不知标本者，是謂妄行。”就是这个意思。

內經还告訴我們說：“緩則治其本，急則治其标，”又說：“病发而有余，本而标之，先治其本，后治其标，病发而不足，标而本之，先治其标，后治其本。”这些都是在治疗时，决定先后緩急的准繩。例

如病人肝木偏旺，中凌脾土，发为腹脹便泄，当先治其肝，后治其脾，这是“本而标之”的意思。又如病人肺阴不足，客邪内侵，咽痒咳嗽，痰吐不暢，当先清理客邪，后养肺阴，这是“标而本之”的意思。

我們在临証實踐中，要既能掌握八綱，又能运用标本，才能更好地进行診斷和治疗。

复 習 題

1. 中医診斷运用八綱的意义何在？八綱与四診的关系如何？
2. 表里与寒热虛实的关系如何？
3. 怎样辨別寒热虛实的真假？

第二章 四 診 概 要

一个疾病发生与发展的过程，也就是邪正相爭，盛衰消長，相互轉化的过程。在这种轉化进行中，它一定会表现出許多現象来，这种表现出来的現象，就是各式各样的症候。前人尝說：“有諸內，必形諸外。”意思就是說，体内有了病变，外形必出現症狀。所以病人发生的許多症狀，都是疾病变化的直接或間接的反映。事实的确如此，有什么病，他就会見什么症，反过来講，見什么症，也可以了解他生什么病。中医診斷的运用四診方法，就是从望聞問切各个角度上来观察和了解病情变化，“从外知內，見症知病”的。这种四診方法的理論認識，是由于懂得了事物演变的反映，所以“欲知其內，当觀乎外；診察于外，斯知其內”的指导工作，在中医临症診斷上，一貫用有成效的。同时这种診察方法，不仅仅見于中医学术范围之內，他与整个祖国文化密切联系着，如四書上說：“听其言也，觀其眸子，人焉廋哉！”千字文上亦說：“聆音察理，鑒貌辨色。”这种“听其言”“觀眸子”“聆音察理，鑒貌辨色”不就是一种四診方法嗎？通过这样方法来观察和了解一个人，它的内心活动，就无从掩藏。更須指出的这种診察方法，是人們的日常生活知識，例如任

何一个血气虛弱的病人，走到人們面前，不論老少男女，每每有他共同的評語，說这个人“血气不好”，或者叫“气色难看呀！”这些說法，說明了什么問題呢？實質上是反映了中医学术的群众基础，它是从群众中来的，是群众智慧的結晶。所以中医的四診知識，有它的理論根据，有它的文化关系，有它的群众基础，我們运用了它，不仅在临症工作上能解決問題，而且在工作关系上，也容易接近群众，与群众多共同語言。

望聞問切四診，在临症上都有它們的独特作用，如难經上說：“望而知之者，望見其五色以知其病；聞而知之者，聞其五音以別其病；問而知之者，問其所欲五味，以知其病所起所在也；切脉而知之者，診其寸口，視其虛实，以知其病，病在何藏府也”。但四診之間，是“相得益彰”的，所以徐春甫說：“四者之要，望聞問之三者，先以得其病情之端，而后总切脉于寸口，确乎知病之源。”在灵樞上面，亦早已指出：“知一則为工，知二則为神，知三則神且明矣。”我們在临症診斷上，應該把四診密切配合起来，作多方面的觀察和了解，才是全面的做法，假如你凭一种或二种的方法，只掌握了片段材料，就遽下判断，这样去做，是会帶有片面性的。

四診的討論方法，与八綱不同。討論八綱，是以一个病或者整个証候群，从望聞問切各方面来加以論証的，所以較詳細，而且有条理，学习起来容易理解；至于討論四診，是以一个病或者整个証候群，分成望聞問切四个部分来加以論述的，材料較為分散，在学习过程中，要善于把各方面情况联系起来看，特別要与八綱联系起来看，这样，四診的診察，对識病認症，就更能發揮他的应有作用。这种診察方法，是前輩中医經驗的积累，是有它一定的特点和价值的，所以直到現在还被广大的医务工作者应用着，这里为了便于作进一步的討論起見，再分別叙述如下。

第一节 望 診

望診主要是运用医生的視覺，觀察病員全身各部分的神、色、形态，看它发生什么变化。所謂“神”，这是生命活动的表現，如“精神”“神气”等。一般来講，身强則神旺，身弱則神怯。“色”是五藏

气血的外荣，如气血旺盛则色泽荣润；气血衰减，则色泽枯槁。“形”是形体，形体的端正丰实，是健康而且为享寿的表征，如相反的缺陷脆弱，每每是多病而善感外邪的。“态”是动态，动态矫健灵活，是精神饱满的现象，如相反的牵强不利，又是某些病态的征象了。这些神、色、形、态，是一个人生活活动的基本表现，要求是能够处处相称的，假如这几方面一有变化，即为反常状态，也就是病态。中医在临床工作中，对于运用望诊以察疾病变化，是有深刻研究的，我们诚能多加探索，潜心体会，在诊断工作上，可以起到很大作用。所以前人对望诊工作，评价很高，又把它列为四诊之首，尝说：“望而知之谓之神”，于此可以想见它的重要程度了。

望诊整个精神，贯注在神、色、形、态等各方面，因这些神、色、形、态的变化，表现于全身各个部分，如面、目、口、鼻、唇、齿、舌苔、四肢、皮肤等等，我们要了解全身各部分神、色、形、态的变化情况，应先对这几方面，有一个基本认识，作为望诊的基础。我们这里的叙述为望诊的一般情况，掌握了这个基础再进行全身各部分的观察，就能做到有重点，有目的地掌握某一部分或某一种形色的变化，为临症上提供更充分的诊断资料，现在按照望诊的“分部观察”，次第的分述如下。

甲、望诊的一般情况

一、望神色（表 10、11，图 1、2）

神色的生成 神色的生成，乃来源于水谷，变见于气血，所谓“五臟所生之外荣”。如素问八正神明论说：“血气者，人之神，”脉要精微论亦说：“精明五色者，气之华也，”灵枢平人绝谷篇又说：“神者，水谷之精气也，”这些经文，都具体的说明了神色的所以生成。

神色的表现 石蒂南说：“人之神气，栖于两目，历乎百体。”的确，我们看到一个人的神气旺盛，则两目光彩，精神奕奕，矫捷轻捷；反之，一个人神气衰微，就目光无彩，萎靡不振，垂头丧气了。素问解精微论上亦说：“人有德（得）也，则气和于目，有亡，忧知于色。”喻嘉言说：“色者，神之旗也。神旺则色旺，神衰则色衰，神藏

則色藏，神露則色露。所以察色之妙，全在察神。血以養氣，氣以養神，病則交病。失眠之人，神有飢色；喪亡之子，神有呆色，氣索自神失所養耳。”這就很生動的描寫了神色的關係和表現。

神在望診上的重要性 神在望診上是很重要的，如素問湯液醪醴論上說：“精氣弛壞，榮泣衛除，故神去之，而病不愈也。”靈樞平人絕谷篇上亦說：“五藏安定，血脈和利，精神乃居。”天年篇又說：“失神在死，得神在生。”這樣，神的盛衰，不僅關係到血氣的盛衰，亦可以診斷到一個病員的死生，它的意義，可想而知。張景岳更以病人的具體表現，來判斷神之存亡，他在“神氣存亡論”里說：“診病以形証言之，則目光精彩，言語清亮，神思不亂，肌肉不削，氣息如常，大小便不脫，若此者，雖脈有可疑，尙無足慮，以其形之神在也；若目暗睛迷，形羸色敗，喘急異常，泄瀉不止，或通身大肉已脫，或兩手尋衣摸床，或無邪而言語失倫，或無病而虛空見鬼，雖其脈無凶候，必死無疑，以其形之神去也。”張氏此說，是以臨症經驗發揮了內經“得神者昌，失神者亡”的精神（在看面目、舌、苔、癍疹、白痞等，也同樣是注意它的神氣色澤的變化，對觀察病情發展非常重要）。

五色診 病人面部的異常色采，叫做病色，根據病色表現，可以測知內臟的病情變化。這種病色的觀察方法，前人已摸出了一套規律，例如“肝病色青，心病色赤，脾病色黃，肺病色白，腎病色黑”。這是按照五行的規律，用木、火、土、金、水來代表五色的屬性，用以說明病症變化關係的，這種診察方法，就是臨症上運用最早的“五色診法”。

五色診法，是根據五行精神運用的，所以它與五藏、五時、五方、五脈等都有聯繫。例如東方色青，其應春氣；南方色赤，其應夏氣；中央色黃，其應土氣；西方色白，其應秋氣；北方色黑，其應冬氣。又如色青者，其脈弦；色赤者，其脈鉤（洪）；色黃者，其脈代（緩）；色白者，其脈毛（浮）；色黑者，其脈石（沉）。所有這些聯繫，說明了五色的變化，可以表示出病情的很多方面，在診斷上是有重要作用的。

五色善惡 五色的表現，宜明亮、含蓄，這叫做“善色”；忌晦

暗、暴露，这叫做“惡色”。例如素問五藏生成篇上說：“青如草莖者死，黃如枳實者死，黑如炁者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死，此五色之見死也；青如翠羽者生，赤如鵝冠者生，黃如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如烏羽者生，此五色之見生也。”

表 10 五色配五行五藏五時五方五脉及其吉凶表

五色	五行	五藏	五時	五方	五脉	善色	惡色
青	木	肝	春	東	弦	如翠羽	如草莖
赤	火	心	夏	南	鉤	如鵝冠	如衄血
黃	土	脾	長夏	中央	代	如蟹腹	如枳實
白	金	肺	秋	西	毛	如豕膏	如枯骨
黑	水	腎	冬	北	石	如烏羽	如炁

病色交錯 病色交錯，是病與色之間的順逆生剋。以肝為例，肝病色青，是正病正色，若反見他色，便為病色交錯。如見黑色，為母乘子，相生之順；若見赤色，為子乘母，相生之逆。若見黃色，為病剋色，其病不加，為凶中順；若見白色，為色剋病，其病則甚，為凶中逆。相剋為凶，凶中順尚可。凶中逆，則必凶；相生為吉，子乘母為吉中小逆，母乘子為吉中大順。其餘四藏，可以类推。

表 11 五藏病色交錯表

五藏	正病正色	病色交錯				備注
		母乘子 (相生之順)	子乘母 (相生之逆)	病剋色 (凶中順)	色剋病 (凶中逆)	
肝	青	黑	赤	黃	白	1. 相剋為凶，凶中順尚可，凶中逆，則必凶。 2. 相生為吉，子乘母為吉中小逆，母乘子為吉中大順。
心	赤	青	黃	白	黑	
脾	黃	赤	白	黑	青	
肺	白	黃	黑	青	赤	
腎	黑	白	青	赤	黃	

色脉相參 色脉相參是從色脉兩者變化，比較論病的。如素

問脈要精微論上說：“征其脈小色不奪者，新病也；征其脈不奪，其色奪者，此久病也。征其脈與五色俱奪者，此久病也；征其脈與五色俱不奪者，新病也。”這是通過色脈的合參，可以知病久暴。又靈樞邪氣藏府病形篇亦說：“見其色而不得其脈，反得相勝之脈，則死矣；得其相生之脈，則病已矣。”這是通過色脈合參，可以知道生尅死生。臨症常見病例，如麻疹初發，其面發赤，其脈應洪。若得沉脈，是色脈不合，難治；如能得弦脈則為可治。

以上所講五色生尅，是五色診病的比較進一步的學說。由於古人經驗積累，認識到某一種病的相互間條件的有利與否，可以轉化它的發展方向。例如腎病而肺健者，其腎病常可治（金生水），肝病而腎健者，其肝病常可治（水生木），心病而肝不旺者，其心病常可治（木生火，肝木不旺，心火自平），脾病而心不病者，其脾病常可治（火生土），肺病而脾健者，其肺病常可治（土生金）。反之，如腎病而脾氣弱者（土不制水），肝病而肺火旺者（金尅木），心病而腎氣虧者（水不制火），脾病而肝陽盛者（木尅土），肺病而心陰虛者（虛火刑金），則其病皆逆。這種以五行生尅道理說明病症的變化關係，是有着概括意義的。

五色配合五臟、五時、五方和五脈等，研究它的錯綜變化，並從這種變化中，了解病情，這是“五色診”的大略。這些知識，是前人長期實踐的經驗，可以運用它來討論病情，更可以運用它來決斷預後的吉凶死生，此中每每可以得到很好的消息，這是值得我們注意的。

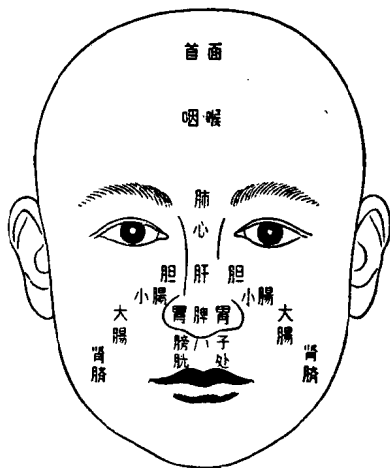


圖 1 面部色診分屬部位圖

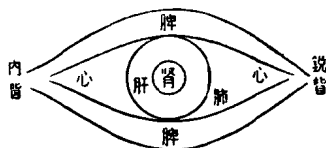


圖 2 目部五臟分屬圖

色診面目分部 关于藏府在面目上的分部，灵樞五色篇說：“庭者，首面也；闕上者，咽喉也；闕中者，肺也；下极者，心也；直下者，肝也；肝左者，胆也；下者，脾也；方上者，胃也；中央者，大腸也；挟大腸者，腎也；当腎者，臍也；面王以上者，小腸也；面王以下者，膀胱、子处也。”灵樞大惑論：“五藏六府之精气，皆上注于目，而为之精，精之窠为眼，骨之精为瞳子(腎)，筋之精为黑眼(肝)，血之精为絡(心)，其窩气之精为白眼(肺)，肌肉之精为約束(脾)，裹攝筋骨血气之精而与脉并系，上属于腦，后出于項中。”

这种藏府在面目的分属部位，是五色診的基础。怎样通过五色变化的观察，从而测知是某一藏府的病变及其相互影响的关系，就是根据这种部位分属，进行討論的。

二、望形态(图3)

形是形体，态是动态。某些疾病，在形体上表现异常，某些疾病又在动态上失于正常，而某些疾病则在形体和动态上两方面都可以給我們诊断印象。从以下所引文献，就可以看出这些問題。

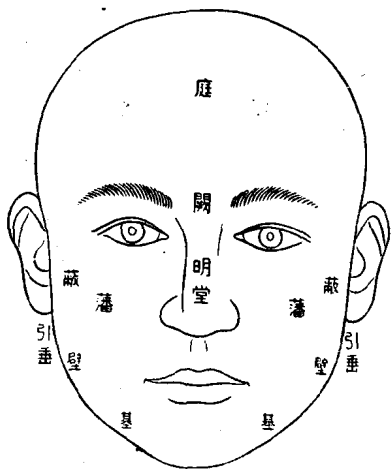


图3 明堂藩蔽图

寿夭象征 寿夭的象征，是从外形的观察，可以了解一个人的寿夭。如灵樞五閱五使篇上說：“五官已辨，闕庭必張，乃立明堂，明堂广大，藩蔽見外，方壁高基，引垂居外，五色乃治，平博广大，寿中百岁。見此者，刺之必已，如是之人者，血气有余，肌肉坚致，故可苦以鍼。”又說：“五官不辨，闕庭不張，小其明堂，藩蔽不見，又埤其牆，牆下无基，垂角去外，如是者，虽平常殆，况加疾哉！”这是从外貌的观察，可以知道寿夭不同，当其患病时，也就治疗难易有殊，预后安危各异了。

形体强弱 身体的强弱，是从形态的表现，可以了解一个人的强健与否。如素問脉要精微論上說：“夫五藏者，身之强也。头者精明之府，头傾視深，精神將夺矣；背者胸中之府，背曲肩随，府將坏矣；腰者腎之府，轉搖不能，腎將憊矣；膝者筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣；骨者髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣；得强則生，失强則死。”这段經文，是身体强弱的具体描写，他說明一个人能够头昂、挺胸、脚健，轉动灵活，能耐劳动，就是健康的表现；反之，一部有病，則形体不振了。

各种病态 不同的疾病，产生不同的形态，这种不同的形态，就是各种疾病的特征。如伤寒論平脉法上說：“搖頭言者，里痛也；行迟者，表强也；坐而伏者，短气也；坐而下一脚者，腰痛也；里实护腹如怀卵物者，心痛也。”王宇泰亦說：“中湿风湿，皆主身重疼痛，不可轉側，要当辨之。大抵阳症身輕而手足和暖，开目而欲見人为可治；若头重視身，此天柱骨倒，而元气敗也。又伤寒傳变，循衣摸床，两手撮空，此神去而魂乱也。又病人皮肤潤泽者生，枯槁者死。”伤寒辨脉法又說：“脉浮而洪，身汗如油，喘而不休，形体不仁，乍靜乍乱，此为命絕也。”

乙、望診的分部观察

一、头 面

从望診的范围来講，它包括人体全部，这是可以肯定的。但另一方面，古人对面和目的望診，尤为重視，如五色診法就是例子。及至溫病学說发展以后，对于舌苔和齿的观察，又更进一步充实和丰富了望診的内容。我們認為在分部望診上，面目和舌苔，是比較重要的，所以，介紹材料，在这两方面也比較多一些。

1. 面部望診 灵樞邪气藏府病形篇說：“十二經脉、三百六十五絡，其气血皆上于面”，如果五藏安和，則其所蘊之精华皆現于面，而色露正色，不見病色；假如有了病，面上就会現出种种不同的病色变化来。由此可見，面部的神气色泽是經絡藏府所蘊藏精华显示于外的一个标志，所以我們也就可以从面部的变化来測知藏府的疾病了。

(一)五色主病：青黑为痛，黄赤为热，白为寒，这是一种说法；又色青为风，色赤为热，色黄为湿，色白为寒，色黑为劳，这又是一种说法。若推而演之，则其说更多。兹再叙述各家说法如下：

面色白，为虚为寒。脱血夺气，亡津液，其面部皆呈白色，纵有火色发热，亦为虚火，断无实热之候。又面上有白点白斑者为腹有虫积。

面色黄，为湿为热为虚，而有明暗之分。挟热则色鲜明，挟温则色昏滞。淡黄痿黄，为内伤脾胃。黄而肥盛，胃中有痰湿；黄而枯羸，胃中有火。面色淡黄之中有红点红纹，是为虫蠱。又凡久病人于准头印堂年寿间，面色转黄而明润，为病退欲愈之候。

青色见于面，大抵为风、寒、痛三症。一般而论青为尅贼之色，诸病皆忌单见独见，脾土部分，尤忌单见，见之其证必凶。若妇女面见色青，必肝强脾弱，多怒少食，或经脉不调。又小儿惊风，亦面现青色。

黑色见于面，为寒为痛。支饮、酒疸、女劳疸，其面皆呈黛黑之色，然支饮、酒疸必黑而带黄。又瘦人多火，面色苍黑，不可泥其为寒。若黑色出于庭，大如拇指，必不病而卒死，此为肾阴早亏，心阳暴绝所致。

赤色见于面大都属热，但有表里虚实的不同。如面色缘缘正赤，为阳气怫郁在表；胃热面赤如醉，又当分其经证与腑证，若面赤口渴饮水脉洪的，为热在阳明气分；若面赤潮热谵语，为实热壅结于府。这是在伤寒过程中每每引为注意的。至若午后颧赤，为阴虚火旺；又面赤如妆，嫩红带白，游移不定，是谓戴阳，这是属于虚损的病情。

诸凡邪在于表，必浮油明显，邪在于里，必沉着深暗。色赤的因热，色白的因寒，色泽浅淡的为正气虚，深浓的为邪气实。这些变化又反映了病情的表里寒热虚实。

观察神色，终以明润为佳，不欲沉夭。凡暴感客邪之色，不妨昏壅滞浊；病久气虚，只宜瘦削清羸。若病邪方强，而见清白少神，或虚羸久困而见嫵媚鲜豔，都不是属于正常的气色，临床上必须加以注意。

(二)色泽浮沉：面色浮泽，为病在表在府；沉濁为病在里在藏。如颧中薄泽为风，风病主阳，皮毛受之，其病浅；冲濁为痺，痺病在阴，肉骨受之，其病深。

(三)色的变化：色散而不聚，其病为近；色聚而不散，其病为远。色上行者，濁气方升而色日增，日增者病日重；色下行者，滞气将散，而色渐退，渐退者病将已。

五藏各有藏部，有外部，有内部。外言六府之表，六府分部于面之两侧；内言五藏之里，五藏分部于面之中央。凡病色先起外部，而后及内部者，其病自表入里，是外为本而内为标，当先治其外，后治其内；若先起内部，而后及外部者，其病自里出表，是阴为本而阳为标，当先治其阴，后治其阳。若反之者，皆为误治，病必益甚。

(四)面腫面浮：面腫与浮，最宜分别。腫则为实，因风火上炎，紅腫而热，或按而痛，此为邪气有余，脉必紧，証必寒热；面浮则为虚，因劳倦伤脾，脾肺阳虚，輸化失常，而面目虚浮，无痛无热，此为正气不足，其形必虚软，其脉必虚弱。

2. 目部望診 內經云：“肝开窍于目”，又云：“五藏六府之精气，皆上注于目”，而目系则“上入于腦”，由此可見，目与藏府有着极为密切的关系。故凡病危之时必察两目，視其变化如何，借以了解藏府的病情，內經云：“头傾視深，精神将夺矣”，是以目部的观察，在望診中亦很重要。

(一)五色主病：目赤色者病在心，白在肺，青在肝，黄在脾，黑在腎。又皆赤者心火，白赤者肺火，珠腫者肝火，皮紅湿爛者脾火。目赤腫者，厥阴肝經风热；白睛黄者，将发身黄。病人眼胞上下有如烟煤，是为痰飲。

(二)清明与昏暗：热病則目昏暗，寒病則目清彻。黑白分明内无热邪，目視不明，是里已有热。又病人目色清白宁靜，多非火証，不可妄用寒凉；病人目不識人，阳明实証可治，少阴虚証难治。又气脱者目不明，阴脱者目盲。目瞑，为將歿之兆；瞳神散大，为腎水不足。若病人目眇多結，則又为肝胆火盛所致。

(三)运动和腫陷：凡病見目反上視，或瞪目直視，或目睛正

圓，或戴眼反折，皆为五藏已絕之症，不治。目內陷者，死。因五藏六府之精气，皆上注于目，而为之精，目陷，为五藏六府之精气皆脫，故死。若病人目精微定，移时即又轉动如常的，多因痰閉使然，不可竟認作不治。

水病始起，目窠上微腫，如新臥起之狀。目上下瞼腫，为脾气热病；若脾虛，則瞼亦腫，以瞼为脾之所主。但脾热之腫，腫急色紅；脾虛之腫，浮腫寬軟，色澤較滯，与水病之胞腫，又稍有別；水病胞腫，为里水而皮有光亮，尤显著在下瞼。

(四)远視和近視：目能远視，責其有火，不能近視，責其无水；法当补肾，用地黃、天冬、山萸之类。能近視，責其有水，不能远視，責其无火；法当补心，用人参、茯神、远志之类。又能曉視，不能晚視，日出則明，日入則暗(俗名鸡盲)，此元阳不足，而胃气不升，宜大补而升举其阳。

3.鼻部的望診 鼻居面部的中央，是脾的部位，又是肺窍。古人对鼻的望診，也相当重視，不但观察它的五色变化，同时还观察它的外形异常，如腫起或陷下，以及崩坏的情况。至涕出的清濁，呼吸的通窒，了解都很細致。举例說明如下：

鼻头色青，腹中痛，苦冷者死；色黄者便难，色白者为气虛或亡血，色赤者为风热，色黑者为劳；微黑者有水气，色鮮明者有留飲。

鼻孔干燥者，属阳明之热，必將衄血；鼻孔干燥，黑如烟煤者，阳毒热深；鼻孔冷滑而黑者，阴毒冷极。鼻腫起者，邪气盛；陷下者，正气衰。

鼻流濁涕，外受风热；鼻流清涕，外感风寒。久流濁涕，其味腥臭，是为鼻淵，系风热燦腦，脂液下滲。又胆移热于腦，亦为辛頻鼻淵。鼻生瘡肉，湿热之盛。鼻孔煽張，肺热之甚。眉发脫落，鼻柱崩坏，为厉风惡候。

4.耳部的望診 望診耳部，不仅可以推測整体变化，又因为耳是肾窍，它的外形变异还反映了肾病征兆。如：耳厚大者为形盛，薄小者为形亏；腫起者，邪气实，消减者，正气虛。下消則耳輪焦黑，腸癰則耳輪甲錯。又凡耳輪紅潤者生，或黄或白，或青或黑，而枯燥者死。薄而白，薄而黑，皆为腎敗。

5. 口唇的望診 脾开窍于口，其华在唇四白，而且脾胃相为表里，所以口唇的变化情况，大都为脾胃疾患的症狀。至于口噤、口斜等，又属于厥阴肝經的病变了。举例如下：

口唇焦干为脾热，亦为食积；焦而紅者吉，焦而黑者凶。唇口俱赤腫者，为热甚；唇口俱青黑者，为冷极；唇淡口膩者为寒湿；唇淡而白者，血虛；唇紅紫者，血瘀。吐血唇紅者，胃热；吐涎唇白者，胃虛。唇紫声嘶者，虫积；唇茧舌裂者，毒积。

脾病則唇黃，肺病則唇白，肝病則唇青，心病則唇赤，腎病則唇黑。又溫病則唇腫，風病則唇瞤，寒病則唇揭，熱病則唇皸，燥病則唇裂，火病則唇痒，氣病則唇麻，血病則唇木。足太陰氣絕則唇反，足厥陰氣絕則唇青，舌卷，卵縮。

口噤不語为瘖厥，口唇喎斜为中风。若唇青舌卷，唇反青，环口鰲黑，口張氣直，口如魚口，口唇顫搖不止，氣出不返，都属难治。

6. 牙齒的望診 腎主骨，齒为骨之余；又陽明之脉，絡于齒齦，所以觀察牙齒的病变，如潤燥枯澤，可以了解腎液胃津的变化，尤其在熱性病方面应特別注意。至齒齦的变化，又表示了胃的病情。

齒上有垢，为胃濁所結；牙齒變燥，为陽液受傷；齒焦有垢，为火虽盛而津液尚未耗竭；其色如灰糕样，則腎胃津液兩竭，其証多死；齒焦无垢亦死。若齒光燥如石，为胃熱甚；色如枯骨，为腎陰涸。又前板齒燥而脉大的为陽明經熱，脉虛的又为中暑。又上齒齦燥为胃絡熱極，証多吐血；下齒齦燥为腸絡熱極，証多便紅。又邪熱傷血，齒色必黃而結瓣；若黃如醬办，为熱邪耗劫腎液，其証多險；若紫如干漆，則又为邪熱耗劫胃津，証尚可治。

咬牙切齒，不是風痰阻絡，就是熱化作瘖。又齒縫流血（齒衄），痛者为胃火冲激，不痛者为腎火上炎。

7. 舌和苔的望診

(一) 舌和苔的一般情况

舌和苔 我們通常是把舌和苔联系在一起，統称之为“舌苔”（或舌胎）。但根据文献和望診的意义来看，舌和苔應該分別开来，舌是指舌体的本身，苔是指舌面的苔垢，如脉理正义上說：“凡言苔者，有垢上浮是也”，辨舌指南又說：“辨舌質，可辨五藏之虛實，視

舌苔，可觀察六淫之淺深”。同時前人還認為察舌質的變化，較察舌苔的變化，更有它的重要意義。如診家直訣上說：“凡察舌，須分舌苔、舌質。舌苔雖惡，舌質如常，胃氣穢濁而已。”周澂之亦說：“舌苔無論何色，皆屬易治；舌質既變，即當察其色之死活。活者，細察底里，隱隱猶見紅活，此不過血氣之有阻滯，非藏氣之敗壞也；死者，底里全變干晦枯萎，毫無生氣，是藏氣不至矣，所謂真藏之色也。”

舌苔之生成 舌苔之所以生成，根據吳坤安的说法：“舌之有苔，猶地之有苔。地之苔，濕氣上泛而生；舌之苔，胃蒸脾濕上潮而生，故曰苔。”章虛谷亦說：“舌本通心脾之氣血……脾胃為中土，邪入則生苔，如地上生草也。若光滑如鏡，則胃無生發之氣，如不毛之地，其土枯矣；胃有生氣，而邪入之，其苔即長厚，如草根之得穢濁而長發也，故可驗病之虛實寒熱、邪之淺深輕重也。”

舌苔和內臟的關係 舌苔和內臟是有着密切聯繫的，舌苔的變化如何，可以反映出臟府的疾病程度。如靈樞經脈篇上說：“手少陰之別，系舌本”、“腎足少陰之脈，循喉嚨，挾舌本”、“厥陰者，肝脈也；肝者，筋之合也；筋者，聚于陰器，而脈絡于舌本也”、“足太陰之正，貫舌中”，至如足陽明、足太陽、手少陽等，也都與舌有聯繫，在靈樞經脈篇和營衛生會篇中都有記述。脈度篇又說：“心氣通于舌，心和則舌能知五味矣。”他如形色外診簡摩上又說：“苔乃胃氣之薰蒸，五臟皆稟氣于胃，故可借以診五臟之寒熱虛實也”。

舌苔的分部 舌苔的分部有兩個方法，如吳坤安說，滿舌屬胃，中心亦屬胃，舌尖屬心，舌根屬腎，兩旁屬肝胆，四畔屬脾，這是以五臟來分的。又舌尖屬上脘，舌中屬中脘，舌根屬下脘，這是以三焦來分的。以上兩種分類方法，都為臨症所習用。

正常舌苔 一般常人的舌苔，舌鑑總論認為：“舌乃心苗，心屬火，其色赤，心居肺內，肺屬金，其色白，舌故當舌地淡紅，舌苔微白。而紅必紅潤內充，白必苔微不厚，或略厚有花。然皆干濕得中，不滑不燥，斯為無病之舌，乃火藏金內之象也。”此紅乃藏氣所蘊所發，白為津液所布所結耳。章虛谷亦說：“無病之人，當有薄苔，如草根者，即胃中之生氣也。”吳坤安又說：“平人舌中常有浮白

苔一层，或浮黄苔一层，夏月湿土司令，苔每較厚而微黄，但不滿不板滯。”以上各节，都是前人討論与舌苔有关的各种問題。

(二)舌和苔的变化

舌的形态 舌体宜柔和，不宜强硬。柔和为气液自滋，强硬乃脉絡失养。如浮而腫大为脹，其因或由水浸，或由痰溢，或湿热上蘊；薄而瘦小为癯，其因或由心虛，或由血微，或由內热消肉。如舌卷兼見囊縮，病入厥阴，每为死候。如舌腫滿口，不能轉动，謂之木舌；舌底重生一物，言語不清，飲食不下，謂之重舌。木舌、重舌，皆由心火熾甚使然。至于舌伸縮无力，是为气虛。时欲伸出口外，吐舌弄舌者，为心脾热結，若大病后見此，則为大凶。其舌伸而偏于一側者，又有两种关系；若色紫紅而勢急，为肝风发瘕；若色淡紅而勢緩，則属中风偏枯。战顫难言，属心脾气亏；掉动不已，是为肝风。舌痿軟而不能动者，須分久暴；暴痿多由热灼，久痿多由阴枯。舌伸出不收者，为痰涎上壅，若小儿病見此，乃心气耗散，是为險症。

荣枯老嫩 辨舌指南上說：“荣者，有光彩也，凡病皆吉；枯者，无精神也，凡病皆凶。荣潤則津足，干枯則津乏。荣者謂有神，神也者，灵动精爽，紅活鮮明，得之則生，失之則死。明潤而有血色者生，枯暗而无血色者死。”又說：“凡舌質堅斂蒼老，不論苔色黃白灰黑，病多属实；舌質浮胖嬌嫩，不拘苔色灰黑黃白，病多属虛。”

潤燥腐膩 辨舌指南上說：“滋潤者其常，燥澀者其变。潤泽为津液未伤，燥澀为津液已耗。湿症舌潤，热症舌燥，此其常也。然亦有湿邪傳入血分，气不化津，而反燥者；如热症傳入血分，而舌反潤者。”

刘吉人說：“腐与膩不同。腐者如腐渣，如腐筋，如豆腐堆鋪者，其过厚，为阳有余，能鼓胃中腐化濁气上升，故有此象；膩者，則中心稍厚，其边則薄，无毛孔，无顆粒，如以光滑之物刮一过者；亦有刮而不脫，滿积而干，而舌本尚罩一层粘液，此为厚膩之常苔，为阳气被阴邪所抑，必有湿濁痰飲、食积、瘀血、頑痰为病，宜宣化。”以上腐与膩对举，是說明腐与膩的不同現象。腐苔是松厚的，揩之可去，为正气將欲化邪；膩苔是板滯的，揩之不去，为穢濁之邪

未化。此外尚有“膿腐”与“霉腐”舌苔，与上面所說的腐苔又有不同。膿腐白帶淡紅，粘厚如瘡膿，多見于內癰等症，如肺癰多白腐，胃癰多黃腐，肝癰多灰紫腐；霉腐滿舌生白衣，或生糜点如飯子样，謂之口糜，此由胃体腐敗，津液悉化為濁腐，蒸騰而上，循食道泛于咽喉，繼則滿舌直至唇齒上下顎，皆有糜点，其病必難治。

舌苔的有根无根 章虛谷說：“无根者，表分濁气所聚，其病淺；有根者，邪气內結，其病深。有根之苔，分其厚薄松實，厚者邪重，薄者邪輕，松者胃气疏通，實者胃气閉結也。”

又辨舌指南上說：“至于苔之有根者，其薄苔必勻勻鋪開，緊貼舌面之上；其厚苔必四圍有薄苔鋪之，亦緊貼舌上，似从舌里生出，方為有根。若厚苔一片，四圍淨洁如截，頗似別以一物涂在舌上，不似舌上所自生者，是无根也。此必久病，先有胃气而生苔，繼乃胃气告匱，不能接生新苔，而旧苔仍浮于舌面，不能与舌中之气相通，即胃腎之气不能上潮以通于舌也。誤服涼藥傷阳，熱藥傷阴，乍見此象者，急救之犹或可复，若病勢纏綿日久，漸見此象，真气已索，无能为矣。”

以上兩节，論苔的有根无根。前一节，从有根无根辨病邪的淺深，是病在初期、中期的現象；后一节，从有根无根辨胃气的有无，是病到后期的現象。它們虽同是討論有根无根，却是針對两个不同病程和不同情况而言，我們应注意分別場合运用。

不同体質在舌苔上的差异 吳坤安說：“脾胃濕熱素重者，往往經年有白厚苔，或舌中灰黃。至有病時，脾胃津液為邪所郁，或因瀉利，脾胃气陷，舌反无苔，或比平昔較薄。其胃腎津液不足者，舌多赤而无苔，或舌尖边多紅点。若舌中有紅路一條，俗稱鷄心苔，血液尤虛。”

苔色的變換順逆 凡舌苔由白而黃，由黃而退，由退复生新薄白苔，此為順象。若舌苔由白而黃，由黃而灰，由灰而黑，由活舌變為死舌，此為逆象。驟退驟无，不由漸退，此為陷象。

(三)舌和苔的主病

(1)舌質

紅舌 舌紅主熱。舌紅而出血如衄，此為熱傷心胞；若紅而中

見紫斑，病將發斑。舌尖獨赤，為心火上炎；舌邊色赤，為肝胆有熱；舌心干紅，為胃陰已傷。若光紅柔嫩無津，謂之鏡面舌，由汗下太過，元津耗極於內。如舌質鮮紅，在溫病為熱甚；在虛勞為陰虛。若淡紅無色，為心脾氣血素虛；若更干而色不榮，則為胃中津氣兩傷，無以化液上潤；若舌淡紅而中見赤點，為病將發黃。

絳舌 絳為深紅色。邪熱傳營，舌色必絳。如初傳絳色，中兼黃白色苔，此氣分之邪未盡。若純絳鮮澤，則為包絡受病；絳而有碎點黃白色，病當生舌疳（舌上碎爛而不收口）；絳而有大大紅點，為熱毒乘心；若絳而光亮（鏡面舌），為胃陰已亡；若色絳不鮮，干枯而萎，為腎陰已涸。舌尖獨絳，此心火上炎；絳而中心發干，乃心胃火燔，劫燬津液。又舌絳望之若干，手捫之原有津液，此乃津虧而濕熱薰蒸，將成濁痰，蒙閉心包；舌絳而上有粘膩，似苔非苔，乃中挾穢濁之氣。

紫舌 紫舌應注意有苔無苔。舌紫而中心有白滑苔，為醉后傷寒；若舌紫而黃苔干燥，為臟腑素熱，脾胃尤甚。若舌紫而腫大，為酒毒沖心；舌紫而色暗晦，為瘀血蓄積；若青紫滑潤，為直中肝腎陰証。

藍舌 藍舌亦須分別有苔無苔。若舌質藍色，而尚能生苔的，是臟腑雖傷未甚，猶可醫治；若光藍無苔，不論何脈，皆屬氣血極虧，病極危險。又有藍色微而不滿舌的，在瘟疫和濕溫熱都不解的時候，可見此舌，治宜芳香清泄；濕痰、痰飲症，亦有苔滿滑膩，中見藍色的，為陰邪化熱之候，治宜清化。

(2) 舌苔

白苔 白苔主表証。薄白而滑，為外感風寒；白滑粘膩，為內有痰濕；白苔絳底，是濕遏熱伏；白而邊紅，是風溫入肺；光白根黃，是為津傷濁結；舌白嫩滑，刮之明淨，屬里虛寒；白如積粉，為溫疫穢濁甚重；白苔如碱，為胃中宿滯夾穢濁郁伏。

黃苔 黃苔屬里症。微黃而不甚燥，為邪初傳里；深黃而見滑膩，為濕熱交阻于中；苔黃而干，是邪雖外解，火已內熾；舌苔黃聚，為陽明實熱，可下之症；若黃燥而生黑刺，或中有裂紋，是熱結已深，氣陰均耗。其有色如姜黃，或淡松花色，色黃而淡，津潤而冷，

又皆阴衰土败之征，病属难治。

灰苔 灰苔即黑苔之轻者，有阴阳之异，寒热之辨。如直中阴经，即时舌便灰黑，而无积苔；若传经热症，则有灰黑干苔。又如面黑舌灰，其人如狂，或瞑目谵语，亦有不狂不语，不知人事的，此为蓄血症。又淡淡灰色中间有滑苔四五点如墨汁者，为邪热传里，兼有宿食未化；若见灰黑而滑润，此又寒水侮土，系太阴中寒证。

黑苔 黑苔亦有阴阳虚实之分。若白苔中心渐黑，伤寒邪热传里之候；若红舌中心渐渐变黑，为湿热瘟疫传变坏症之兆。黑而滑润，是水来尅火，阳虚而阴寒盛；黑而燥裂，是火极似水，热熾而津液枯。若舌苔根黑而燥，为实热结于下焦，急宜下之；舌根无苔，惟尖黑燥，为心火自焚，不可救药。若起病发热胸闷，遍舌黑色而润，无他险恶症状的，乃胸膈素有伏痰，不必张皇。又舌苔黑滑，为太阴寒水侮土；黑滑粘腻，为湿痰寒饮伤脾。

(3) 驗舌决死生法 死生的判断，决定于全身证候，历代記載，已頗明备，然佐以驗舌，則尤显而易見。今采擇前人素所經驗者，附載于此，以为临症之一助。

舌如去膜猪腰子者危。

舌如鏡面者危。

舌糙刺如沙皮而于干燥裂者危。

舌斂束如荔枝肉而絕无津液者危。

舌如火柿者危。

舌如烘糕者危。

✓ 舌光无苔，胃气絕也，不治。

舌卷而囊縮者不治。

舌本强直，轉动不活，而語言蹇澀者危。

舌起白苔如雪花片者，脾冷而閉也，不治。

舌因誤服芩連而現出人字紋者，不治。

(四) 察舌时应注意的几个問題

(1) 观舌苔的几个步骤 观察舌苔，大致有这样几个步骤：一、舌色，二、舌質，三、舌尖，四、舌心，五、舌边，六、舌根，七、潤燥，八、变换情况。如此一一注意，可以了解全面。

(2)飲食和染苔 辨舌指南上說：“凡病人欲察舌之時，宜先診而后食，則苔之厚薄易分；診而后飲，則苔之滑澀易辨。”

王孟英說：“食橄欖能黑，食枇杷白苔能黃之類，皆不可不知也”，脈理正義也說：“凡見黑苔，須問曾食酸物及甜咸物否，能染成黑色，非因病而生也；然潤而不燥，刮之即退為異耳。此等苔，惟虛証津潤能染；若內有實熱，舌即生苔而燥，又何能染及耶？”

(3)傷痕和夜間察舌 叶天士說：“舌苔不燥，自覺悶極者，屬脾濕盛也；或有傷痕血跡者，必問曾經搔挖否，不可有血而便以為枯症，仍從濕治可也。”王秉衡說：“燈下看黃苔，每成白色”，以上情況，临床上均宜注意，以免誤認病情。

(4)特殊舌苔的診察 叶天士說：“不拘何色，舌上生芒刺者，皆是焦熱極也，當用青布拭冷薄荷水揩之，即去者輕，旋即生者險矣。”辨舌指南說：“至于干黑之舌，又當以蜜拭其苔垢，然后觀其形色，紅赤者可治，青黑者不可治，亦望舌之所宜知也。”

附錄 1 妊娠傷寒辨面色舌色法：

面以候母，舌以候子。色澤則安，色敗則死。面赤舌青，母活子死；面青舌赤，母死子活；面舌俱赤，母子皆活；面舌俱青，母子皆死。如舌太赤，胎雖不死，須防其墮，急宜清熱安胎；如舌苔太重而焦黃，里症全俱，宜于清營安胎之中合以攻下，不可因循致誤。

附錄 2 吳坤安察舌辨証歌（摘自曹炳章“辨舌指南”）：

六淫感症有真傳，臨証先將舌苔看，察色分經兼手足，營衛表里辨何難。

白苔主表，黃苔主里，足經之邪，分表里治之；白苔主衛，絳苔主營，手經之邪，分心營肺衛治之。 邵仙根評

凡診察傷寒，當先察舌之形色，分別足經手經、衛分營分、在表在里，再參脈証施治，無不獲效。若拘定足六經治病，非但無效，且病亦鮮有合乎六經者。

白肺絳心黃屬胃，紅為胆火黑脾經，少陰紫色兼圓厚，焦紫肝陽明又青。

此條統論手經足經，以舌之形色辨之。 邵仙根評

此以形色分六經，兼心、肺兩手經。足六經不言太陽者，以太陽

初成，舌未生苔也。故凡临症見舌无苔而潤，或微白而薄，即是太阳。若黄苔阳明，紅色少阳，黑苔太阴，紫色少阴，焦紫厥阴阳邪、青滑厥阴阴邪。

太阳与肺同主表，邪尚在表，故舌无苔而或薄白。 邵仙根評

表白里黄分汗下，絳营白卫治分岐，次將津液探消息，泽潤无伤澀已亏。

白苔属表，当汗；黄苔属里，当下。絳苔营分之热，宜清忌表；白苔卫分之邪，宜汗忌清。治法天淵。再以舌之燥潤，驗其津液之存亡，不拘何色，但以潤泽为津液未伤，燥澀为津液已耗；热病以存津液为主，故宜深察。

白为肺卫仍兼气，絳主心营血后看，白内兼黄仍气热，边紅中白肺津干。

凡外邪之入，先到卫分，不解，然后入气分而营分，不解，然后入血分。白内兼黄，仍属气分之热，不可用营分药；白苔边紅，此温邪入肺，灼干肺津，不可辛温过表，清輕凉散为当。

卫邪可汗宜开肺，气分宜清猛汗难，入营透热羚羊妙，到血未清地与丹。

凡舌苔白潤而薄，邪在卫分，可汗。开肺即是开太阳，如麻黄、羌活之类。如苔白而厚或兼干，是邪已到气分，只宜解肌清热，如葛根、防风、連翹、蟬蛻、薄荷之类，不可用辛温猛汗也。若寒邪化热，过卫入营，或温邪吸入，竟入营分，則舌苔紅絳而燥，惟羚羊为妙品，以能透热于营中也。邪在营分不解，漸入血分，則发热不已，宜清血分之热，鮮生地、丹皮之类。

白黄气分流連久，尚冀战汗透重关，舌絳仍兼黄白色，透营泄卫两和間。

凡舌苔白中帶黄，日数虽多，其邪尚在气分流連，可冀战汗而解。若舌紅絳中仍帶黄白等色，是邪在营卫之間，当用犀、羚以透营分之热，荆、防以泄卫分之邪，两解以和之可也。

此条是泄卫透营之要法，惟荆、防不如薄荷、連翹之穩。 邵仙根評

白而薄潤风寒重，温散何妨液不干，燥薄白苔津已少，只宜凉解肺家安。

此辨风寒与风热治法不同。凡风寒初入太阳，则舌无苔，或生苔白润而薄，此寒邪重，津液不亏，辛温汗之可也。如白苔虽薄而燥，或舌边舌尖带红，此风热之邪伤于气分，病在手太阴肺经，津液已少，不可过汗，只宜轻清凉解气分，如前胡、苏子、杏仁、连翘、黄芩、薄荷、桔梗、淡竹叶之类。

苔若纯黄无白色，表邪入里胃家干，更验老黄中断裂，腹中满痛下之安。

舌苔纯黄无白，邪入胃经，热而未实，宜白虎等汤清热凉润。若焦黄断裂，热入胃府而燥实，症必腹满坚痛，故可下之。邵仙根评

凡治病先要辨清营卫表里，上文辨营卫，此论表里。然表症即属卫分，故此专论里症。伤寒由表入里，故舌苔先白后黄，至纯黄无白，邪已离表入里，即仲景所云胃家实也。然舌苔虽黄，而未至焦老裂纹起刺，大便虽闭，而未至痞满鞭痛，尚属胃家热而未实，宜清不宜攻，必再验其舌形黄厚焦老，中心裂纹或起刺，腹中鞭满胀痛，方用承气，下之则安。舌中心属胃，凡肠中有燥屎，舌中心必有黄燥、黑燥等苔。若腹无鞭满耕痛之状，亦只须养阴润燥，不可妄用承气攻之。

二条论外邪，以舌之黄白分表里。惟舌燥有津亏邪实之不同，须分别施治。邵仙根评

太阴腹满苔粘腻，苍朴陈苓湿结开，黄燥还兼胸痞满，瀉心陷胸二方裁。

湿邪结于太阴，症必胸腹满闷，湿阻气机，宜以苦温开之。若痰热湿邪结于心下，而痞痛者，邪滞中宫，宜瀉心、陷胸以开痞滌痰。邵仙根评

阳明实满，舌苔老黄燥裂；太阴湿满，舌苔白而粘腻。阳明实满，满及脐下少腹；太阴湿满，满在心下胃口。

此数语辨症确切，当熟记之。邵仙根评

湿邪结于太阴，则胸腹满闷，宜苦温以开之，苍、朴、二陈、二苓之类。若黄苔而燥，胸中痞满，此阳邪结于心下，按之痛者，热痰固结也，小陷胸法；嘔噦溺澀者，湿热内结也，瀉心法。

微黄粘腻兼无渴，苦泄休投开泄安，热未伤津黄薄滑，犹堪清热透肌端。

病有外邪未解而里先結者，如舌苔粘膩微黃、口不渴飲、而胸中滿悶是也。此濕邪結于氣分，宜白薤、橘紅、杏仁、郁金、枳殼、桔梗之類，開泄氣分，使邪仍從肺衛而出，則解矣。不可用瀉心苦泄之法，逼邪入里。黃苔虽主里，如苔薄而滑者，是熱邪尚在氣分，津液未亡，不妨用柴、葛、芩、翹或梔、豉、翹、荷之類，輕清泄熱以透表邪，亦可外達肌分而解也。

濕留氣分治粘膩，小溲如淋更快聯，濕結中焦因痞滿，朴陳苦溫泄之安。

此以粘膩舌苔為濕邪之驗，白而粘膩者寒濕，黃而粘膩者濕熱。更驗其小便不利、大便反快，為濕邪痞滿，乃濕邪結于中焦，宜厚朴、蒼朮、二苓、二陳之類，苦溫以開泄之。若舌黃粘膩，痞滿嘔噦，大小便俱不利，此濕熱結于中焦，宜瀉心法之類，苦辛寒以開泄之。

上焦濕滯身潮熱，氣分宜通病自痊，濕自外來肌表著，秦艽蘇桂解肌先。

凡看舌苔，或白或微黃，而粘膩不渴者，總屬濕邪。但濕自內出，恒結于中焦而成痞滿。若濕自外來，上焦氣分受之，每見潮熱自汗，醫者表之不解，清之不应，不知熱自濕中來，只要宣通氣分，如淡豆豉、茯苓皮、滑石、半夏、豬苓、米仁、廣皮、白薤、黃芩之類，氣分濕走，熱自止矣。若冒雨露，濕邪留于太陰衛分之表，發熱自汗不解，口不渴飲，身雖熱不欲去衣被，舌苔灰白粘膩，宜桂枝、秦艽、紫蘇、茯苓皮、二陳、姜皮之類，解肌和表，濕邪自去。

濕熱久蒸成內著，厚黃嘔吐瀉心求，若兼身目金黃色，五苓梔柏共茵煎。

濕熱內著，從飲食中得之，嗜酒人多此。苔必厚黃粘膩，痞滿不飢，嘔吐不納，惟瀉心最效，川連、干姜、赤苓、半夏、枳實、茵陳、通草之類。濕熱內結，若誤治必致成疸，宜五苓加茵陳、梔、柏之類。

舌絳須知營分熱，犀翹丹地解之安，若兼鮮澤純紅色，胞絡邪干菡萏攢，素有火瘻成內閉，西黃竺貝可加餐。

舌絳為邪入營中，宜泄營透熱，故用犀角以透營分之熱邪，翹、丹、

鮮地以清營分之熱邪。邪入心包絡，則神昏內閉，須加廣郁金、石菖蒲以開之。若兼有火痰，必致痰潮內閉，更當加西黃、川貝、竺黃、竹瀝之類，清火豁痰。

心承胃灼中心絳，清胃清心勢必殘，君火上炎尖獨赤，犀角導赤瀉之安。

如黃苔中心絳者，心受胃火蒸灼也，于清胃藥中加清心藥（如石膏、川連之類是也），其勢必孤矣。如舌尖獨赤起刺，心火上炎之故，犀角合導赤散以瀉之。

若見邊紅中燥白，上焦氣熱血無干，但清膈上無形熱，滋膩如投却疾難。

涼膈散去芒硝、大黃，加石膏，能清膈上無形客熱。其邪不在血分，妄投滋膩，必增病矣。

舌苔邊紅中心燥白，乃上焦氣分無形之熱，其邪不在血分，切勿妄投滋膩血分之藥，宜輕清涼解為治。 邵仙根評

絳舌上浮粘膩質，暑兼濕穢欲蒸痰，恐防內閉芳香逐，犀珀蒼蒲滑郁含。

暑蒸濕濁則成痰，暑濕兼穢，恐蒙閉心胞，故用菖蒲、郁金，借其芳香逐穢，犀角以透營分暑邪，琥珀、滑石清暑利濕。

舌絳粘膩上浮，暑濕醱蒸痰濁蒙閉心胞也，急用芳香逐穢、宣透滌痰之法，痰多可用西黃、天竺黃之屬。 邵仙根評

白苔絳底因何故，熱因濕伏透之難，熱毒乘心紅點重，黃連金汁亂狂安。

舌苔白底絳者，熱因濕邪遏伏，宜泄濕以透熱，如犀角、滑石、茯苓皮、豬苓、米仁、茵蘆、黃柏之類。若濕溫症，舌現紅星点点，此熱毒乘心，必神昏譫語，宜苦寒之品治之，狂亂者非黃連、金汁不解。如無金汁，以人中黃代之。

黃連清心火，金汁解熱毒。 邵仙根評

舌絳碎生黃白點，熱滯濕鬱欲生疳，古名狐惑皆同此，雜症傷寒仔細探。

舌碎絳而有黃白腐點者，此濕熱邪毒蘊久不宜，蒸腐氣血，化為痰濁，得風木之氣化而成虫也。 邵仙根評

狐惑即牙疳、下疳之古名也，近时惟以疳名之。牙疳即惑也，蝕咽腐齦，脫牙穿腮破唇；下疳即狐也，蝕爛肛阴，由伤寒余毒与湿露为害。若胃强能食，能任苦寒重药者，可治。按狐惑虫証也，上唇有瘡，虫食其臟，兼咽爛为惑；下唇有瘡，虫食其肛，兼声啞为狐。面色乍白乍黑乍赤，惡聞食气，情志默默，此其候也。

此參准繩与金匱之言相同。又云狐惑虫病也，惑当作蛾。看其上唇内生瘡如粟，唾血，心内懊憹而痛，此虫在上，食其五臟；下唇内生瘡者，其人不寤，此虫食下部是也。金匱蝕于上部則声啞，甘草瀉心湯；蝕于下部則咽干，苦參湯洗之。蝕于肛者，雄黃薰之。邵仙根評

舌絳不鮮枯更萎，腎阴已涸救之难，紫而枯晦凋肝腎，紅澤而光胃液干。

舌形紫晦如猪肝色，絕无津液者，为枯；舌形斂縮，伸不过齿，为痿。此肝腎已敗，不治。若舌色紅澤而光，其色鮮明者，属胃阴干涸，犹可滋养胃阴，甘凉純靜之品主之，如鮮生地、鮮石斛、蕉漿、梨汁之类。

黃苔方知邪入里，黑兼燥刺热弥深，屢清不解知何故，火燥津亡急救阴。

舌苔黑燥，为阳明之热，腹无痞滿鞭痛，非承气症，只宜清解。若清之不应，是腸中燥火与热邪固結，胃土过燥，腎水不支，胃中阴液已干，宜大小甘露飲以救胃汁。阴液充溢，阳邪自解，二便自通。

黑滑太阴寒水侮，腹疼吐利理中宜，更兼粘膩形浮胖，伏飲凝痰开逐之。

舌苔黑滑，为太阴之寒，所謂寒水侮土，理中症也。若兼粘膩浮胖，是湿痰寒飲伏于太阴，当用溫药和脾，如二陈、厚朴、姜汁合五苓之类，开之逐之，痰飲自去。

舌見边黃中黑膩，热蒸脾湿痞难禁，吐嘔便閉因伤酒，开泄中焦有瀉心。

胃热蒸脾湿，則舌黃中帶黑膩，中焦痞滿嘔吐，小便不利，嗜酒人多此症。

舌苔边黃中心黑膩，是胃热蒸动脾湿，蘊結中宮，以致痞滿嘔吐便閉，用瀉

心湯开泄中焦。 邵仙根評

寒湿常乘气分中，风兼二气自从同，重將黃白形中取，得訣才將脉症通。

寒湿二气，都入气分，风兼寒湿，亦入气分。风兼溫熱，或入气分、或入营分矣。气分之邪，于舌苔之黃白取之；营分之邪，于舌苔之紅絳取之。得此要訣，再將脉症兼參、病无遁形。

溫邪暑熱走营中，兼入太阴气分同，吸受心营并肺卫，暑溫挾湿卫营通。

溫暑二气，常入营分，兼入气分。蓋溫暑都从口鼻吸入，則上焦先受，故或入心营，或入肺卫，或先卫后营。惟湿邪常走气分，必暑挾湿、湿挾暑，則三焦营卫通入矣。

伤寒入里阳明主，热病阳明初便纏，先白后黃寒化热，純黃少白熱蒸然。

太陽主表，陽明主里。伤寒由表达里，故在表属太陽，入里即入陽明府病；热病自內达外，借陽明为出路，故初起即在陽明。但看舌苔，先白后黃者，伤寒由表达里；寒化为热也。若初起純黃少白，或黃色燥刺，是病发于陽明，由里出表，熱勢蒸然內盛也。

更參外症，初起惡寒发热为伤寒，壯熱无寒为热病。

热病无寒惟壯熱，黃芩梔豉古今傳，惡寒发热伤寒症，发汗散寒表剂先。

凡溫熱之症，不可发汗，如仲景陽明病之梔豉湯，少陽病之黃芩湯，皆可通治。

此条亦伏气所发之热病，切不可辛溫发汗，宜用梔豉、黃芩等方，清解少陽陽明。若是伤寒，可用表剂发汗矣。 邵仙根評

少陽溫病从何断，舌絳須知木火然，目赤耳聾身熱甚，梔翹犀角牡丹先。

凡溫病热病，皆純熱无寒。热病发于陽明，溫病发于少陽。当从何法断之，但看舌苔黃燥为陽明热病，絳赤为少陽溫病。溫病宜用犀角、梔、翹、鮮地、丹皮之类，以解木火之郁，大忌汗散。

舌絳赤，外症耳聾目赤者，是溫病从少陽而发出也，当清解木火之郁，与伤寒少陽症之可用表散不同，故忌汗散。 邵仙根評

若是溫邪从上受，穹中吸入肺先傳，芩翹梔豉桑葉杏，氣燥加膏肺分先，邪入心營同胆治，再加玄麥郁蒼鮮。

溫邪从內發者，以少陽胆經治之。若因天時晴燥太過，其氣从口鼻吸入，則上焦心肺受邪，舌苔白燥邊紅，治在氣分；舌色鮮紅，治在營分。營分與少陽胆經同法，亦用犀角、丹皮、鮮生地之類，再加元參、麥冬、廣郁金、鮮菖蒲，以清心開穹也。

春時溫邪从口鼻吸入，受而即發，舌苔不燥者，邪先入肺也，从肺衛氣分治之。若舌鮮紅而絳，邪入心營也，治與少陽胆經同法，加入清心開穹之品。 邵仙根評

寒溫二氣前粗辨，暑濕相循病必纏，溫病已陳粘膩舌，只將暑症再提傳。

上文論傷寒溫病，以下言暑邪濕溫。 邵仙根評

暑傷氣分苔因白，渴飲煩嘔咳喘連，身熱脈虛胸又滿，無形氣分熱宜宣，薑皮貝杏通芩滑，梔豉翹心竹叶煎，或見咳紅荷葉汁，痞加朴薤郁金川。

此條暑傷氣分，治从肺衛。如肺氣郁，則暑邪逆入營中，故咳紅。 邵仙根評

暑入心營舌絳紅，神呆似寐耳如聾，溺淋汗出原非解，失治邪干心主宮，犀滑翹丹元地甌，銀花竹叶石膏同，欲成內閉多昏昧，再入牛黃即奏功。

暑熱之邪，上蒙清穹則耳聾，不與少陽同例，忌用柴胡；乘于胞絡則神昏，宜清心開閉。凡邪在手經，忌足經藥。

凡溫熱暑邪，由口鼻吸受，邪在手經，从三焦立法，忌用足經藥，此與治傷寒分別處也。 邵仙根評

暑混合邪空穹觸，三焦受病勢弥漫，脘悶頭脹多嘔噦，腹痛還防瘡痢干，梔豉杏仁芩半朴，銀花滑石郁紅安。

暑邪挾濕，从口鼻空穹觸入，則三焦氣分受病，頭脹脘悶嘔噦，此邪初入見症，其勢尚輕，故只用梔、豉等以清宣氣分，余如鮮枇杷葉、通草、淡竹叶之類，亦可加入。暑熱之邪，留于膜原則變瘡，入于腸胃則成痢，治宜隨症加減。

濕溫氣分流連久，舌赤中黃燥刺干，咯血毋庸滋膩入，耳聾莫作三

阳看，三焦并治通茹杏，金汁銀花膏滑寒，若得疹痧肌内透，再清痰火养阴安。

凡暑湿合邪，輕則气分微結，重則三焦俱病。清解不应，即属湿温重症。肺气不得宣暢，則釀成膿血；湿热上蒙清窍，則耳聾无聞。治当急清三焦，气分一松，則疹痧得以外达，再議清火清痰，漸入养阴之品。

苔形粉白四边紅，疫入膜原势最雄，急用达原加引药，一兼黄黑下忽忽。

凡时症初起，苔形粉白而厚，四边紅絳者，此疫症也。邪在膜原，其势最雄，頃刻傳变，診家不可輕視。吳又可用达原飲加引經表药，透之达之，如兼太阳加羌活、阳明加葛根、少阳加柴胡。如舌变黄燥色，乃疫邪入胃，加大黄下之；如变黑色，入里尤深，用承气下之。疫势甚者，其舌一日三变，由白而黄，由黄而黑，当速下之。

若見鮮紅純絳色，疫傳包絡及营中，清邪解毒銀犀妙，菖郁金黃溫暑通。

溫疫一症，治分兩途。但看舌苔白而黄、黄而黑者，疫邪自表达里，汗之下之可也；如見舌苔鮮紅絳色，此疫邪入于营分及包絡之間，汗下兩禁，惟宜清营解毒、逐穢開閉，如犀角、銀花、菖蒲、郁金、西黃、金汁、人中黃之類，与溫熱暑症治法相通。

溫邪時疫多斑疹，臨症須知提透宜，疹屬肺家風與熱，斑因胃熱發如茲。

此条溫暑斑疹，与伤寒發斑不同。疹屬肺經風熱，斑是胃家伏熱。時疫斑疹，兼有毒氣，均宜提透清解熱毒。 邵仙根評

疹斑色白松肌表，血熱如丹犀莫遲，舌白荊防翹薄力，舌紅切忌葛升醫。

疹斑發于气分，其色淡紅而白者，舌苔亦白，宜葛根、防風、蟬衣、荊芥、連翹、薄荷、牛蒡等，松肌解表。若見赤斑丹疹，邪在营分血分，舌必絳赤，宜犀角、連翹、鮮生地、人中黃、淨銀花等，透營解毒，大忌升、葛足經之药。

邵仙根云：白疹邪在气分，舌白淡紅，宜松肌达表，从肺卫清透；紅疹邪在

营分，舌苔絳赤，宜清营宜透。

凡属正虚苔嫩薄，淡红微白补休迟，厚黄腻白邪中蕴，诊者须知清解宜。

不拘虚寒杂症，正气虚者，其舌苔必娇嫩而薄，或淡红或微白，皆可投补。若见黄而白、厚而腻，总属内邪未清，不可遽进补药。邵仙根云：此条凭舌苔以验其虚实，分别宜清宜补之总诀。又云：以上三十九歌，皆察舌辨症之要法，語語的傳，可謂時病金針矣，后学当熟讀之。

二、四 肢

1. 手足 手足拘急，屈伸不利，为寒凝經脉。手足抽搐，角弓反張，为热深作瘕。半身不遂，肢弱无力，为癱瘓病。諸肢节疼痛，身体尪羸，脚腫如脫，为历节痛。足不能行，軟弱而不痛者为痿。通身肢节疼痛，行动牽强者为痺。

2. 掌腕 掌腕为整体的一个部分，从掌腕情况变化的观察，在某些場合，亦可以作为整体诊断的依据。这种方法，是繼承了古人“診尺”的精神，在临床上是有实用价值的。

观其肌之滑澀，以征津液之盛衰；理之疏密，以征营卫之强弱；肉之坚軟，以征胃气之虚实；筋之粗細，以征肝血之充饒；骨之大小，以征肾气之勇怯；爪之剛柔，以征胆液之淳清；指之肥瘦，以征經气之荣枯；掌之厚薄，以征藏气之丰歉。

3. 爪甲 气色白而消瘦，爪甲鮮紅，为气虚有火；爪甲色淡，为肺胃虚寒；爪甲蒼白，乃血虚色不能荣。又用指按病人指甲，以测病情吉凶。如按之白，放之回紅，虽久病可治；放之而紅仍不复，虽頓病亦凶。又如手足爪甲青黑者，是为死征。

4. 魚际 魚际是大指本节間的丰肉，診察魚际的絡脉，可以了解很多病情变化。如胃中有寒，則魚际絡青；胃中有热，則魚际絡赤；絡暴黑的，为痺症；其有赤有黑有青的，为寒热气；其青而短的，为少气。

5. 小儿指紋(图4) 指紋与寸关尺为同一血脉，故又名脉紋。驗看指紋为儿科中一个很好診察方法，常用于三岁以下的小儿。

茲叙述其运用意义如下。

(一)指紋三关：以两手食指內側三节为三关：初节为风关，次节为气关，三节为命关。

(二)看色：其紋色紅黃相兼，隱隱不显，为无病之象。紫属有热，紅属伤寒，黃为伤脾，黑为中惡，青主惊风，白主疳症。又小儿肌肤皤白，唇色慘淡，多属阳虛，指紋四时皆淡，虽有病亦只淡紅，淡青，淡紫而已；淡紅为虛寒，淡青为虛风，淡紫为虛热。此盖根本不坚，中气怯弱，無論新病久病，总归于虛，切不可攻伐剋削。若病邪过郁，荣卫阻滯，升降羈留，指紋推之澀滯，絕无流利之象，由痰食风热相搏，是为实症。

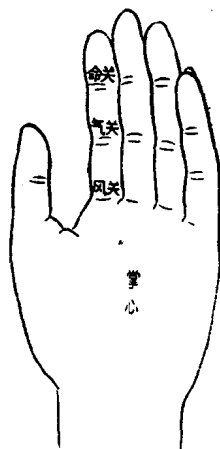


圖 4 指紋圖

(三)看紋：紋見风关主病輕，气关主病重，若过命关，主病危而难治。又紋向中指弯的，为內为順，为外感风寒；紋向大指弯的，为外为逆，为內伤痰食。紋直則热，紋曲則寒。紋多好比脉数，紋少好比脉迟。又凡有外邪在皮毛腠理之間，太淵脉浮，指紋亦显露于外，謂之表証；及邪入里，又淺深有別，若指紋半沉，邪在阳明胃經，指紋极沉，邪在阳明胃府。

(四)診指紋法：令人抱儿对立于向光之处，医者以左手握儿食指，以右手大拇指側面，蘸口津(或清水)，由命关推向气关风关，指紋愈推愈出，从而观察变化，推求病情。

三、皮 肤

1. 腫脹 凡腫脹之病，观察表皮变化，亦可加以区别。如皮厚色蒼的，多属于气；皮薄色泽的，多属于水。气为阳，阳性急，为脹速，每从上腫而漸下，得以安臥；水为阴，阴性迟，故为脹漸，每从下腫而漸上，更有咳嗽不得臥之征。

水气当分阴阳，症狀和治疗，是显然不同的。如阴水則肢厥体重，先腫下焦，繼則一身悉腫，阴股間寒，足脛腫甚，按之胛而不起，

口淡不渴，大便自調，小便虽少，却不赤澀；阳水則面浮惡風，自汗心煩，先腫上焦，遍身尽腫，按之熱而即起，口苦而渴，小便黃赤，大便堅燥，甚則二便不通。

金匱說：“諸有水者，腰以下腫，當利小便；腰以上腫，當發汗乃愈。病水腹大，小便不利，其脈沉絕者，有水，可下之。”

巢源水腫候：“唇黑傷肝，缺盆平傷心，臍出傷脾，足下平滿傷腎，背平傷肺，凡此五傷，必不可治。”

2. 發黃 面目及皮膚呈黃色，在傷寒為瘧熱在里，由于无汗或小便不利所致；在雜病為黃疸，其名很多，如金匱上有黃疸、酒疸、谷疸、女勞疸，巢源有急黃、行黃等等。一般在臨床上的歸納，大抵分作陽黃、陰黃兩大類。濕熱為患，其色明亮如桔子色，謂之陽黃；寒濕為患，其色暗晦如烟熏，謂之陰黃。

面色黧黑，每是黃疸的后期現象。事實上很多疸症延久不愈，是會變成黑疸的，不僅如金匱所載酒疸、女勞疸是如此。所以，巢源上說：“夫黃疸、酒疸、女勞疸，久久多變為黑疸，”這是一個比較深刻的觀察。

3. 出痘（表 12） 出痘，又名天花，這是一種烈性傳染病，小兒患此最多。在解放前，傳播很廣，死亡率也高，反動政府根本不加過問，任其蔓延。自從中華人民共和國成立以後，對衛生工作，首先採取了“預防為主”的方針，普遍免費接種牛痘，天花是已經基本消滅了。不過我們醫務工作者，還應提高警惕，嚴為防范。所以在这里作扼要介紹：

從望診來說，在痘症過程中，主要是觀察它的出沒、形色和分布情況，從而辨別吉凶順逆。如：

始出：形宜頂尖根圓，不宜隱如蚊咬。色欲如桃花滋潤，不欲淡白紫晦。

起脹：形宜漸綻充肥，不宜頂平不突，板實不綻。色欲頂漸放白，根紅光潤，不欲頂色灰滯，根血散漫，或地腳深紅。

成漿：形宜根紅斂束，痘壳完固，不宜壳軟皮薄，而致痒塌。色欲白而漸黃，蒼而濃厚，不欲灰干不潤，漿薄清稀。

結痂：形宜如螺壳，不宜如麩薄。色欲蒼如栗壳，不欲白如麩

色。

大凡形軟色白，为气血亏虛；紫黑凝滯，乃毒气壅盛。稀疏多順，密布多逆。头面、頸項、咽喉、胸背等处，更不宜密。至于手足則虽較多，尚不为凶。

至于水痘，临症上比較常見，家長們如少常識，每易誤認為天花，茲为便于正确掌握疫情起見，列表对照如下：

表 12 天花水痘对照表

病名 类别	天 花	水 痘
发 热	发高烧，头身剧痛，三四日才出痘。	不发高烧，一二日即出水泡。
布 痘	痘粒成对，一齐出現，大小齐等。	痘粒散見，陸續出現，大小不齐。
痘 形	痘粒頂上有凹陷（即痘臍），頂白根紅。	无臍，痘疱易破易干，泡水易出。
灌 漿	漿厚如膿、色渾濁，結厚痂。	漿薄如水，色晶瑩明亮，不結厚痂。
痘 痕	遺留痘痕。	不留痘痕。
历 程	經過時間較長，約二周以上，才收斂結痂。	經過時間較短，不过一周時間，即作痒收斂。
年 齿	儿童和成人都有。	几乎全属儿童。

4. 麻疹

（一）麻疹的一般情况：麻疹也是一种具有傳染性的病症。古人对此，已有正确的認識。如医宗金鑑所載：“疹非一类，有瘙疹、癰疹、溫疹，盖痘疹非正疹也；惟麻疹則为正疹，亦胎元之毒，伏于六府，感天地亢阳火旺之气，自肺脾而出，故多咳嗽噴嚏，鼻流清涕，眼泪汪汪，两胞浮腫；身热二三日或四五日，始見点于皮肤之上（按：自顏面而漸次布及軀干、四肢）。形如麻粒，色若桃花，間有类于痘大者，此麻疹初发之狀；形尖疏稀，漸次稠密，有顆粒而无根暈（按：疹与疹之間健康皮色明显），微起泛而不生漿，此麻疹見形之后，大异于痘也。”

(二)麻疹的出現、消退及色澤之順逆：麻疹的出現宜透徹，色澤宜紅潤。其消退，宜依出現之先後，漸次收沒。倘突然隱伏，神昏喘急，身熱不退，此為熱毒內攻逆症。其色淡紅而暗者，為風寒外閉；赤紫滯晦，為熱毒壅盛；白而不紅，又屬正氣虛陷，不能透達之象。

5. 斑疹

(一)斑疹的一般情況：在傷寒、溫病及瘟疫等症過程中，斑疹為一種常見的症候。有一病即見的，有因汗下失宜而見的；有斑或疹獨見的，有斑與疹互見的；都由於熱毒入於營血所發生。一般來講，凡傷寒發斑，多由於汗下失當；溫熱發斑，多由於應清失清；皆由邪遏於胃熱蒸成斑。惟溫毒、熱疫兩証必發斑疹，當其將發未發之際，首先辨其証候：如若汗若清若下後，邪仍不解，其人見壯熱無汗，胸膈煩悶，嘔噦，起臥不安，耳聾足冷，脈或沉伏，便是斑點欲出的先兆；及其現出，察看病人面部、背心、胸膛、四肢，有大紅點平鋪於皮膚上的叫斑，所謂有觸目之色，而無碍手之質，其形有稠如錦紋的，有稀如蚊跡的。若有小紅點高起於皮膚上的叫疹，其形有顆粒，或如粟粒。總之，斑形大而疹形小，斑與膚平而疹形高起，這是兩者的不同點。

(二)斑疹的輕重吉凶：出疹者輕，發斑者重；少見者輕，多見者重；色紅者輕，色赤者重，若色黑而晦者必死。赤色身煖，自胸腹散四肢者吉；黑色身涼，自四肢入腹者凶。發出宜神情清爽，是外解里和，為透泄佳兆；出而神志昏迷，是正不勝邪，為內陷凶象。又有色淡紅而稀暗，四肢微冷，口不甚渴，脈洪數（但無力），為虛斑，治宜溫補。又面赤足冷，下利清谷，此陰盛格陽，內真寒外假熱，郁而成斑，治宜桂附引火歸原。

6. 爛喉痧痧

(一)喉痧的一般情況：此病由溫厲之毒，吸入肺胃所致，故又名疫痧。其症憎寒壯熱，身如被杖，筋骨疼痛，胸悶口渴；而咽喉腫痛，尤為必見之候。其現瑣碎小粒者為痧；痧者，沙也，紅暈如泥沙而起，屬肺。其成片如云頭突起者為痧，痧者，丹也，或隱在皮膚之間。多起於手足身背之上，此胃府之熱滯外越也。

(二)病痧的色泽顺逆：色泽以淡红荣润为佳，深红较重，艳如胭脂为恶，半隐不透、肢体肤黑为逆。

7. 白痞 白痞系一种高出皮肤的白色小颗粒，内有晶滯水分，与疹不同；夏秋暑湿伏邪之証，每每見此。盖暑必夹湿，为粘膩之邪，湿滯卫分，汗出不彻所致，但亦为湿邪透泄的出路。此时观察白痞的色泽形态，頗有助于临床的診斷。大凡色白点細，形如肌粟，狀如水晶珠而明亮滋潤者佳；漿痞密布，又为湿毒熾盛。若病情淹纏迁延至二三候，邪未达而元气受伤，发出白痞，出无定期，热势壯則外見，緩則隱伏，甚至連发八九次，邪不达而身热不退者，由其人元气亏乏，不能化邪外出，治当养正生津，清暑滲湿，使正气充旺，則伏邪漸化而热得退。如病久痞色不鮮泽，粒不飽滿，为气液耗伤；若痞色干白如枯骨，大凶之証，津液气竭，邪欲外出，元气亦随之外散，为邪正并脫之候。

四、二 便

1. 大便 便溲色白，为腸中有寒；便溲色醬，为腸中有热。痢疾便如膿涕，色白病在气分，色赤病在血分；五色兼見，五藏受伤，病情至此，脾胃虛弱是主要关键。大便下血，色鮮紫者为热伤阴絡；稀淡者为脾虛。少腹鞭滿，小便自利，大便色黑，便出甚易，为有蓄血。

2. 小便 小便短澀而赤，为內热；清長过多，为气虛。伤寒小便清，知未傳里，邪仍在表；小便有血，为热在下焦。小便如粟狀，是为淋病；溺而飲水多，小便数，有脂似麋片甘者，为消渴病。

小 結

望診居四診之首，它在临症診斷上，頗有实用意义，因为祖祖輩輩的實踐，在这方面已有丰富經驗，非常可貴，我們应加以很好的学习和运用。

在临症时是怎样运用望診的？概括地說，是观察病人的神、色、形、态。因为神色是藏府气血显示于外的标誌，从神色的衰旺，可以知道藏府气血的虛实盈亏；形态是指病人在疾病过程中表现出

来的反常姿态,一定的疾病,会产生一定的形态。我們从这几方面去观察,可以获得它的总的概念,再从这个概念基础上,作有目的、有重点的进一步診察,就更能取得具体資料,有助于诊断,这就需要运用分部望診了。

在分部望診中,面目的色泽表情、舌質与苔的变化,是重要部分。在面目,是注意它的神色变化,浮沉上下,荣枯順逆。舌質是注意它的坚斂蒼老,浮肿嬌嫩;舌苔是注意它的潤燥腐膩,厚薄松实等等。若診小儿时,对指紋的观察,如浮沉以分表里,淡滯以定虛实,内外以觀順逆,都有一定的参考价值。至于腫脹在皮肤的表现,如气脹、水腫、阴水、阳水的鑑別,以及水腫的五不治症,也是紧要的。黄疸主要是观察它的明亮与暗晦,以別其为阳黄、阴黄。麻疹斑疹痧痧,主要是注意它的形状和色泽,以及出沒的变化,不仅有助于鑑別,且可以作预后吉凶的判断。至于大小二便,虽属人体所排除的廢物,但它的顏色以及溏硬如何,有无油脂粟粒,也足以証明某些藏府的病变情况,在诊断上都有相当价值。

有关望診的材料,以上是介紹了一个大概。其中以面色和舌苔比較更为重要,在临床上应该很好注意。其余各节,也都有它的一定价值,均宜加以領会掌握,适当运用。这样,在实际工作中是可以获得很多帮助的。

复 習 題

1. 神色是什么?怎样观察神色?
2. 怎样从形态的变化来了解疾病?
3. 舌和苔在诊断上有什么重要意义?它有那些变化?
4. 斑、疹、疖、痧怎样辨别?

第二节 聞 診

聞診,在四診中,也是重要的一环,自素灵以下,及历代先哲,莫不注意研究。难經說:“聞而知之者,聞其五音,以別其病。”王秉衡又說:“聞字虽从耳,而四診之聞,不專主于听声也。”所以聞診范围,不仅限于耳聞,还应扩展到鼻嗅。因此我們也把聞診分为两个

部分。属于听觉所感到的，为声音；属于嗅觉所感到的，为气味。通过我們的听觉和嗅觉，来分別声音和气味的正常或异常，再結合其他診察方面所获得的資料，加以分析和綜合，而后可以得出明确的診斷。

甲、声 音

一、声音的一般情况

医宗金鑑說：“凡万物中空有窍者，皆能鳴焉，故肺象之而主声也。凡发声必由喉出，故为声音之路也；必因会厌开合，故为声音之門戶也；必借舌为宛轉，故为声音之机也；必資之于牙齿唇口，故为声音之扇助也。五者相須，故能出五音，而宣达于远近也。”这是声音所以产生的大略。此外尚有腸鳴、尿气、阴吹正喧，亦都有声，它的产生机轉，又不可以和上文一概而論了。

1. 五声五音与五藏四时的配合 祖国医学的特点，是“天人合一”的整体观念。这是由于認識了人生在天地之間，自然界一切，与人息息相关，自然界是时刻在发展变化着的，人身也与之适应，时刻发展变化着。內經上的五声五音与五藏四时相配合，也就是反映和說明了这些問題。如六节藏象論上說：“天食人以五气，地食人以五味。五气入鼻，藏于心肺，上使五色修明，音声能彰。”这就說的很明显了。現在把这种配合，介紹如下：

肝属木，象春，其德为和（張介宾注：春阳布和），其音为角（王冰注：調而直）。

心属火，象夏，其德为显（張注：阳象明显），其音为征（王注：和而美）。

脾属土，象長夏，其德为濡（張注：濡潤泽物），其音为宫（王注：大而和）。

肺属金，象秋，其德为清（張注：秋气清肃），其音为商（王注：輕而勁）。

腎属水，象冬，其德为寒（張注：冬令寒冷），其音为羽（王注：深而沉）。

金鑑又把五音的发展及其声韵，作了淺显的描述，有助于我們

的理解。它說：“五藏各有正聲，必合于五音也。如舌居中，發音自喉出者，此宮之正音也；其聲極長極下極濁，有沉洪雄厚之韻，屬土，入通于脾。開口張腭，音自口出者，此商之正音也；其聲次長次下次濁，有鏗鏘清肅之韻，屬金，入通于肺。撮口而發，音自唇出者，此羽之正音也；其聲極短極高極清，有柔細尖利之韻，屬水，入通于腎。以舌點齒成音者，乃徵之正音也；其聲次短次高次清，有抑揚咏越之韻，屬火，入通于心。內縮其舌而成音者，乃角之正音也；其聲長短高下清濁相和，有條暢中正之韻，屬木，入通于肝。此五藏不病之常音也。”

2. 情志的變音 肝志為怒，發聲為呼；心志為喜，發聲為笑；脾志為思，發聲為歌；肺志為憂，發聲為哭；腎志為恐，發聲為呻。

又喜感于心，則其發聲必忻悅以散；怒感于心，則其發聲必忿急而厉；哀感于心，則其發聲必悲悽以嘶；樂感于心，則其發聲必舒暢而不迫；敬感于心，則其發聲必正直而肅歛；愛感于心，則其發聲必溫柔以和。醫者在臨床之際，于此能够比類而推，熟悉了不病的聲音，也就可以認識有病的聲音了。

3. 體質不同的變音 金鑑上說：“若夫喉有寬隘，寬者聲大，隘者聲小。舌有銳鈍，銳者聲辨，鈍者不真。會厭有厚薄，厚者聲濁，薄者聲清。唇亦有厚薄，厚者聲迟，薄者聲疾。牙齒有疏密，疎者聲散，密者聲聚。五者皆無病之聲音，乃形質之稟賦不同也。以此推之，在喉、在會厭、在舌、在齒、在唇之當有別也。”

4. 怎樣掌握聞診 醫門法律上說：“聲者，氣之從喉舌而宣于口者也。新病之人聲不變，小病之人聲不變，惟久病苛病，其聲乃變。迨聲變，其病機显呈而莫逃，所可聞而知之者矣。經云：聞而知之謂聖，果何修而若是？古人聞隔垣之呻吟叫哀，未見其形，先得其情，若精心體驗，積久誠通，如瞽者之耳偏聰，豈非不分其心于目耶。”所謂“精心體驗”，所謂“積久誠通”，這是掌握聞診工作的唯一關鍵，值得我們深切注意的。

以上對聲音的幾個基本問題，作了一些介紹，使我們在聞診的臨床工作上，知常知變，心中可以首先有個概念。至于有關具體問題，分述如下：

二、語 言

1. 辨外感內傷 外感有余之証，寒熱并作，語聲重濁，前輕后重，高厉有力；內傷不足之証，寒熱間作，口鼻中氣短，少氣不足以息，困倦，語言先重后輕，氣怯聲低。

2. 辨寒熱虛實 陽候多語，屬熱；陰候無聲，屬寒。發言壯厉，屬實；發言輕微，屬虛。又怒罵叫号，奔走不定，謂之“狂言”；語無倫次，數數更端，謂之“譫語”。這都属于實証熱証，每于傷寒胃實、蓄血、狂疾及溫病邪入心包時見之。無人則言，見人則止，謂之“獨語”；一事一語，頻頻諄復，謂之“鄭聲”。睡則多言，喚醒則止，謂之“睡中呢喃”；出言不正，旋自知非，謂之“錯語”。若言聲微小，欲言不能復言，此為奪氣。這些症狀，每每由于心氣虧虛，神失所舍，宜從虛証論治。

又如大人卒中，小兒驚風，神志昏迷，牙關緊閉，則不知言語。風非，神志不亂，而舌強舌短，言語蹇澀。又如悲傷欲哭，狀如神靈所作，是為婦人藏躁症。這些病情，虛實寒熱，又當參合其他形証加以決斷。

三、呼 吸

常人的呼吸氣息是平和的。若口鼻的氣發粗而疾出疾入的，多是外感邪氣；口鼻氣微而徐出徐入的，多屬內傷正氣不足。氣粗是呼吸有力而不和平，每于陽明熱甚時見之，其病多在肺胃兩經。氣微是呼吸低微，主諸不足，常見于熱病已愈正氣未復的時候；若在雜病，以失血最為顯著。因此呼吸的或太過或不及，都是病理變化的反映，在這方面亦有很多應該注意之點，如：喘、哮、上氣、短氣等等，都應當運用聞診的方法來深刻了解病情的寒熱虛實。現在分別介紹如下：

1. 喘 主要為呼吸困難，故張口抬肩，不得平臥。其呼氣與吸氣的長短，大致相等；呼吸次數有增多的，亦有不增多的。在臨床，喘有虛實的分別。

(一) 實喘：其來驟，其脈實，其人強壯；其喘則肺脹氣粗，聲高

息湧，膨膨然若不能容，惟以呼出为快。

(二)虚喘：其来徐，其脉虚，其人倦怠，或因病后，或因咳久；其喘慌张气怯，声低息短，提之若不能升，吞之若不相及；劳动则甚，急促似喘，但得引长一息为快。

实喘有属实、属热和在肺、在胃的不同，虚喘有在中、在下和属脾、属肾的分别，均应考究它的原因，随证施治。

2. 哮 其病似喘，但不如喘的出气之多，而且有呀呷之音，呼吸出入有声。多由初感外邪，失于表散，留于肺俞，因而频发频止，淹绵岁月。此中又有痰哮、盐哮、醋哮（俗有糖哮）等分别。

3. 上气 邪气与正气相搏，正气不得宣通，但逆上咽喉之间，气道窒塞，呼多吸少，气息急促，是谓上气。有因胸膈痰湧而上气的，如金匱的咳逆上气、时时唾濁、但坐不得眠的皂莢丸症；有因阴虛火炎而上气的，如金匱的火逆上气、咽喉不利、止逆下气的麦門冬湯症；又有外邪束于皮毛、肺气不舒而上气并腫的，如巢源的上气腫候——“肺主于气，候身之皮毛，而气之行，循环于藏府，流通經絡。若外为邪所乘，则肤腠闭塞，使气内壅，与津液相并，不得泄越，故上气而身腫也”。

4. 短气、少气 呼吸虽数，而不能接續，似喘而不抬肩，似呻吟而无痛楚，呼吸急而无痰声，是谓短气。有因里实而短气的，如伤寒論阳明病的“短气腹滿而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也”；有因留飲而短气的，如金匱的“胸中有留飲，其人短气而渴，四肢历节痛，脉沉者，有留飲”；有肺虛而短气的，如巢源論的“肺虛則气少不足，亦令短气，則其人气微，常如少气，不足以呼吸；診其脉寸口俱微，血气不足，其人短气”。

少气由于藏气不足，表现为呼吸微弱，言語低微，不能报息，大抵久病重病虛弱者，多見此症。

5. 鼻煽 鼻孔弛張不已，可以一望而知。若單有气急不兼鼻煽，不一定是危証；若气急兼鼻煽，則多数是危險，虑其肺藏窒塞。

6. 鼻鼾 卒中而見鼾声，为风邪中藏的標誌，其証多不治；若鼻鼾而語言难出者，則又为风溫之候。

关于呼吸方面，大致有上述种种情况。但在临床上，每多相

混，不可能截然分明。如喘可以兼上气，短气也可以兼少气。这在古書里是常常可以遇到的，如金匱“上气喘而躁者，属肺脹”、巢源“肺虛則气少不足，亦令短气”等等，就是例証。他如金匱“吸而微数，其病在中焦，实也，当下之則愈，虛者不治。在上焦者，其吸促。在下焦者，其吸远。”这是又以吸的“促、远、微数”，以驗病之在上在中在下。所有这些情况，我們在临床上，都应參酌其他形証，掌握它的寒熱虛实，隨証論治。

四、咳 嗽

1. 咳嗽与藏府的关系 咳嗽一症，一般來講，它与肺的关系，最为密切，所以內經上說“肺为咳”。但它又說“五藏六府，皆令人咳，非独肺也”，則咳嗽之病，固然很多是肺藏疾患的表現，而其他藏府，即五藏六府的任何一藏一府，如有病變，亦能影响到肺，而令作咳。这个說法，是討論咳嗽比較全面的看法，對我們臨床診斷，是有很多啟發的。

2. 咳嗽在聞診上的鑑別 古人認為：有声无痰謂之咳，有痰无声謂之嗽，有声有痰謂之咳嗽。这是大略的說法，臨床之際，并不能如此截然分明，它的相互变化，还是很多的。茲舉數例如下：

咳嗽重濁而悶，痰清色白，鼻塞不通，其声并从口出，是为外感風寒；咳声不清，痰稠色黃，屢咳难出，咽喉干痛，鼻出熱气，此为肺伤于熱。

咳嗽陣作，发則連声不絕，謂之頓咳。其胸膈痰飲多者，嗽則气动于痰，上搏喉咽之間，痰气相击，随嗽动息，呼呷有声，謂之呷嗽。

因咳而有痰者，咳为重，主治在肺；因痰而致咳者，痰为重，主治在脾。

咳声嘶啞，有先伤于風，咳嗽未除，更伤于熱，因而咳嗽声嘶的，此为熱包寒；有素咳嗽之人，更感于寒，因而咳嗽声嘶的，此寒包熱。

失音須分久暴。暴病多为風寒客于会厌，痰湿壅滯肺絡；久病多为熱伤肺痿，血槁津枯。前者为金实則无声，后者为金破則不

鳴。又“綱目”稱瘡有二：一舌瘡，為中風舌不轉運之類；二喉瘡，為勞嗽失音之類。蓋舌瘡但舌本不能轉運言語，而喉咽音聲則如故；喉瘡則喉中聲嘶，而舌本仍能轉運言語。

五、嘔 吐

1. 嘔吐在聞診上的意義 有物有聲叫做嘔，有物無聲叫做吐，有聲無物叫做干嘔。嘔、吐和干嘔，因為有的有物，有的無物，所以發出的聲響是不同的，即使我們還沒有看到病人，只要聽到它的聲響，就可以知道是嘔是吐，還是干嘔。一般而論，胃以降為順，不管嘔、吐或干嘔，都是胃氣上逆的現象。在聞診時，我們可以从嘔吐的微甚、聲響的強弱，而對疾病的輕重和病體的虛實，獲得一些概念。但是，嘔吐是一種症狀，能產生這一症狀的疾病很多，它的原因，也很複雜，所以有關嘔吐的許多問題，不可能從聞診上求得全部解決。因此，我們在臨床上，對嘔吐一症，應作多方面的探索和分析。

2. 常見的嘔吐疾病 嘔吐清水痰涎，舌苔白滑，脈小無力，此胃中有寒。嘔吐粘痰黃水，或酸或苦，苔黃脈大有力，此胃中有熱。反胃嘔吐，朝食暮吐，暮食朝吐，此脾腎俱虛，不能消谷。里實嘔吐，大便秘結，腹滿胸悶，此為腸有燥矢，穢濁上犯。傷寒表邪外遏，里氣不舒，則發熱惡寒，脈緊，體痛嘔逆。氣郁情志悵悵，肝失條達，則木來犯土。他如霍亂則吐利并作，飲家則先渴後嘔，肺癰吐膿，胃癰嘔膿等等，都可以從嘔吐見症，了解一部分病情。

六、呃 逆

呃逆是氣逆從咽沖出而發生的一種聲音。但呃逆的聲音，亦并不一樣，有高有低，有斷有續，這是由於它的成因不同，而這種不同，卻反映了病情的虛實寒熱。例如：呃逆連聲而有力的，屬於實熱，每見於傷寒失下，大便秘結，胃氣不降，上逆而呃；呃逆聲低怯，而不能上達於咽喉的，屬於虛寒，每見於瀉利日久，脾陽告衰，虛氣上逆之候；如果呃逆斷續不繼，半時方呃一聲的，大都出現在久病或熱性病的後期，這是胃氣已敗，最為危險，內經所說“病深者，其

声噦”“汗不出，大顙发赤，噦者死”，即指此类。一般而論，呃逆属实的可治，属虛的难治。

七、噯 气(噯)

噯气，就是飽食息。灵樞口問篇上說：“寒氣客于胃，厥逆从下上散，复出于胃，故为噯。”这段經文，是說寒氣客胃，因而作噯。至于伤寒論的“伤寒发汗、若吐、若下解后，心下痞鞭，噯气不除”、巢源的“谷不消則脹滿而气逆，所以好噯而吞酸”，則前者由汗吐下后，胃弱不和，后者乃因宿谷不化所致。

噯的另一意义，是一种情志疾病的声音。当一个人心有不平，或情有所逆，气郁于心，胸中怫悒，常会发生一种叹息之声，內經所說“心为噯”，就是指此而言。

八、噦 欠

噦，是噴嚏。欠，是呵欠。灵樞口問篇說：“阳气和利，滿于心，出于鼻，故为噦。”又說：“卫气者，晝日行于阳，夜半則行于阴，阴者主夜，夜者臥；阳者主上，阴者主下，故阴气积于下；阳气未尽，阳引而上，阴引而下，阴阳相引，故数欠。”金匱寒疝宿食篇亦說：“夫中寒家喜欠，其人清涕出，发热色和者善噦。”又說：“中寒其人下利，以里虛也，欲噦不能，此人肚中寒。”根据这些說法，噦是一种阳气和利的現象，中寒阳虛的，就不能得噦。經驗証明，病至阳虛，久无噦而忽得之，确属陽回將愈的佳兆。欠乃“阴阳相引”，为阳弱阴胜，而阳气有欲伸的現象，所以中寒家喜欠，当人們疲勞神倦的時候，也常喜呵欠。

九、呻 吟

呻吟，是病人感觉痛苦，不能忍耐所发出的声音。当結合其他症狀，推知病人痛苦的所在，如張錫三說：“脉之呻者，痛也，謂診时呻吟也。攢眉呻吟，苦头痛也；叫喊以手撫心下，中脘痛也；呻吟不能轉身，腰痛也；搖頭以手捫腮，唇齿痛也；呻吟不能行起，腰脚痛也。”

乙、气 味

凡物腐敗，則其气味变异，如“魚餒肉敗”之类，病时的气味异常，理亦如此。正常人气血流暢，藏府經絡，清鮮活潑，是不会有异常气味产生的。病人就不然，藏府气血津液，受病毒的薰蒸，不論在他的呼吸气息中，以及排泄物如汗、痰、涕、唾、經、帶等等，都可能产生一种不正常的气味。这些异常气味，对診斷某些疾病，也有一定帮助。茲簡述数例如下：

一、伤寒与瘟疫

广瘟疫論上說：“风寒气从外收斂入內，病无臭气触人；間有作臭气者，必待数日轉阳明府証之时，亦只作腐气，不作屍气。瘟疫气从中蒸达于外，一病即有臭气触人；輕則盈于床帳，重則蒸然一室，且專作屍气，不作腐气。”

二、痰 与 涕

咳唾濁痰膿血，如有腥臭的，为肺癰；无腥臭的，为肺痿。鼻流濁涕，如有腥臭的，为腦热鼻淵；无腥臭的，为风寒外感。

三、口臭、汗臭、血腥臭

口噴臭穢之气，如属胃府有热，則作热臭气；如有宿食，則作酸臭气；如为牙疳，則作腐臭气。又伤寒、溫热病人，如有汗臭，則可知其已曾出汗。临病人如聞血腥臭，則可知其必曾失血。

四、二 便

大便有酸臭气，为腸有积热；大便有生腥臭而便清冷的，为腸寒症。又小便臭濁黃赤，为膀胱有热。屁臭，多因消化不正常，宿食停滯。

五、月經及帶下

妇女行經，有臭穢之气的，为热；有腥臭之气的，为寒。帶下，

属湿热，則其气臭穢；属虚寒，則其气腥穢。

小 結

聞診，是一个細致的診斷方法，要求我們能以安靜的心神，灵敏的感觉，去进行工作。誠如喻嘉言所說：“精心体驗、积久誠通”，自然可以辨析精微，聞声知病了。

声音的产生，主要由于气的作用，所以声音的变化，有关于气的盛衰，至深且鉅，此外，还可以从声音測候五藏的病變，如万病回春說：“肝病声悲，肺病声促，心病声雄，脾病声慢，腎病声沉”，这就是听声辨証的范例。但其間也有非疾病性的变化，例如生理缺陷，感情作用，当加以区别。在临床診斷方面，要以語言与呼吸为首要，因为，我們接触任何一个病員，必然要和他进行問答，就能够听到他的呼吸与語言，他的語言之壯厉或低微，狂言或錯語，他的呼吸之喘逆或上气、短气或少气等等，都应该引起我們的注意。至于咳嗽及嘔吐，在临床中也是比较多見的症狀，通过聞診，能够判別疾病的寒热虚实，对診斷也有一定作用。呻吟是病人的痛苦表現，从呻吟声中，可以了解病人痛苦的微甚。其他如呃逆、噯气、噯、欠等，都足資我們診斷的参考。

其次是气味的聞診，它虽不如聞声的范围广泛，但也有它的一定意义，例如伤寒与瘟疫之辨、肺癰与肺痿之异，以及汗臭、血腥、二便、經帶等等，在临床上，亦宜加以注意。

复 習 題

1. 病人語言、呼吸的变化，在診斷上有何价值？
2. 气味的聞診对診斷有什么帮助？
3. 你对聞診的体会如何？試举例說明之。

第三节 問 診

問診也是四診之一，主要是对病情进行一番調查了解的工作。它的診察方式，是通过医生与病員或其家属的談話，借以了解病員的生活居处、周圍环境，以及疾病的演变情况，例如疾病是怎样发

生的、病情是怎样发展的等等，一一了解，同时詳細記錄下来，作为临症工作的参考。病案記錄，亦是医学上一个有价值的文献，历代医家对这些工作，都很重視。如灵樞上早就提出“临病人問所便”，后来李梴亦提出，临床上要問很多項目，喻嘉言更指出，要“先議病，后議葯”，并定出一个“議病式”，进一步充实了問診的内容。

問診在临床診斷上，是有积极作用的，不过在某些地方，亦有他的一定限制，如病員对疾病痛苦的忍受程度，并不完全一致；疾病关键問題，未必每个病員都能說得出来，或者有时还会答非所問。在这些情况之下，問診就很难达到理想的要求，所以把望聞問切四診結合起来运用，才能帮助我們进行更全面的診斷。

这里我們專就問診而論，归納一些文献，扼要地分“問診綱要”和“脉案記錄”两部分来介紹。

甲、問診綱要

一、注意工作时的环境

在問診进行过程中，一个安靜自由的环境，亦是必要的。如其在嘈杂环境下进行工作，容易打乱我們工作的注意力，而且有許多情緒感伤的病史，以及“隱曲不便”和有关妇科問題等等，亦都要求我們在問診場合，注意到周圍有无影响关系。同时，医生与病員的談話，亦每每有它的个别性，或者保守秘密的地方，如其不注意到周圍环境，可能会引起不必要的誤会，甚而至于会給我們工作上，帶來不必要的損失的。素問移精变气論早就指出，“閉戶塞牖，系之病者，数問其情，以从其意”，所謂“閉戶塞牖”，是多么注意到环境的安排，也充分說明了我們前輩們，是深深懂得問診与周圍影响的关系了。后世註釋內經的人，多說如此可以“无外其志”，我們的体会，亦認為环境安靜，医生可以集中思想，傾听对方的陈述，病員可以无所顧忌，暢所欲言，这是符合工作要求的，所以在这里又提出了一个环境問題，冀能引起注意。

二、問籍貫、职业

籍貫方面（包括出身和生活到过的地方），應該注意詢問。在

素問上面，已經有“異法方宜”的討論了，喻嘉言亦認為：議病時須辨高卑燥溼五方的異宜。事實確如此，由於籍貫的不同，病情和用藥，每每有它的特殊性。前人嘗說：“北方多傷寒，南方多溫病”；西北慣用大量麻、桂，四川常用附子，南方則往往是桑、菊、銀、翹。我們虛心體察，這裡頭是有它的不同，由於天時、地理、體氣等錯綜複雜關係，需要我們在臨床上加以考慮。同時我們還得注意另一個情況，就是地方病問題，如蘇北的大肚子痞（如黑熱病之類），長江兩岸的鼓脹病（如血吸蟲病之類），蠶桑區的桑葉黃（如鉤蟲病之類）等等，每每是有它的特殊病型，而且是在一個地區很流行，在另一個地方，就不大注意，或甚至會不認識它。如其不留心詢問，在某些場合，可能要模糊我們臨床方向。即如我們很多醫書里面，亦有“瘴氣”“蠱毒”等記載，有些或就是指的某種地方疾病，所以詢問籍貫，亦是一個重要的病史了解。

至於職業問題，亦宜引為注意。由於社會事業的發展，社會分工亦日趨專業化，根據許多知識的證明，一個人經常工作，生活於某種環境之下（如腦力勞動，體力勞動，鉛字工，音樂家），每每是易於引起某種疾病的，這就是所謂“職業病”。這些疾病，都有它的一定規律，亦有它的特定形症，如果能夠加以掌握了，亦有利於臨床上的處理。所以，這亦是宜予注意詢問的。

三、問平日生活習慣

平日的生活習慣，每每能影響着病情，這亦是我們在臨床上所宜注意的。素問上早就提出：“凡欲診病，必問飲食居處。”丹溪心法亦說：“凡治病，必問平日起居飲食如何。”事實確如此，從一個病員的生活習慣的了解，可以幫助我們決定臨証的處理方針。例如以平日的勞逸而論，勞則氣散，逸則氣滯，勞逸不同，用藥亦有異。再以平日的飲食而論，一貫正常的，胃腸氣多充實，假如平日飲食失調，中氣先已虧損，中氣的強弱如何，它能影響着疾病的傳變程度。再從平日體質而論，素來強壯的，體氣多壯實，有抵抗能力；平日多病的，可知體氣多虛，不耐邪氣侵襲。抵抗能力如何，是任何疾病預後的關鍵所在。

又如五味中有偏嗜、偏多食之物，則知臟氣有偏盛偏絕之候。所以，好食甘者脾虛，好食辛者肺病，好食酸者肝虛，好食咸者腎弱，嗜食苦者心病。又如酒客多痰熱，煎炒多犯上焦，或流入大腸而為濕熱之証。此外齋素、嗜茶等等，在論病用藥上，都有引起我們加以注意詢問的必要。

四、問精神環境

精神環境如何，對某些疾病的發生、發展及預後，影響很大。所以，古人每每把七情之變與六淫之傷，相提並論，認為兩者都是重要的致病因素。即在一般臨床上，亦是以外感六淫與內傷七情，分為兩大系統。因此，關於這方面的詢問，就有引起我們重視的必要。試觀素問上面，亦早就提出很多說法，如：“診有三常，必問貴賤，封君敗傷，及欲侯王”，又說：“凡未診病，必問嘗貴後賤，嘗富後貧”，“暴樂暴苦，始樂後苦”等等，這些文獻都反映了前人对它重視了解的情況。在歷代著錄中，關於這方面記載，非常豐富，茲舉數例如下，作為臨証參考：

素問血氣形志篇上說：“形樂志苦，病生于脉，治之以灸刺；形樂志樂，病生于肉，治之以鍼石；形苦志樂，病生于筋，治之以熨引；形苦志苦，病生咽嗌，治之以甘藥；形數惊恐，經絡不通，病生于不仁，治之以按摩醪藥。”這是內傷疾病中的所謂“五形志病”，由于環境刺激的不同，發病和治療，亦各有所異。

疏五過論上亦說：“暴樂暴苦，始樂後苦，皆傷精氣，精氣竭絕，形体毀沮。暴怒傷陰，暴喜傷陽，厥氣上行，滿脉去形。”又說：“嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營；嘗富後貧，名曰失精，五氣留連，病有所并。”這些情志生活的苦樂變遷，每每不容易處理得當，它可以導致很壞的後果，如“脫營”“失精”，這是大家所熟悉的事。這裡附錄一些材料，以便加深對這一點的認識。

附錄：脫營証、失精証

脫營証 初如痰核，不赤不痛，堅硬如石；或發膺乳腋肋，或發肘腕脛膝。若忽而不治，或誤服攻堅解毒清火消痰等藥，則日漸腫大，盤根錯節，破後無膿，惟流血水，決不可救。

失精証 不因邪伤而身体日减，筋脉痿痹，飲食无味，神情倦怠，內虽郁結，外无聚，綿延日久，終至不治。

举痛論上又說：“怒則气逆，甚則嘔血及飧泄，故气上矣；喜則气和志达，营卫通利，故气緩矣；悲則心系急，肺布叶举，而上焦不通，营卫不散，热气在中，故气消矣；恐則精却，却則上焦閉，閉則气还，还則下焦脹，故气不行矣；惊則心无所倚，神无所归，慮无所定，故气乱矣；劳則喘息汗出，外內皆越，故气耗矣；思則心有所存，神有所归，正气留而不行，故气結矣。”这是“七情”病变的具体描写，皆得問而知之。

医学入門亦說：“当問所處順否，所處順，則性情和而气血易調；所處逆，則气血怫郁，于所服藥中，量加开郁行气之剂。”

此外，尚有一个應該注意的問題，就是有关七情之变，不仅是要求我們仔細詢問，还要求我們通过問診的机会，进一步做好說服教育工作。如疏五过論上說：“医不能严，不能动神，外为柔弱，乱至失常，病不能移，則医事不行，此治之四过也。”照这样說法，对精神影响的病，我們責任范围，就不只限于藥物所及，还要發揮我們的說服教育能力。不單是注意他們的疾病，更主要的是能感动病人，假如不这样去做，因而不能把病人挽回过来，还是我們的一个过失。这种認識，这种学术，实有很大的进步性，值得我們景仰，后世医家对情志方面的病，主張以精神疗法为主，藥物疗法为輔，确是体现了这种学术精神，并繼承了前人的工作美德，所以能为病員解除痛苦，挽救了很多的思想病人。因此，关于这一方面，也是我們問診中的要点之一。

五、問起病、轉变及医疗經過

了解一个疾病的起始情况和轉变經過，每每能够給我們一种初步診斷印象，如这个病的或急或緩、属表属里等等，孙思邈亦說：“問而知之，別病淺深。”在临証接触病員之际，这样一个初步概念，是非常重要的，它可以权变我們的处理步驟。素問三部九候論上也說：“必审問其所始病，与今之所方病，而后各切循其脉”。它所謂“始病”，所謂“方病”，我們体会，那就是注意到一个疾病的发生情

况和現在病情的发展趋向。同时它还加上一个“必”字，更可以說明它的重要性了。

現在我們从起病的情况来談，假如这个病起得急暴，每每多属外感；反之，病起得很慢，胃口先倒，身疲少力，則每每属于內伤。再拿症狀来看，假如开首即是脉浮头痛項强而惡寒，大致病在于表；如腹痛吐利，手足逆冷，此病即为在里。此外，尚有某些卒急疾病，如“中惡”“客忤”“惊厥”“中毒”等等，一开始就緊張万狀，使人手足无所措，臨証时很难捉摸和处理。此时我們当十分机警，除了予以适当的急救而外，务能了解到它的发病原因，如大怒大醉可以伤形气，大惊大恐能够伤神志，禽兽魚虫的中毒，果实菜谷的食伤，以及暑热、风寒的触冒等等，都可以誘发某些急暴疾病，应当注意詢問。

我們再从病的轉变情况来談，假如是发病起初很輕，而現在变重了，即当注意标本吉凶。病情有发展，我們的处理就得多机变。假如是起病很重，現在轉輕了，我們亦当考虑盛衰逆从，症狀虽減輕，还宜审慎从事，不能疎忽粗心。往往有邪衰正亦衰，或者是表面轉輕而內在却变重了的情况，例如方書上所說的某些內陷症，就是如此。至如“痢变瀉、变瘡为輕，瘡变瀉、变痢为重”，“先喘后脹病在肺，先渴后嘔为水停心下”等等，都是值得我們注意的事情。

至于以往医疗的經過，每每可以关系到疾病的变化情形，不論它的效与不效，大都可以作为我們后来临床处理的借鏡；尤其是某些長久的病程，病員的体会很深，我們应得細細探問。

六、問現在症狀

現在症狀，是我們临床上最注目的地方，应得作为重点詢問。皇甫謐說：“問之要察阴阳之虛实，辨藏府之寒热。疾病所生，不离阴阳、藏府、寒热、虛实，辨之分明，治无誤矣。”这个說法，可以作为我們工作的指針。張景岳氏，对于这一点，也很有研究，他的“十問篇”，就是一个有名的文献。这里节引其文，重点介紹如下：

1. 問寒熱 問寒熱，是問內外之寒熱，用以辨別病之在表在里。“人伤于寒，則为病熱”，故凡病身熱脉紧，头疼体痛，拘急无

汗，而且是很短時間內得病的，必為外感。蓋因寒邪侵襲經絡，所以頭痛身疼；邪閉皮毛，所以拘急發熱。若平日無疾，而忽見脈証若是，多因外感。蓋寒邪非素所有，而突然若此，此是表証。若無表証，而但身熱不解，則多屬內傷。但內傷則必有內証相應，合而參之，自得其真。以上是一般的說法，如再進一步考究，此中尚有很多差異情況，即以表証而論，如身熱經旬，或至月余不解，亦有仍屬表証的。蓋因初感寒邪，身熱頭痛，醫不能辨，誤認為火，常用寒涼，以致邪不能散；或雖經解散，而藥未及病，以致留蓄在經，其病必外証多而里証少，此非里証，仍當解散。

再以內証而論，內証發熱，固然多屬陰虛，其來也漸。但陰虛者必傷精，傷精者必連藏。此中症狀，又多差異，如其在上而連肺的，必為喘急咳嗽；在中而連脾的，或妨飲食，或生懊憹，或為躁煩焦渴；在下而連腎的，或精血遺淋，或二便失節。然必倏熱往來，時作時止，或氣怯聲微，是皆陰虛之証。

又如怒氣七情，傷肝傷藏而發熱的，總屬真陰不足，所以邪火易熾，亦屬陰虛。又如勞倦傷脾而發熱的，以脾陰不足，故易于傷，傷則熱生于肌肉之分，亦屬陰虛。這是里証陰虛發熱的大略。

假如內傷積熱，在症瘕必有塊聚的形証，在血氣必有瘀滯的病征；或九竅熱于上下，或藏府熱于三焦。若果因實熱，凡火傷在形體而無涉于真元的，則其形氣声色脈候，自然壯實，有據可凭，此當以實火治之。

總而言之，寒証顯然易知，或外寒，為陽亏于表；或內寒，為火衰于中。熱証則比較複雜，表熱、里熱、陰虛、實火，都得細細辨析。這裡還得注意的，熱病固多屬實，而虛熱者最不可誤；寒病固多屬虛，而實寒者間亦有之。此寒熱之在表在里，不可不辨也。

2. 問汗 問汗，亦因以審察表面。凡表邪盛的必無汗；而有汗的，邪隨汗去，已無表邪。這是一般的情況。其中有邪盡的出汗，身涼熱退，邪隨汗去。但又有邪在經而汗在皮毛的，此非真汗；有得汗后，邪雖稍減而未得盡痊的，猶有余邪。因此，又不可因為有汗就肯定沒有表邪，還須因其脈証而詳察判斷。

至如暑溫等証，有因邪而作汗的，有虽汗而邪未去的，還属于

表証。总之，表邪未除的，在外則連經絡，故头身或有疼痛；若邪在內則連藏府，故胸膈或生煩躁。在表在里，有証可凭；或紧或数，有脉可辨。須察其真假虛实，孰微孰甚而治之。

又有全非表証，如阳虛而自汗的，須实其气；阴虛而盜汗的，須益其精；火盛而汗的，涼之自愈；过飲而汗的，清之可宁。此汗証之有阴阳表里，又不可不察。

3. 問头身 問头部情况，可以察邪在上下；問身部情况，可以察病在表里。一般而論，头痛的，为邪居阳分；身痛的，为邪在諸經。病的前后左右，可以辨别阴阳；有热无热，又可以分別內外。凡屬表邪，都可发散而愈。

假如火盛于內而为头痛的，必有內应之証，或在咽喉口腔，或在耳目諸窍。假如別无身热惡寒等表証，此为热盛于上，病为在里，察在何經，宜清宜降，“高者抑之”，即是指此等症而言。若用輕揚散剂，則火更上升，头痛愈甚，那就錯了。

至如阴虛头痛，发作无时，是因酒色过度，或遇劳苦，或逢情慾，其发則甚，此为里証，耗精伤气，非补不可。

又如头痛属里之証，多因于火，这是一般的說法。其实，亦有阴寒在上，阳虛不能上达而痛甚的。其証是惡寒嘔惡，六脉沉微，或兼弦細，諸治不效，曾以桂、附、人参、熟地之类，治愈此病，可知头痛亦有属于阳虛的。

头痛一症，可以分經論証，归經用葯。如后头痛属太阳，前額眉棱等痛属阳明，兩側头痛属少阳，巔頂痛属厥阴。如此認証，臨床处理，更容易掌握。

又有所謂“头风”的，这是一般的俗称。但也必有所因，須探求其本，辨而治之。

眩暈，头重等証，亦应辨别虛实。凡病中眩暈，多因清阳不升，上虛而然。如丹溪云：“无痰不作暈”，并非全面之論，应当兼形气、分久暫以察之，試觀內經上說：“上虛則眩，上盛則热痛”，其义可知。至于头重，尤属上虛，內經上說：“上气不足，腦为之不滿，头为之苦傾。”就是指此等病而言。

至于討論身痛，亦当察其表里，以分寒热。若外感风寒作痛

的，或上或下，原无定所，随散而愈，此属表邪；若有定处，而别无表証，乃痛痺之属，邪气虽亦在經，此当以里証視之。身痛又有寒热之异：若因于火盛的，或肌肤灼热，或紅腫不消，或內多煩渴，必有热証相应，治宜以清以寒；若并无热候，而疼痛不止，多属阴寒，以致血气凝滯而然，內經上說：“痛者寒氣多也，有寒，故痛也”，必溫其經，使血气流通，其邪自去。

又如劳損病劇，而忽加身痛极甚，此阴虛之极，不能滋养筋骨而然，营气慳敗，治疗也就困难了。

4. 問二便 二便为一身之門戶，無論內傷外感，皆当察此，借以分別病情的寒热虛实。盖前阴通膀胱之道，小便的利与不利、热与不热，可以察气化的强弱。凡患伤寒而小便通利的，以太阳之气未劇，是为吉兆。后阴开大腸之門，大便的通与不通、結与不結，可以察阳明的虛实。凡大便热結而腹中坚滿的，方属有余，可以通之，若新近得解而不甚干結，或虽旬日不解而无腹脹之意，便非阳明实邪。仲景曾說，大便先鞭后溏者不可攻，可見后溏者，虽有先鞭，已非实热；假如大便純溏而又連日得通的，更可知不能輕易攻下了。若非真有坚、燥、痞、滿等症，則原非实邪，其不可妄攻，是更容易明白的。

伤寒大便溏，为邪已尽，不可再下；湿溫大便溏，为邪未尽，必大便鞭，慎不可再攻，因为湿溫尿燥，是湿热已化，病气已除了。

又如小便，有人見到发黄，便謂是火，这是不全面的。却不知人逢劳倦，小水即黄；焦思多虑，小水亦黄；瀉痢过多，小水亦黄；酒色伤阴，小水亦黄。假使沒有或淋或痛等热症相兼，不可因为有些发黄，就認為是火。余（景岳自称）見逼枯汁而斃人命的很多，前人曾說：“中气不足，溲便为之变”，这是有它道理的。若小水清利，知里邪未甚，而病亦不在气分，以津液由于气化，气病則小水不利，小水漸利，則气化可知，最为吉兆。

大便通水谷之海，是腸胃之門戶；小便通血气之海，是冲任水道之門戶。二便皆主于腎，本为元气之关，必真見实邪，方可議通議下，否則最宜詳慎，不可誤攻。假使不是真实而妄逐之，导去元气，則邪气本来在表的，反乘虛而深陷；病属內虛的，必由泄而愈。

亏。所以凡病不足，慎勿强通。最喜的，小便得气而自化，大便弥固者弥良。营卫既调，自将通达，即大便秘结旬余，也不必过虑，若滑泄不守，乃非虚弱者所宜，此当首先注意。

5. 問飲食、口味 問飲食，一可以察胃口之清濁，二可以察藏府之阴阳。病由外感而食不断的，知其邪未及藏，而惡食不惡食，亦可因以测知；病因内伤而食飲变常的，辨其味有喜惡，而受冷受热的习惯，亦可問而知之。素欲温热的，是阴藏之人，用藥宜煖，素好寒冷的，是阳藏之人，用藥可清。或口腹失节，以致悞伤，問明原因，則一时之权变，亦可据以为辨。故飲食之性情，所当詳察，藥餌之宜否，亦可因以推知。

如諸病得食稍安的，必是虛証；得食更甚的，或虚或实皆有，当辨而治之。

又，有胃气則生，无胃气則死，此百病之大綱。故諸病若能食者，勢虽重而尚可挽救；若不能食者，勢虽輕而必致延剧。所以飲食的詢問，很为重要。

又，口味苦淡，亦当詢問，可凭此以察病情。如口苦的，多属于热；口咸的，多属于寒；口淡的，多属于虚；口甘的，脾热成疴；口酸的，多伤于食等等，这是常見的情况。

6. 問胸腹 胸即膈中，上連心肺，下通藏府。胸腹之病极多，难以尽悉，而临証必当詢問，可以辨其有邪无邪，及宜补宜瀉。夫胸腹脹滿，則不可用补；而不脹不滿，則不可用攻，此是大法。然痞与滿不同，当分輕重。重者脹塞中滿，此为实邪，不得不攻；輕者但不欲食，不知飢飽，似脹非脹，中空无物，是为痞气，并非真滿。此或以邪陷胸中时有之，或脾虚不运时亦有之。病者不知这种分别，有时但見胃气不开，飲食不进，問之都說飽悶，而实在并非真有脹滿，此在疑虚疑实之間，医者若不察其真确，未免补瀉倒施，因以致悞，則为害不小。

又如今人病虛証的极多，非补不可。但用补之法，不宜造次，欲察其可补、不可补之机；則全在先察胸腹之寬否何如，然后以漸而进，如未及病，再为放胆用之，就不会出偏差，这是用补的大法。即使勢在危急，进补难容少緩，亦必先問清其胸中寬舒的，才可驟

然进补。若元气真虚，而胸腹又胀，是必虚不受补之証，若强进补剂，不但无益，而且可以产生相反作用，虚証并未受益，而痞胀却加重了。所以胸腹情况，不可不察。

7. 問聾、睡眠 耳虽少阳之經，实为腎臟之官，又为宗脉之所聚，問之非惟可辨虚实，亦且可知死生。凡人之久聾者，此一經之閉，无足为怪。惟是因病而聾的，不可不辨。在素問热論篇上說：“伤寒三日，少阳受之，故为耳聾”，此是寒邪在經，气閉而然。然以余所驗，則末有不因气虚而然者，素問說“精脫者耳聾”，仲景說“耳聾无聞者，阳气虚也”，由此观之，則凡病是証，其属气虚的占多数，属气閉的为少見。

聾有輕重，輕者病輕，重者病重。若随治漸輕，可知其病之漸退；若虽治而聾更加重，則病亦在加重。若病至聾极，甚則絕然无聞，此誠精脫之証，余（景岳）經歷者数人，皆至不治。

睡眠一症，亦是值得注意的病情，尤其是失眠，临床遇見很多。这里分为不寐、多寐两方面，討論如下：

不寐一証，原因很多，临床处理，应先探問明白。如有由于心血不足，或神不守舍而不寐的；有由于心火焦煩、津干口渴而不寐的；有由于心胆俱怯，触事易惊而不寐的；有由于胆火郁热，口苦神煩而不寐的；又有思慮伤脾，脾血亏损，經年不寐的；又有病后的虛煩不寐，病久余热不止的遺精不寐；又有过于飽食，或病脹滿。所以素問逆調論說：下經曰，胃不和，則臥不安；高年的血衰不寐，以及妇人肥盛、多郁不寐等等，皆当辨別主症兼症的差异；探明原因，予以适当的治疗，不可忽于詢問，一概而論。

至如多寐，亦有几种情况，应加分別，有由于湿胜，身重脉緩；有由于气弱，神倦肢惰；有由于病后，身热好眠，是余邪未清，正气未复。此外尚有，口苦嗜眠为胆实証，脉微細但欲寐，为少阴病。

8. 問渴 問渴与不渴，可以察里証之寒热，而虚实之辨，亦从以見。凡內热之甚，則大渴喜飲，冰水不絕而腹坚便結，脉实气壯，此为阳証。

如口虽渴而喜热不喜冷的，此非火証，中寒可知。既非火証，何以作渴？則可知其水亏之故。

又如病人問其渴否，則答曰口渴；問其欲飲湯水否，則又不欲。只因內无火邪，所以不欲飲湯水；真陰內亏，所以口无津液，这叫“口干”，并非“口渴”，不可以口干作口渴論治。

至如阳邪虽盛，而真阴又虛，不可因其火盛喜冷，便云实热。盖其內水不足，欲得外水救济。水涸精亏，真阴已枯，必兼脉証細察之，此而略差，死生立判。余（景岳）曾治垂危最重伤寒（指热性病）就遇到这种情况，每以峻补之剂，浸冷而服；或以冰水、人参、熟地等剂，相間迭进，因而得到挽救的人，不在少数。一般人見了都認為奇特，不知理当如是，何奇之有。但必須确是干渴燥結之甚，乃可以参、熟、凉水并进，若无实結，不可予冰。

以上各节，是根据景岳“十問篇”的精神討論的。这些問題，都是临床上現在症中所宜注意的事，是处理每个疾病所当首先明确的事，因此把它作为重点介紹。

9. 問妇人、小儿疾病 妇人疾病，在很多地方，大致上与男子相同，所不同的，就是月經、帶下、妊娠、产褥等情形，因之看妇人的疾病，在这方面的詢問，应加以留神。如果月經、帶下、妊娠、产褥等妇科本身疾病，牽涉到內科范围，病情就变为复杂，更宜注意鑑別而論。所以在妇人病員的詢問上面，除了一般的了解之外，还宜加問經、帶、胎、产的情形，这才可以掌握病情的全面，定出确当的处理方針。此外，尚有妇人多气善郁之說，在一定环境下，也得注意詢問。

医学入門問診，有一段涉及妇人病方面的，附此以供參考。

妇人經調否？或参前为血热，或参后为血虛，或当經行时有外感，經尽則散，不可妄药，以致有犯血海。

經閉否？或有潮热，或有咳嗽，或有失血，或有白帶否？能飲食否？能食則血易調而諸証自除，食減漸瘦者危。

有症瘕否？有腹痛潮热，而一块結实者，为症瘕。

有孕能动否？腹中有一块，結实能动，而无腹痛潮热等症者，为有孕。腹虛大脹滿，按之无一块結实者，为气病，其經水亦时渗下。

产后有寒热否？有腹痛否？有汗否？有咳嗽否？寒热多为外

感，腹痛多为瘀血。或食积停滯，有汗且潮热，为气血大虛。咳喘为瘀血入肺，难治。

至于小儿疾病，是难以問对的，所以在症狀的了解上，也就不易深入。但我們要注意，他有很多常发疾病，方書上所說痧、痘（天痘是現在已經基本上消灭了，水痘还是时常有流行）、惊、疳，临床上要随时留心。至就一般而論，應該注意了解他的父母健康狀況、襁养情形、发育过程，以及最普通的如食伤、受凉、惊恐等等，这些都是小儿疾病的常見因素，我們可以在家属方面，注意探問。

乙、脉案記錄（表 13）

談到脉案記錄，大家都是熟悉的，前面写几行案語，下面罗列一些药名，通俗叫做开张“方子”（或“單子”）。把許多方子，按一个疾病为次序，或按一类病为次序，編集起来，就叫做医案或类案。現在通称之为病历。关于这种文献，在我們祖国医学中，占着很大比重，也起着很大作用，而且还有着很悠久的历史。如淳于意的“診籍”、韓天爵的“医案一宗”、吳崐的“脉案格式”、喻嘉言的“議病式”等等，都說明了历代医家，是如何的重視和发展这个工作。但近几十年来，由于祖国医学，受到帝国主义文化侵略的摧殘，部分同道們，对自己的事业，亦失去了信心。因此，在日常事务中，就忽視了临床工作的記錄，即有些記錄，亦每流于形式，甚至有的就簡直只写几样药名了。所以很多老前輩們的临床实况，宝貴經驗，无从流傳和总结下来，这是学术上的一个損失。今天情况，与过去是不同了。祖国医学，受到党和政府的重視，不仅要求把它繼承下来，而且要求很好的把它发揚和流傳下去。那末，我們今天的工作，是有事业意义，是有发展要求的。因此，脉案記錄，亦成为我們工作中的一个重要环节了。

脉案記錄是临床上的写实材料。它能真实地、生动地把复杂的病情变化和医工的处理机智，一一記錄下来，这是活的、可貴的医学文献，对我們临床或研究工作，有很大启发，如理論怎样去联系实际、实践又如何丰富理論，从理論、实践到发展、提高，在这里是可以找到很多窍門的。所以說它在学术地位上，是起着很大作

用的。

至記錄要求，如过去的單写上几句脉案，似乎太簡單，不够理想要求。但究竟要写多少，似亦很难一时就定出一个刻板的公式来。大体的講，一个記錄，應該包括到多方面，如病員的主訴、現在症狀、发病和傳变經過、平日情况、家庭环境以及医工本身的印象、处理步驟和治疗方法等等。假如是复診和轉診，尚須詳記它的医药經過、病情演变等。至如病人提到的过去病症，对現在有参考价值的，亦应把它記載下来。一般的材料，要簡洁明确；重点問題，又要尽量写得詳細。这是一个大致的要求。

至于文献之中，对病历研究，最足以参考和取法的，要算喻嘉言寓意草的議病式了。下面提出介紹：

与門人定議病式：

某年、某月、某地、某人。年紀若干，形之肥瘦長短若何，色之黑白枯潤若何，声之清濁長短若何，人之形志苦乐若何。病始何日，初服何药，次后再服何药；某药稍效，某药不效。时下晝夜孰重，寒热孰多，飲食喜惡多寡，二便滑瀉有无；脉之三部九候何候独异，二十四脉中，何脉独見，何脉兼見。其症或內伤或外感，或兼內外，或不內外，依經断为何病。其标本先后何在，汗吐下和寒溫补瀉何施。其药宜用七方中何方，十剂中何剂，五气中何气，五味中何味，以何湯名为加減和合，其效驗定于何时。——詳明，务令纖毫不爽，起众信从，允为医門矜式，不必演文可也。

某年者，年上之干支，治病必明运气也。某月者，治病必本四时也。

某地者，辨高卑燥湿五方异宜也。

（按 以上几項，是注意記錄外在环境影响的情况。）

某齡、某形、某声、某气者，用之合脉，图万全也。

形志苦乐者，驗七情劳逸也。

（按 以上几項，是注意記錄內在环境影响的情况。）

始于何日者，察久近傳变也。

历問病症藥物驗否者，以之斟酌已見也。

（按 以上几項是注意記錄疾病的发生、发展的演变情况。）

晝夜寒熱者，辨氣分血分也。

飲食二便者，察腸胃乖和也。

三部九候何候獨異，推十二經脈受病之所也。

二十四脈見何脈者，審陰陽表里，無差忒也。

(按 以上几項，是詳細記錄現在的症狀。)

依經斷為何病者，名正則言順，事成如律度也。

標本先后何在者，識輕重次第也。

(按 以上几項，是對病情的分析歸納，並加以判斷，詳細記錄，作為治療的指導和工作的考核。)

汗吐下和寒溫補瀉何施者，求一定不差之法也。

七方、大、小、緩、急、奇、偶、復，乃藥之制，不敢濫也。

十劑，宣、通、補、泄、輕、重、滑、瀉、燥、濕，乃藥之宜，不敢泛也。

五氣中何氣，五味中何味者，用藥最上乘之法，寒熱溫涼平，合之酸辛甘苦咸也。

引湯名為加減者，循古不自用也。

(按 以上几項，是詳細記錄處理上的根據和方法步驟，可以“持循待續”防止主張紛紜，雜藥亂投。)

尅效于何時者，逐款辨之不差，以病之新久、五行定痊期也。

(按 這一項是臨床時的預後意見，可以考核自己的想法做法，能否完全符合客觀變化，從而為進一步處理，提供綫索。)

上面一個文獻，我們把它研究一下，很有理致可尋。它首先注意到外在環境的影響，其次是注意內在環境的情況，第三注意疾病的发生和發展的演變，第四是詳細詢問和記錄現在症狀，第五對一個疾病的各方面認識，作出記錄，第六是處理的根據是什麼、如何給以治療，一一記載出來，最後作出一個預後診斷。有識有見，料事毫不含糊。這樣一個記錄，可以說是詳細而且具體的了。假如我們能夠這樣去做，是合乎理想要求的。如能再進一步，把它整理修訂，制出一個比較容易統一的病歷表式來，對臨床的幫助是很大的。

在今天來講，老樣式的來開張方子，似乎太嫌簡單；西醫病歷，

制表說明：以往中医临症习惯，是开張方子，前面写上几行脉案，后面罗列一些藥品。这种方式，作为研究要求来講，似乎太嫌簡單。近来有了中医門診所，医院等条件，但所用病历，大都系采仿西医病历，并不能反映中医的特点。我們特根据中医学术体系以及文献記載，制訂本病历表，希能通过这种病历的运用，体现出中医学的固有面貌，并有利于中医的临証工作，有利于总结經驗。

本表包含了以下几个重点：

1.表上列入农历年份、节气和阴晴，这是貫串了中医的“天人合一”学术思想。因为作为一个中医看病，是必須注意到天时节阴晴轉移对病情的影响的，如时令病，脱离了季节，就无从論病定名；如杂病，脱离了季节，亦无从判断它的順逆輕重，所以这里首先把它提出了。

2.从姓名、性別以至工作單位等項的記載，可以了解一个病員的周圍环境及其对疾病的影响。

3.从望聞到問切，这是四診，是中医特有的診察方法。望診的重点为神色形态（包括舌苔、皮肤）。神色为气血的外荣，形态是各个疾病的特征。聞診的重点，在耳聞为声音，有力无力，可以辨别疾病的虛实；在鼻嗅为气味，腥臭腐屍的不同，可以了解病情的清濁寒溫。問診的重点，主要是探詢病情，凡望、聞、切所不能知曉的，都可于此有意識的了解（問診放在表格其他三診上面，主要是为了記錄和察看的便利）。切診的重点，是按脉和触診胸腹四肢等，从而得知病症的阴阳虛实等情况。这些都是中医在临症上所最注意而且是作为認識疾病的依据的，所以这里把它明确规定下来，便于記錄和提供分析判断的病情資料。

4.从案語到葯物，就是“理法方葯”，这是中医認識疾病和处理疾病的一套全面知識。案語是理論認識，也就是根据理論指导对上面四診材料，作一番綜合分析，下一个判断。治法是从理論認識基础上产生的，也就是根据理論来指导处理的方向而定出一个法則。方剂又是治法的产物，因为一个治法，可以包括很多方剂，而各方剂又各有它的特点，究竟以誰为主，配合誰用，亦應該有个計

划。至于藥物,实际上是方剂的内容,但多寡輕重、气味溫凉、升降浮沉等配合如何,必須一一記下来研究,是否符合于当时病情,亦便利于后来的斟酌、进退。这样把它記全了,不仅在临床上是一个比較全面的做法,而最主要的是能够把理論与临証实践結合起来,同时对病員亦負責,对学术研究亦多一分比較完整的資料。

5. 至于其他、医嘱兩項,其他項內,是准备記載一些四診以外的檢查資料,以备参考的;医嘱項內,是作为交代护理、飲食禁忌、服藥方法等記載的。

6. 复診亦用同样病历,因为一般情况,初診記錄比較詳細,复診記錄,就每每簡略了。实际上每一个病都有很多的轉折經過和机智处理,当时并不注意,但一旦提出研究或进行总结,就感到資料不全,发生困难,因此我們又用一种表格形式把它固定下来。假使在日常临症上就加以注意,这样做了,我們認為既能体现出中医学学术的特点,亦能逐步积累完整的研究資料,对学术、对事业都是有利的。

小 結

問診主要是对病情的一番調查了解工作,而这个工作的进行,是比較复杂的,所以,首先提出一个环境問題,以便利于工作的进行。因为問診的工作环境,关系到病情的能否曲折毕露,也影响到医生对病情的各方面了解,宜在工作上加以注意。此外,同是多种多样的病,是不是都机械地按照一个公式进行詢問,我們認為当然不是这样刻板的。大概而論,可以把許多常見疾病,分成几大类,如外感(急性病)、內伤(慢性病)和比較特殊的(地方病、职业病等),以及妇科、儿科等,作有步驟,有重点的探問。例如急性疾病,可于疾病过程、平日生活起居以及有无异常生活等情况注意去問;慢性疾病,就得重視精神生活环境,以及医藥經過等方面的詢問;某些比較特殊的病,則籍貫、生活到过的地方,以及职业等方面,可加意探問;至于妇科、儿科等疾病,應該注意他們的特定范围,細加辨認。这是問診的大略,可以參酌上面的提綱,相机行事。至問診的另一个要求,就是要能把每一个病情,都記錄下来。如在临床上所

看到的和調查了解到的各種材料，以及醫生的理論認識和處理方法等等，都一一的作出記錄，把它作為處理一個疾病的案卷，亦可作為研究一門學術的資料，這是醫學中有價值的文獻。總的說，在問診之中，主要是抓住兩點，就是問得中肯，記得切實；這樣，工作就能達到目的要求了。

復 習 題

1. 問診在臨床上的意義何在？
2. 問診應該注意那幾點？為什麼？
3. 怎樣寫病歷？

第四節 切 診

切診亦是四診之一，它是運用醫生的手，在病員軀體上的某些部分，作某種形式的診察，如或切、或按、或觸、或叩等等。通過這種診察，可以了解病員的體內變化和體表反映，如脈氣的盛衰、胸脹的痛痞、皮膚的腫脹、手足的溫涼等等。這種診察所得的結果，與看到的形象、听到的聲音，以及問到的病情，有同樣重要的診斷價值。所以古人在這個方面，是很重視的，而且運用也非常成功，自有它的獨到經驗。不過，在切診方面，有些問題，亦須引起我們注意，如操作的技术，關係很大，熟練與不熟練，每每可以影響到診斷的正確程度。又如接觸範圍，在某些環境下，尚有它一定的限制，如對婦女的觸診，小兒的切脈、按腹等等。所以，在臨床要求上，望、聞、問、切，應該結合起來運用。現在為了敘述便利起見，分脈診和觸診兩部分來介紹。

甲、脈 診

脈診，古來醫工，都很重視，著作亦非常豐富，在幾千年的實踐過程中，積累了很多經驗。我們如果能夠很好地掌握它，運用它，的確可以有助於“視死別生”，在臨床起到一定作用的。但是這門學問畢竟是一種精巧的技术，同時病狀的出現是千變萬化的，因此脈象也就有着各種不同的表現。我們要很好的掌握這門技术，

就必須不断地从理論上去钻研，不断地从临床上上去体認，才能达到成功的地步。这里就脉診的有关問題，扼要地分六个部分介紹于下：

一、診脉的意义

診脉是診斷工作中的重要环节，历来医工对此都很認真。它的作用和意义，究竟如何？关于这个問題，內經上面早已突出它的主要精神了。如素問离合真邪論，它是以自然界的現象，来比喻和說明这些問題的，它說人有經脉，犹如地有經水（河道里的水），如說：“天地溫和，則經水安靜；天寒地冻，則經水凝泣；天暑地热，則經水沸溢；卒风暴起，則經水波涌而隴起。”又說：“其行于脉中循循然，其至寸口，中手也，时大时小。”我們从这里体会，古人認識到平人之脉，是好比天地溫和时候的經水，其行是安緩平靜的。假如病人之脉，如在风暴激蕩下的經水，其行則波涌而隴起了，接触到医工的手指上，也就时大时小。这样的脉象出現，就反映了这个人已为某种邪气所侵犯。这种說法，是很逼真，而且也是通俗而現实的。它已認識了脉搏的所以变化，是由于客觀事物（邪气，包括內在和外在的刺激）的触发，而这一个变化的道理，是由于人与天地相参，客觀环境有变化，人体的适应和反映也就有变化。这种論点，是确有它的科学价值，这样論脉，也确有它的现实意义。

又如脉要精微論上說：“夫脉者，血之府也。長則气治，短則气病，数則煩心，大則病进。”灵樞逆順篇上說：“脉之盛衰者，所以候血气之虛实，有余不足。”这些記載，是在上文的基础上更有了發揮，把它体味一下，它對我們有两方面的启发，一方面是說脉的長、短、数、大、盛、衰等等，是脉搏变化的反映，从这些反映中，可以了解某种邪气的变化。另一方面是說血气的正常与病变，或虛、或实、有余、不足等等，因此說明了通过脉診可以考察人身的血气情况。人的身形精神，惟气血阴阳，疾病表現，亦是一个邪正消長。我們切脉，既可以了解到邪气的变化，更注意到正气的情况，是有它一定的診斷价值的。关于这个道理，說得最为明显的，要算方盛衰論上的一段經文了。它說：“診合微之事，追阴阳之变，章五中之

情，其中之論，取虛實之要，定五度之事。”我們談到这里，對診脈的意義，是可以有一個比較具體的概念了，它可以考察人身血氣如何，從而追求陰陽盛衰的變化，暴露內臟的情形，以便取得邪正虛實的關鍵，決定五藏常度上有那些偏差事宜，為臨床工作指出方向，為進行治療找到根據，這就是脈診意義的主要所在了。

二、診脈的部位和配合藏府

診脈部位，古來有各種學說，這裡介紹的，是其中比較主要的兩種，即“三部九候”和“獨取寸口”。三部九候，是在頭、手、足三部，以診通身之脈。獨取寸口，是在寸口部分，分寸、關、尺三部，以候十二經脈。前對這兩方面，都有很多經驗。至於兩種學說的分配藏府，略有歧異，今引其說如下，以供研討。

1. 三部九候 三部者，有下部（足部），有中部（手部），有上部（頭部）。部各有三候，三候者，有天（上）、有地（下）、有人（中）也。三而三之，三三者九，故謂之三部九候（見素問三部九候論）。

上部天，兩額之動脈（太陽穴），以候頭角之氣；上部地，兩頰之動脈（巨髕穴），以候口齒之氣；上部人，耳前之動脈（和髕之分耳門穴），以候耳目之氣。

中部天，手太陰也（寸口部），以候肺；中部地，手陽明也（合谷穴），以候胸中之氣；中部人，手少陰也（神門穴），以候心。

下部天，足厥陰也（五里穴，婦人取太沖穴），以候肝；下部地，足少陰也（太谿穴），以候腎；下部人，足太陰也（箕門穴，候胃氣者，當取沖陽穴），以候脾胃之氣。

以上是三部九候的大概情況，這種診脈方法，是測候通身氣血的變化，有很大的現實意義。如三部九候論上說：“人有三部，部有三候，以決死生，以處百病，以調虛實，而除邪疾。”我們看到這些評價，可以概見前對它的重視程度了。

2. 獨取寸口 難經一難說：“十二經皆有動脈，獨取寸口，以決五藏六府，死生吉凶之法，何謂也？然。寸口者，脈之大会，手太陰之動脈也……五藏六府之所終始，故法取于寸口也。”

脈經上說：“從魚際至高骨，却行一寸，其中名曰寸口。從寸至

尺，名曰尺泽，故曰尺寸。寸后尺前，名曰关。”

至于两手寸口六部的分配藏府，它与上面的三部九候，有些不同，而且就是这一种学说之内，因时代先后，亦互有歧异，列表说明如下：

表 14 寸口分配藏府的几种学说

姓 名	寸		关		尺		备 註
	左	右	左	右	左	右	
王叔和	心 小腸	肺 大腸	肝 胆	脾 胃	腎 膀胱	腎 三焦	以大小二腸配于二寸，取心肺与二腸相表里之义也。
李濒湖	心 膻中	肺 胸	肝 胆	脾 胃	腎 膀胱 小腸	腎 大腸	小腸配于左尺，大腸配于右尺，上下分属之义也。
張景岳	心 膻中	肺 胸中	肝 胆	脾 胃	腎 膀胱 大腸	腎 小腸	大腸配左尺，取金水相从之义；小腸配右尺，取火归火位之义。
分 診 三 焦	宗气出于上焦，寸脉以候之。		营气出于中焦，关脉以候之。		卫气出于下焦，尺脉以候之。		(本表系根据“医学实在易”)

現在临床上通用的，一般是采取李濒湖的学说。但王叔和、張景岳二說，亦有它的道理，根据临床其他証候，可作为参考。至寸、关、尺分診三焦，很为簡單扼要，所以一并加以介紹。

以上是独取寸口的大概情况。这种診脉方法，有的認為始自难經，其实不尽然，在內經上面，早已論及了。如五藏別論上說“气口何以独为五藏主”，就可以証明。不过側重寸口，忽略三部九候、人迎、趺阳等，可能始自难經。同时以內經的“三部九候”名称，單用于寸口而变为一种取脉方法，确乎是始于难經。如十八难上說：“三部者，寸关尺也；九候者，浮中沉也。”它的含义，与內經是名同而实异了。我們以事物发展的眼光来看，独取寸口的方法，当是从三部九候的基础上发展而来，它是比較便于临床工作的，同时在前人的生活实践中，亦肯定了它有很好的实用价值，所以，能在后来的很

長時代里，就一直沿用了它。

現在临床上应用的，一般是采取后一种独取寸口方法。但是我們对某些病証，要作全面性的观察比較，或者要在头手足的某一部分，作深入的考察，那前一种三部九候的方法，是有更好診斷价值的。尤其如“六脉全无”的时候，死生决断，可取診于足。总的說来，我們在临床上应相机行事，一般情况下，可采用独取寸口的方法，但在特殊情况下，三部九候的方法，还得很好运用。同时，我們都很了解，治病救人，方法是多一个好一个，能够多懂得一些，对医生、病家两方面来講，都是有利的。

三、診脉的方法和要求

診脉方法，有很多研究，这里介紹其中几个主要的。

首先是“指法”問題。如朱肱活人書上說：“凡初下指，先以中指端按得关位（掌后高骨为关），乃齐下前后二指，为三部脉，前指，寸口也；后指，尺部也。若人臂長，乃疏下指；若臂短，乃密下指。盧子由学古診則上又說：“人之三指，参差不齐，必使指头齐平，节节相对，方可按脉。但三个指头的皮肉不同，食指最灵，中指则厚，无名指更木厚，故必用指端棱起如綫者名指耳，以按脉之脊。盖脉必有脊，不独洪大勁强之脉有脊，即細小微弱，亦有脊焉。不啻目之視物，大小咸能察焉。若惜其爪甲之長，留而不去，止以指面厚肉診脉，則不灵矣。”王汉臯医存又說：“医者三指之端，亦有动脉，宜知所分別，不可誤以自己之动脉，作为病者之脉。”这些都是有关于指法方面的学說。

其次是“七診”“九候”“五十动”。

医宗必讀上說：“脉有七診，曰浮、中、沉、上、下、左、右，七法推尋。浮者，輕下手于皮毛之間，探其府脉也，表也；中者，略重下指，于肌肉之間，候其胃气也，半表半里也；沉者，重下指于筋骨之間，察其藏脉也，里也；上者，即‘上竟上者，胸喉中事也’，即于寸內前一分取之；下者，即‘下竟下者，少腹、腰股、膝脛足中事也’，即于尺內后一分取之；左右者，即左右手也。凡此七法，名曰七診。

“又有九候，即浮、中、沉，三部各三，合而为名。每部各有浮、

中、沉之候，合寸、关、尺三部算之，共得九候之数。

“每候必观察五十动，乃是古人候脉的常法。灵枢根结篇上说：“持其脉口，数其至也，五十动而不一代者，五藏皆受气；四十动一代者，一藏无气；三十动一代者，二藏无气；二十动一代者，三藏无气；十动一代者，四藏无气；不满十动一代者，五藏无气，予之短期，要在终始。所谓五十动而不一代者，以为常也。”又，张山雷说：“于五十之间，而脉无断续不匀，则可知其血气之未败。第必以五十为衡者，亦犹易言大衍之数五十也。盖其人而正气尚充，必无歇止之脉，若不及五十至而已继续不调，则血气已是不相联属，其凶可知。”

以上是临床上常用的几种寸口诊脉方法，假如能够熟练操作，可以解决一般问题了。至于内经上三部九候的诊察方法，主要是从头、手、足三部和左右之间，比较观察，从各部之间的差异，以为诊断。

关于工作要求，前人亦有深刻研究，兹述其大要如次。首先是注意诊脉的时间问题，如脉要精微论上说：“诊法常以平旦，阴气未动，阳气未散，饮食未进，经脉未盛，络脉调匀，气血未乱，故乃可诊有过之脉”，这是因为平旦环境平静，周围内外对人的刺激较小，假如邪正或有偏差，容易诊察出来。

其次是应该注意我们的工作态度问题，因为，我们的态度如何，不仅它本身就是一个刺激，更重要的，诊脉一事，是细致复杂，明察微妙的工作，决非浮躁粗率，所能成事。所以脉要精微论上说：“持脉有道，虚静为保”，方盛衰论上亦说：“必清必静，上观下观”等等。我们在临床之际，应该要有虚心冷静的态度，要能上面观察气色，下面观察形体，做到如疏五过论上所指出的：“善为脉者，必以比类奇恒，从容知之”，这样地工作，才算得深入细致，审慎从事，合乎工作要求了。

四、诊脉的注意点

诊脉是一件比较复杂细致的工作，既要求有一定的操作技术，也要求关心到内外环境的各种刺激。因为脉息的变动，不仅由于

病而出現，即并非疾病，亦可以随时随地随着环境的迁移而表現波动。这些波动，在临床上每每能够模糊我們的目标。許多前輩于此是受到很多鍛炼的，同时也找出了很多規律，對我們來講，是个很大的帮助，这里扼要地分別介紹如下：

1. 脉与环境的关系 內經上說：“人与天地相參”，这就是說，人是自然界的一个人物，他的生活反映，始終与周圍环境，保持着一个整体統一性，以脉息來講，就是一个最明显的事实。

首先从脉与外在环境的关系来看，素問脉要精微論上說：“万物之外，六合之內，天地之变，阴阳之应，彼春之暖，为夏之暑，彼秋之忿，为冬之怒；四变之动，脉与之上下。”又說：“春日浮，如魚之游在波；夏日在肤，泛泛乎万物有余；秋日下肤，蟄虫將去；冬日在骨，蟄虫周密，君子居室。”灵樞順气一日分为四时篇上又說：“春生夏長，秋收冬藏，是气为常也。人亦应之，以一日分为四时，朝則为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬”，这些文献就具体地描写了脉与环境的一致性表現（一年四时的以及一日四时的）。古人常說：“順四时則生，逆四时則死”。因此，我們應該首先注意。

又，医宗必讀上說：“北方之人，每見实强；南方之人，恒多軟弱。酒后之脉常数，飲后之脉常洪。速行之脉必疾，久飢之脉必空。”这是更充实了上文的意义，說明外在环境中的地理关系和日常生活，在脉中亦有一定的反映。

其次是关于脉与內在环境的关系，我們可以从以下两部分來談：一部分是关于情志方面的影响，素問上面亦早已論及了，它說凡是一个人的惊恐恚劳动靜，脉息都能够变动的。千金翼亦說：“人乐而脉实，人苦而脉虛，性急而脉緩，性緩而脉躁，此皆为逆，逆則难治。反此为順，順則易治。”医学入門更詳論七情之脉，如“喜伤心脉虛，甚則心脉反沉；思伤脾脉結，甚則脾脉反弦；忧伤肺脉澀，甚則肺脉反洪；怒伤肝脉濡，甚則肝脉反澀；恐伤腎脉沉，甚則腎脉反濡；惊伤胆脉动，甚則入肝脉散；悲伤胞絡脉紧，甚則心胞絡与肺系气消而脉虛。”这些討論，都說明了情志上的变化，在脉搏上也有它一定的反映。另一部分是性別、年齡、体格方面的关系，如：妇人之脉，常欲濡弱于丈夫。男左大为順，女右大为順。男子寸

强，女子尺胜。这是性别上的一些差别。又如：少壯之脉多大，衰老之脉多虚。小儿四五岁者，脉自疾駛，呼吸常八至也。这是年龄上的一定差异。又如：人之大小长短，脉之大小长短，皆如其人形则吉。反之则为逆也，人大而脉细，人细而脉大，人壮而脉细，人羸而脉大，此皆为逆。又如：肥人責浮，瘦人責沉（肥人当沉，今反浮；瘦人当浮，今反沉，故責之）。这是说明了体格的不同，脉息亦常有它一定的差异。再如：“脉有反关，动在臂后，别由列缺，不干症候。别有一种，名曰斜飞（又名侧关），尺则犹是，寸关相违。”这说明了在体格方面，尚有它的某些特殊差异。这些说法都是生理上的差异情况，表现于脉搏上的变化。

以上是情志和生理对于脉搏的影响，也就是脉搏与内在环境的关系。再结合上文脉与外在环境的关系来看，这些各种形式的表现，都告诉了我们一个共同的道理，即是脉象一事，并非简单刻板的公式，处处需要揆度，处处需要权衡，只有了解它的一般方面，才能认识它的特殊方面，这是我们应该注意的事。

2. 脉的至数和胃气（表 15）脉的至数，是脉学的一个基础，在讨论脉息变化时，往往要把它作为一个标准。事实上亦是如此，至数的反映，在生理上、病理上突出了许多问题，这是前人的经验积累，直到今天还有宝贵的现实意义。如素问平人氣象論上說：“人一呼脉再动，一吸脉亦再动，呼吸定息脉五动，闰以太息，名曰平人。平人者，不病也。”这是一呼一吸以候平人脉搏至数的主要标准。又說：“人一呼脉一动，一吸脉一动，曰少气。人一呼脉三动，一吸脉三动而躁，尺热曰病温；尺不热，脉滑曰病风；脉澀曰痺。人一呼脉四动以上曰死；脉絕不至曰死；乍疎乍数曰死。”这是至数变化的大略，是我们在临床切脉时所宜加以注意的。至如由于至数变动，暴露出来的许多病情，象“数则为热，迟则为寒”等等，留在下面讨论。

脉搏的有无“胃气”问题，又是脉诊上一个重要问题，古人每每說：“有胃则生，无胃则死”，于此可以想见它的重要程度了。即在脉学的讨论上，亦每每把“胃气”有无，作为平人、病人、将死的衡量标准，如有胃曰平人，胃少曰病，胃絕则死。同时在脉学上，还定出

它的專用名詞，如平脉、病脉、死脉（眞藏脉）之类。至于它在临床上的表現，以脉象来講，在平人气象論上是这样描写的：“脉弱以滑，是有胃气。”灵樞終始篇上亦說：“谷气来也，徐而和。”此外，尚有“微”“緩”等形容。这里將平人气象論一段經文，立表对照，可以提供学习上的参考。

表 15 五藏四时平、病、死脉比較表

（据素問“平人气象論”文、类經注）

藏 时	脉 名	脉 象	注 釋
肝 (春)	春胃微弦曰平。	平肝脉来，軟弱招招，如揭長竿末梢，曰肝平，春以胃气为本。	招招，犹招招也。揭，高举也。高揭長竿，梢必柔軟，即微緩弦長之义。
	弦多胃少曰肝病。	病肝脉来，盈实而滑，如循長竿，曰肝病。	盈实而滑，弦之甚过也。如循長竿，无末梢之和軟也，亦弦多胃少之义。
	但弦无胃曰死。	死肝脉来，急益勁，如新張弓弦，曰肝死。	勁，强急也。如新張弓弦，弦之甚也，亦但弦无胃之义。
心 (夏)	夏胃微鈎曰平。	平心脉来，累累如連珠，如循琅玕曰心平，夏以胃气为本。	脉来中手如連珠，如循環玕者，言其甚滿滑利，即微鈎之义也。琅玕，玉而有光者，似珠。
	鈎多胃少曰心病。	病心脉来，喘喘連属，其中微曲，曰心病。	喘喘連属，急促相仍也。其中微曲，即鈎多胃少之义。
	但鈎无胃曰死。	死心脉来，前曲后居，如操帶鈎，曰心死。	操，持也。前曲者，謂輕取則坚强而不柔。后居者，謂重取則牢实而不动，如持革帶之鈎，而全失冲和之气，是但鈎无胃也。
脾 (長夏)	長夏胃微軟弱曰平。	平脾脉来，和柔相离，如鸡踐地，曰脾平，長夏以胃气为本。	和柔，雍容不迫也。相离，勻淨分明也。如鸡踐地，从容輕緩也。此即冲和之气，亦微軟弱之义。
	弱多胃少曰脾病。	病脾脉来，实而盈数，如鸡举足，曰脾病。	实而盈数，强急不和也。如鸡举足，輕疾不緩也。言弱多胃少，言实而盈数，皆失冲和之气。
	但代无胃曰死。	死脾脉来，銳坚如烏之喙，如烏之距，如屋之漏，如水之流，曰脾死。	如烏之喙，如烏之距，言銳不柔也。如屋之漏，点滴无倫也。如水流，去而不返也。是皆脾气絕而怪脉見，亦但代无胃之义。

(續上表)

藏 时	脉 名	脉 象	注 釋
肺	秋胃微毛曰平。	平肺脉来，仄仄翕翕，如落榆荚，曰肺平，秋以胃气为本。	仄仄翕翕，众苗齐秀貌。如落榆荚，輕浮和緩貌。即微毛之义。
	毛多胃少曰肺病。	病肺脉来，不上不下，如循鸡羽，曰肺病。	不上不下，往来澀滯也。如循鸡羽，輕浮而虛也。亦毛多胃少之义。
	(秋) 但毛无胃曰死。	死肺脉来，如物之浮，如风吹毛，曰肺死。	如物之浮，空虚无根也。如风吹毛，散乱无緒也。亦但毛无胃之义。
腎	冬胃微石曰平。	平腎脉来，喘喘累累，如鉤，按之而坚，曰腎平，冬以胃气为本。	冬脉沉石，故按之而坚。若过于石，則沉伏不振矣。故必喘喘累累，如心之鉤。阴中藏阳，而得微石之义。
	石多胃少曰腎病。	腎病脉来，如引葛，按之益坚，曰腎病。	脉如引葛，坚搏牽連也。按之益坚，石甚不和也。亦石多胃少之义。
	(冬) 但石无胃曰死。	死腎脉来，发如夺索，辟辟如殫石，曰腎死。	索如相夺，其勁必甚。辟辟如殫石，其坚必甚。即但石无胃之义。

至于脉息胃气的由来，古人認識到这是生成于谷气。如云：“谷气入胃，五藏六府皆以受气，故平人之常气稟于胃。胃者，平人之常气也。”又如“五藏者，皆稟气于胃，胃者，五藏之本也。藏气者，不能自致于手太阴，必因于胃气，乃至于手太阴也。”根据这些說法，所謂胃气問題，病人的納谷情况，亦是一个重要之点。因为納谷如何，可以决定血脉的供給如何，也直接或間接地影响到“弱以滑”或“徐而和”等的反映程度如何，这是关于胃气問題的大略。

以上提出的几个注意点，是使我們在繁复的脉学中，心中有个預見，是病还是不病，是常还是变，才不致忙乱应付。三部九候論上亦說：“必先知經脉，而后知病脉”，就是指出了这个道理。惟此中尚有很多材料，有待于我們作进一步探討，这里不过举出一些大概而已。

五、脉象的認識

脉象方面，学說亦很多，代有发明，其中能够集經典之大成，且詳为立論的，似应以王叔和的学說，为最可取法。这里就主要采用

他的材料，結合一些后来成就，分述如下。

1. 二十八脉象

浮脉：举之有余，按之不足（浮于手指下）。

沉脉：举之不足，按之有余（一曰：重按之乃得）。

迟脉：呼吸三至，去来极迟。（一曰：举之不足，按之尽牢。一曰：按之尽牢，举之无有。吳山甫：医者一呼一吸，病者脉来三至，曰迟。）

数脉：去来促急。（一曰：一息六七至，一曰数者进之名。）

滑脉：往来前却流利展轉，替替然，与数相似。（一曰：浮中如有力。一曰：漉漉如欲脱。）

涩脉：細而迟，往来难且散，或一止复来。（一曰：浮而短。一曰：短而止；或曰，散也。戴同父：脉来蹇涩細而迟，不能流利圓滑者。）

虚脉：迟大而軟，按之不足，隱指豁豁然空。（周正倫：虛者，不实也，无力为虛，按至骨无脉者，謂之无力也。）

实脉：大而長微强，按之隱指愒愒然。（一曰：沉浮皆得。滑寿：按举不絕，迢迢長动而有力，不疾，不迟，为三焦气滿之候。）

長脉：長脉迢迢，首尾俱端，直上直下，如循長竿。

短脉：短脉澀小，首尾俱俯，中間突起，不能滿部。（滑寿：两头无、中間有，不及于本位。）

洪脉：极大，在指下（一曰：浮而大）。

微脉：极細而軟，或欲絕，若有若无。（一曰：小也。一曰：手下快。一曰：浮而薄。一曰：按之如欲尽。張璐：按之稍有模糊之狀，不似弱脉之小弱而分明、細脉之纖細而有力也。）

紧脉：数如切繩狀。（一曰：如轉索之无常，不散，其广有界限，而脉与肉間划然分明之謂也。）

緩脉：去来亦迟，小駛于迟。（一曰：浮大而軟，阴浮与阳同等。吳山甫：緩之狀，如琴弦之久失更張，縱而不整。曰緩，与迟不同。迟以数言，緩以形言。）

芤脉：浮大而軟，按之中央空，两边实。（一曰：手下无，两旁有。）

弦脉：举之有余，按之如弓弦状。（一曰：如张弓弦，按之不移。又曰：浮紧为弦。戴同父云：从中直过，挺然指下。）

革脉：弦而芤，如按鼓皮。（李东壁：革者虚，牢者实。）

牢脉：有似沉伏，实大而长微弦（沉坚有根之极）。

软脉：极软而浮细。（一曰：按之无有，举之有余。一曰：小而软；软亦作濡，曰濡者，如帛衣在水中，轻手相得。）

弱脉：极软而沉细，按之欲绝指下。（一曰：按之乃得，举之无有。李东壁：弱乃濡之沉者。）

散脉：大而散；散者，气实血虚，有表无里。（滑寿：按之散满于指而不聚，来去不明，漫无根柢。）

细脉：小大于微，常有，但细耳。（李中梓：微脉则模糊而难见，细脉则且明而易见，故细比于微稍稍为大也。）

伏脉：极重指按之，着骨乃得。（一曰：手下裁动。一曰：按之不足，举之无有。一曰：关上沉不出，名曰伏。虽重按亦不得，必推筋乃见也。）

动脉：见于关上，无头尾，大如豆，厥厥然动摇。（何梦瑤：数而跳突名曰动……大惊多见此脉，盖惊则心胸跳突。）

促脉：来去数，时一止，复来。

结脉：往来缓，时一止，复来。（张介宾：脉来忽止，止而复起，总谓之结。）

代脉：来数中止，不能自还，因而复动。脉结者生，代者死。（张介宾：代者，更代之义，而于平脉之中，忽见软弱，或乍数乍疏，或断而复起，均名曰代。）

疾脉：疾为急疾，数之至极，七至八至，脉流薄疾。

2. 十怪脉象（危亦林得效方）：

一曰釜沸，二曰鱼翔，三曰弹石，四曰解索，五曰屋漏，六曰虾游，七曰雀啄，八曰偃刀，九曰转豆，十曰麻促。

釜沸：脉在皮肤，有出无入，如汤涌沸，息数俱无，乃三阳数极，无阴之候，朝见夕死，夕见朝死。

鱼翔：脉在皮肤，头定而尾摇，浮泛泛泛，三阴数极曰亡阳，当以死断。

彈石：脉在筋肉間，辟辟湊指，促而堅，乃腎經真藏脉見，遇戊己日則不治。

解索：脉如解亂繩之狀，散散無序，腎與命門之氣皆亡，戊己日篤，辰巳日不治。

屋漏：脉在筋肉間，如殘蠶之下，良久一滴，濺起無力，狀如水滴濺地貌。胃氣營衛俱絕，七八日死。

蝦游：脉在皮膚，如蝦游水面，杳然不見，須臾又來甚急，又依前隱然不動。醒者七日死，困者三日死。

雀啄：脉在筋肉間，連連湊指，忽然頓無，如雀食之狀，蓋來三而去一也。脾元谷氣已絕于內，醒者十一日死，困者六七日死。

偃刀：脉如手循刀刃，無進無退，其數無准。由心元血枯，衛氣獨居，無所歸宿，見之四日難療。

轉豆：脉形如豆，周旋展轉，并無息數。藏府空虛，正氣漂散，象曰行尸，其死可立待也。

麻促：脉如麻子之紛亂，細微至甚。蓋衛枯榮血獨澀，輕者三日死，重者一日殂矣。

以上是二十八脉象和十怪脉象，它在临床上都是可以遇到的，其實有的已很熟悉，如浮、沉、迟、數之類。但總的來說，要全部掌握它，是要經過一番艱苦的。前人在这方面，付出了很大的鉅研精力，從這些鉅研中，也確實找到了很多竅門，如分類方法、脉學提綱等等，可以幫助我們進一步做好這個工作。這裡再引述如下，以供參考。

首先在脉學的分類方法上，王叔和已用了一番功夫，他說：浮與扎相類，弦與緊相類，革與實相類（千金翼作牢與實相類，是），滑與數相類，沉與伏相類，微與澀相類，軟與弱相類，緩與迟相類，等等。然這種分類，似乎比較簡略，不能滿足于我們的願望。洄溪脉學的“審象論”，對此启发較多，擇要介紹如下：

一曰比類以晰其似。所以明相類之脉，比其類而合之，辯其異而分之，鮮不決之疑矣。如迟之與緩，似乎同也，而迟則一息三至，脉小而衰；緩則一息四至，脉大而徐。沉之與伏，似乎同也，而沉則輕舉則無，重按乃得；伏則重按亦無，推筋乃見。數、緊、滑，似乎同

也，而數則來往急迫，呼吸六至；緊則左右彈指，狀如切繩；滑則往來流利，如珠圓滑。浮、虛、芤，似乎同也，浮則舉之有余，按之不足；虛則舉之迟大，按之无有；芤則浮沉可見，中按則无。濡之与弱，似乎同也，而濡則細軟而浮，弱則細微而沉。微之与細，似乎同也，而微則不及于細，若有若无，狀类蛛絲；細則稍胜于微，应指极細，狀比一綫。弦与長，似乎同也，而弦則狀如弓弦，端直挺然，而不搏指；長如長竿，过于本位，而不搏指。短与动，似乎同也，而短为阴脉，无头无尾，其來迟滯；动为阳脉，无头无尾，其來數滑。洪之与实，似乎同也，而洪則狀如洪水，盛大滿指，重按則稍減；实乃充实，应指有力，举按皆然。牢之与革，似乎同也，而牢則实大而弦，牢守其位；革則虛大浮弦，內虛外急。促、結、澀、代，似乎同也，而促則急促，數時暫止；結为凝結，迟則暫止；澀則迟短澀滯，至而帶止，三五不調；代則动而中止，不能自还，止數有常，非暫之比。

一日对举以明相反之脉。有可因此而悟彼者，令阴阳不乱也。如浮沉者，脉之升降也，以察阴阳，以分表里。浮法天、为輕清；沉法地、为重濁也。迟数者，脉之急慢也。脉以四至为和平，如見五至，必形气壯盛，或聞以太息、五至皆为无病之象。不及为迟，太过为数。迟阴在藏，数阳在府。数在上为阳中之阳，在下为阴中之阳；迟在上为阳中之阴，在下为阴中之阴。虛实者，脉之剛柔也，皆以內之有余不足，故咸以按而知之。長短者，脉之盈縮也。長者見于尺寸，有通于三部；短不見于尺寸，盖必質于中而后知，过于中为長，不及于中为短。滑澀者，脉之通滯也。千金曰，滑者血多气少，血多故流利圓滑；澀者气多血少，血少故艰澀而散。洪微者，脉之盛衰也。血热而盛，气随以溢，滿指洪大，冲涌有余，故洪为盛；气虛而寒，血随以澀，应脉微渺，欲絕非絕，故微为衰。紧緩者，脉之弛張也。紧为寒伤营血，脉絡激搏，若风起水涌，又如切繩轉索；緩为风伤卫气，营血不流，脉不能疾速，宛如徐行而怠。数見关上，形如豆大，厥厥动摇，异于他部者，动也；深藏于內，不見其形，脉在筋下者，伏也。結促者，脉之阴阳也。阳甚則促，促疾而时止；阴甚則結，結徐而时止。至于代、牢、弦、革、芤、濡、細、弱八脉，則又不可以对举也。

一曰辨兼至者，所以明相互之脉。大抵脉独見为証者鮮，合众脉为証者多。姑举一二，以例其余，如似沉似伏实大弦長之合为牢、极軟极細之合为濡之类是也。合众脉之形为一証者，如浮緩为不仁、浮滑为风痰、浮洪大而長为风眩癰疾之类是也。有二合脉、三四合脉者，然又有一脉独見，而为疾亦多者，如浮为风，又为虛，又为阳，此一脉之証合也。

以上是脉学分类說法的大概，在二十多种紛繁的脉象中，进行分析辨認，对我们学习来講，可以有比較清楚的印象。但要求能够再进一步，綱举目張，执簡馭繁，在临床上更能心手了然，那脉学的提綱学說就更可貴了。

在脉学提綱問題上，前人用心，亦是很多的，如最早就提出一个“阴阳”綱領，使复杂的脉象，定出了一个辨別的方向，临床工作，亦初初有个簡化扼要的概念。例如素問阴阳別論上說：“脉有阴阳，所謂阴者，真藏也，所謂阳者，胃脘之阳也。別于阳者，知病处者；別于阴者，知死生之期。”这是以脉的有胃气或沒有胃气来分別的。难經上說：“脉有阴阳之法，何謂也？然，呼出心与肺，呼入腎与肝，呼吸之間，脾受谷味也，其脉在中。浮者，阳也；沉者，阴也。故曰阴阳也。”这是以脉的应指浮沉来分別。脉經上又說：“关前为阳，关后为阴。阳数則吐血，阴微則下利。阳弦則头痛，阴弦則腹痛。依此阴阳以察病也。”这是以脉的前后部位来分別的。又說：“凡脉之大为阳，浮为阳，数为阳，动为阳，長为阳，滑为阳；沉为阴，澀为阴，弱为阴，弦为阴，短为阴，微为阴。是为三阴三阳也。阳病見阴脉者，反也，主死；阴病見阳脉者，順也，主生。”这是以脉象病情来分別的。以上种种，是阴阳綱領的大概。这种綱領，可說得其要領，然未免太嫌原則一些，仍未易掌握。所以，后人又有一些补充主張，如四綱——浮沉迟数、六綱——浮沉迟数滑澀、八綱——浮沉迟数滑澀虛实（或短長）、十綱——上下来去至止迟数浮沉，等說。其中最通用的要算滑伯仁提出的六綱，很便利于临証工作，再附其說如下：

“凡取脉之道，理各不同；脉之形狀，又名非一。凡脉之来，必不單至，必曰浮而弦、浮而数、沉而紧、沉而細之类，將何以別之？

大抵提綱之要，不出浮、沉、迟、数、滑、澀之六脉也。浮沉之脉，輕手重手而取之也；迟数之脉，以己之呼吸而取之也；滑澀之脉，則察往来之形也。浮为阳，輕手而得之也，而芤、洪、散、大、長、濡、弦，皆輕手而得之之类也；沉为阴，重手而得之也，而伏、石、短、細、牢、实，皆重手而得之之类也。迟者一息脉三至，而緩、結、微、弱，皆迟之类也；数者一息脉六至，而疾、促皆数之类也。或曰，滑类乎数，澀类乎迟，何也？然脉虽似，而理則殊也。彼迟数之脉，以呼吸察其至数之疎密；此滑澀之脉，則以往来察其形狀也。数为热，迟为寒；滑为血多气少，澀为多气少血。

“所謂脉之提綱，不出乎六字者，盖以其足以統夫表里阴阳寒热虛实、风寒燥湿、藏府血气也。浮为阳为表，診为风为虛；沉为阴为里，診为湿为实。迟为在藏，为寒为冷；数为在府，为热为燥；滑为血有余，澀为气独滯也。人一身之变，不越乎此，能于是六脉之中以求之，則疾疾之在人者，莫能逃焉。”

关于寸口脉象学說，大致的介紹到这里，告一段落。我們首先是泛論二十八脉知十怪脉，其次是介紹脉学的分类方法，最后討論脉学的提綱問題。如此，对寸口脉象学說，已举其大要。至于三部九候的脉象，主要是“察九候，独小者病，独大者病，独疾者病，独迟者病，独热者病，独寒者病，独陷下者病”，它比寸口学說，要簡單得多。

这个脉象問題，是脉学中的一个关键問題，無論是学习也好，运用也好，不能不承認，它是一个考驗的关口。事实要求是如此，不論今天是学习，或明天去工作，都要求我們能够突破这个关口，才可以成为脉学上的內行，才可以真正有利于工作。根据上面的說法，脉象自有数十种的表現，而且还有很多的差异，究竟如何才能熟习它呢？我們体会，除了钻研上面所說的理論以外，还得不断地从实践中去鍛煉，也就是在日常工作中，先候候自己的脉，再去比比病員的脉，进一步再从輕重病員中去比較，再从各种不同的病員中去比較，积累經驗，熟能生巧，自然能够逐步熟习它和掌握它。

六、脉与病的关系

上节在脉象方面，已介紹了好多學說，如各種形狀描寫、分類鑑別、提綱歸納等等，對二十多種脈象，大致上可以有個概念了。這裡還有另一種方法，可以幫助我們掌握各種脈象的出現和變化，就是把脈象與病証聯繫起來看，也就是前人主張的“從症測脈，從脈測症”，所謂脈的“主病”。事實上確是如此，脈與病，是密切關聯着的，我們只要一看到某些一連串的証候，就可以推想到它會出現某種脈象，所謂“有此病，即有此脈。”例如“傷寒脈緊、傷風脈緩、熱病脈盛（洪或數）、中暑脈虛”等等，就是明顯的事實。這樣做去，比上面所說的那些方法，又多了一個把握。

關於這方面的研究，古人是用了很大功夫的，所以著作亦非常多。這裡採用的是“脈訣啟悟”的學說，比較顯豁扼要。如能更進一步鉅研，從內、難、脈經以下，積有豐富資料，可以給我們作有益的參考。至於這裡的寫法，述要如下：首先是標明“主病”，將某一種脈與某一種病，有一定關係的，大致上把它規定下來，使我們在臨症上，見証可以測脈，切脈可以測証，例如表症其脈必浮，脈浮亦為風邪之類。其次是標明“寸關尺”兩手六部，臟腑分屬有別，則脈象之出現，就直接關係到各該臟腑之病變。例如數脈見于右寸，數為熱，右寸屬肺，病主肺熱；遲脈見于左寸，遲為寒，左寸屬心，病主心痛停凝等等。這樣，在一般主病的基礎上，再進一步分部觀察，對病情的了解，就更深刻。又其次是標明“虛實”，因為任何疾病，都是一個邪正互為消長的關係，經文所謂“邪氣盛則實，精氣奪則虛”。我們切脈，亦重要在抓住這個關鍵，有了這個概念，才可以進一步考慮到邪屬何氣、病在何部。第三點標明“兼脈”，因為單純的脈，或單純的病，在臨床上是比較少見的，往往是二合、三合、四合兼見。兼脈以本脈為主題，在這個主題下可能兼見的，都把它歸攏起來討論。這樣，對錯綜複雜的脈與病的變化，又可以多一個認識。但是，有一個情況須要說明，有的脈可以兼見許多變化，而有的脈呢？往往是與別脈兼見的，所以，同是一個脈，材料就各有多少。即上面虛實一項，亦有類此情況，有的本身已是虛脈，

或者已是实脉了，那就不能再分虚实。这里把“脉诀启悟”文献选录如下：

浮脉

主病：浮脉为阳，风邪在表。

寸关尺：右寸脉浮，伤风鼻塞；左寸脉浮，伤寒头痛。左关脉浮，肝胆风邪；右关脉浮，风伤脾胃。右尺脉浮，风犯命脉，左尺脉浮，太阳犯本。

辨虚实：无力表虚，有力表实。

辨兼脉：浮紧风寒，浮缓风湿，浮数风热，浮洪风火，浮涩伤营，浮芤失血，浮短气亏，浮濡气衰。

沉脉

主病：沉脉为阴，邪伏在里，里无伏邪，只为气滞。

寸关尺：右寸脉沉，肺病喘咳；左寸脉沉，暴怒伤营。左关脉沉，肝胆气结；右关脉沉，中满食滞；右尺脉沉，寒侵便溏；左尺脉沉，气伏溺闭。

辨虚实：无力里虚，有力里实。

辨兼脉：沉迟滞冷，沉数内热，沉滑痰饮，沉涩血结（或称气郁），沉弱虚衰，沉牢坚积，沉紧冷痛，沉缓寒湿，沉弦伏饮，沉细阳衰。

迟脉

主病：迟主藏寒，其病为阴。

寸关尺：右寸脉迟，肺痿咳沫；左寸脉迟，心痛停凝。左关脉迟，症结攣筋；右关脉迟，火虚冷滞；左尺脉迟，溲便不禁；右尺脉迟，火衰飧泄。

辨虚实：有力积冷，无力虚寒，伤寒伤变，兼滑非寒。

辨兼脉：浮迟表冷，沉迟里寒，迟滑胀满，迟涩血寒，迟弦饮积，迟结物凝，迟细寒湿，迟微阳脱。

数脉

主病：数主府热，其病为阳。

寸关尺：右寸脉数，肺癰喘咳；左寸脉数，火炎口瘡。左关脉数，肝胆火邪；右关脉数，脾胃实热。左尺脉数，遺濁淋閉；右尺脉

数，燥結便紅。

辨虛實：有力實火，無力虛火。

辨兼脈：浮數表熱，沉數里熱，弦數肝火，緩數濕火，陽數君火，陰數相火，左數陰傷，右數火亢。

滑脈

主病：滑為血盛，主痰主孕；滑為邪盛，百病皆順。

寸關尺：右寸脈滑，哮喘痰嗽；左寸脈滑，恍惚怔忡。左關脈滑，胆府邪侵；右關脈滑，痰滯脾胃。左尺脈滑，遺精白濁；右尺脈滑，下利窘迫。

辨虛實：無力虛痰，有力實滯。

辨兼脈：浮滑風痰，沉滑痰食，滑數痰火，滑短氣病。浮而滑散，中風癱瘓；滑而沖和，懷孕可決。

澀脈

主病：澀為血少，氣滯傷精。

寸關尺：右寸脈澀，傷燥咳沫；左寸脈澀，驚悸傷營。左關脈澀，血少邪遏；右關脈澀，心痛噎膈。左尺脈澀，遺濁頑嗣；右尺脈澀，液涸結腸。

辨虛實：有力澀滯，無力虛衰。

虛脈

主病：虛主血虛，又主傷暑。

寸關尺：右寸脈虛，自汗氣怯；左寸脈虛，驚悸怔忡。左關脈虛，血不榮筋；右關脈虛，飲食難化。左尺脈虛，腰膝痠痺；右尺脈虛，真火衰弱。

實脈

主病：邪實脈實，火實壅結。

寸關尺：右寸脈實，咳逆咽痛；左寸脈實，舌強氣涌。左關脈實，火壅脇痛；右關脈實，脹滿疼痛。右尺脈實，溺閉腹滿；右尺脈實，相火亢逆。

辨兼脈：實而且緊，寒積稽留；實而且滑，痰凝見祟；實而清長，藏氣之充；實而數大，府熱之聚。

長脈

主病：長主有余，气逆火盛；長而清圓，寿征之診。

寸关尺：右寸脉長，逆滿之病；左寸脉長，君火为病。左关脉長，木实之殃；右关脉長，土郁脹悶。左尺脉長，奔豚气逆；右尺脉長，相火專令。

短脉

主病：短主不及，为气虛病。

寸关尺：右寸脉短，头痛肺虛；左寸脉短，心神不足。左关脉短，肝气有伤；右关脉短，膈气为殃。左尺脉短，少腹必疼，右尺脉短，真火不隆。

洪脉

主病：洪为盛滿，气盛火亢；如見虛洪，火浮水涸。

寸关尺：右寸脉洪，胸滿气逆；左寸脉洪，心煩舌破。左关脉洪，肝木太过；右关脉洪，胃热脹悶。左尺脉洪，水枯溺澀；右尺脉洪，龙火燔灼。

微脉

主病：微为亡阳，气血大衰。

寸关尺：右寸脉微，虛汗喘促；左寸脉微，神虛惊悸。左关脉微，肝虛寒慄；右关脉微，胃虛冷逆。左尺脉微，髓竭精伤；右尺脉微，阳亡命絕。

紧脉

主病：紧主寒邪，亦主諸痛。

寸关尺：右寸脉紧，伤寒喘嗽；左寸脉紧，心痛滿急。左关脉紧，外伤寒邪；右关脉紧，内伤冷食。左尺脉紧，奔豚疝疾；右尺脉紧，小腹急痛。

辨兼脉：浮紧表寒，沉紧里寒。急而紧者，是为遁尸；数而紧者，当主鬼击（言突然发病）。

緩脉

主病：緩为胃气，亦主湿邪。

寸关尺：右寸浮緩，风邪所伤；左寸澀緩，少阴血虛。左关浮緩，肝风内鼓；右关沉緩，土弱湿侵。左尺緩澀，精室空虛；右尺緩細，真阳衰弱。

辨兼脉：浮緩伤风，沉緩寒湿。緩大风虛，緩細湿痺，緩澀脾薄，緩弱气虛。

芤脉

主病：芤脉中空，主失血症。

寸关尺：右寸脉芤，相傳阴亡；左寸脉芤，心主喪血。左关脉芤，汗血不藏；右关脉芤，脾血不攝。左尺脉芤，精漏亡阴；右尺脉芤，便紅为咎。

弦脉

主病：弦为肝风，亦主气郁，主痛主飲，主瘧主痢。

寸关尺：右寸脉弦，胸及头痛；左寸脉弦，心中必痛。左关脉弦，痙瘧症瘕；右关脉弦，土虛停飲。左尺脉弦，飲聚疝瘕；右尺脉弦，腹痛下痢。

辨兼脉：浮弦支飲，沉弦悬飲。弦数多热，弦迟多寒，弦大劳伤，弦細拘急。阳弦头痛，阴弦腹痛。單弦飲癖，双弦寒瘤。

革脉

主病：革主表寒，亦属中虛。

寸关尺：右寸脉革，金衰气壅；左寸脉革，心血虛痛。左关脉革，疝瘕为祟；右关脉革，土虛木疼。左尺脉革，精空可必；右尺脉革，女人半产。

牢脉

主病：牢主坚积，病在于阴。

寸关尺：右寸脉牢，息賁为疾；左寸脉牢，伏梁为病。左关脉牢，肝結血积；右关脉牢，阴寒痞癖。左尺脉牢，奔豚气逆；右尺脉牢，阴凝积結。

濡脉

主病：濡主阴虛，髓竭阴伤，病因新暴，势必垂亡。

寸关尺：右寸脉濡，腠虛自汗；左寸脉濡，健忘惊悸。左关脉濡，血虛筋攣；右关脉濡，脾虛湿侵。左尺脉濡，精血枯損；右尺脉濡，火敗命乖。

弱脉

主病：弱主阳衰，真气衰弱；弱为阳陷，久病非剧。

寸关尺：右寸脉弱，自汗短气；左寸脉弱，惊悸健忘。左关脉弱，筋枯挛急；右关脉弱，水谷成疴。左尺脉弱，涸流可征；右尺脉弱，阳衰可驗。

散脉

主病：散主腎敗，見則危殆。

寸关尺：右寸脉散，自汗淋漓；左寸脉散，怔忡不寐。左关脉散，溢飲之疴；右关脉散，脹滿蠱疾。左尺脉散，北方水竭；右尺脉散，阳消命絕。

細脉

主病：細主气衰，亦主湿侵；諸虛勞損，細則為甚。

寸关尺：右寸脉細，咳嘔气怯；左寸脉細，怔忡不寐。左关脉細，肝阴枯竭；右关脉細，胃虛脹滿。左尺脉細，遺滑甚忧；右尺脉細，下元冷儻。

伏脉

主病：伏脉为阴，受病入深；阴遏阳伏，获汗为珍。

寸关尺：右寸脉伏，邪伤卫征；左寸脉伏，邪伤营征。左关脉伏，肝血在腹；右关脉伏，寒凝水蓄。左尺脉伏，疝瘕結核；右尺脉伏，火衰阳伏。

动脉

主病：动脉主痛，亦主于惊。

寸关尺：右寸脉动，自汗喘促；左寸脉动，惊悸煩乱。左关脉动，拘攣掣痛；右关脉动，脾虛疹热。左尺脉动，失精亡髓；右尺脉动，火迅龙飞。

促脉

主病：促因火亢，亦主物停。

寸关尺：右寸脉促，肺鳴咯咯；左寸脉促，心火炎炎。左关脉促，血燥生殃；右关脉促，脾宮食伤。左尺脉促，遺精滑脫；右尺脉促，灼熱亡阳。

結脉

主病：結属阴寒，亦因凝积。

寸关尺：右寸脉結，肺虛寒凝；左寸脉結，心冷疼甚。左关脉

結，疝瘕凝結；右关脉結，痰积食停。左尺脉結，痿躄之病；右尺脉結，阴寒为甚。

代脉

主病：代主藏衰，危惡之候。脾土敗坏，吐利为咎；中寒不食，腹痛难救。二动一止，三四日死；四动一止，六七日死。次第推求，不失經旨。

疾脉

主病：病为阳极，阴气欲竭；脉号离經，虛魂將絕。渐进渐疾，且夕殞灭，毋論寸尺，短期已决。

以上二十八脉的主病，是临症上所习用的，可以作为主要参考。但这些討論，都是脉与症相一致的情况。此外，尚有脉与症不一致的情况，所謂变常情况，如“舍脉从症、舍症从脉”之类，在临症上亦是一个要紧关头，我們不可以不懂得，否則就要穷于应付，失之机变。茲再介紹医宗必讀的学說如下。

从症不从脉 脉浮为表，治宜汗之，此其常也，而亦有宜下者焉。仲景云，若脉浮大，心下硬，有热属藏者，攻之，不令发汗是也。脉沉为里，治宜下之，此其常也，而亦有宜汗者焉。少阴病，始得之，反发热，而脉沉者，麻黄附子細辛湯微汗之是也。脉促为阳，管用葛根芩連湯之矣；若脉促厥冷为虛脱，非灸非溫不可，此又非促为阳盛之脉也。脉迟为寒，管用干姜、附子溫之矣；若阳明病脉迟，不惡寒，身体濈濈汗出，則用大承气，此又非迟为阴寒之脉矣。四者皆从症不从脉也。世有切脉而不問症者，其誤可胜言哉。

从脉不从症 表症汗之，此其常也；仲景曰，病发热头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里，用四逆湯，此从脉之沉也。里症下之，此其常也；日晡发热者，属阳明，脉浮者宜发汗，用桂枝湯，此从脉之浮也。結胸症悉具，嘗以大小陷胸下之矣；脉浮大者不可下，下之則死，是宜从脉而治其表也。身疼痛者，嘗以麻黄、桂枝解之矣；然尺中迟者，不可汗，以營血不足故也，是宜从脉而調其營矣。此皆从脉不从症也。世有問症而忽脉者，得非仲景之罪人乎。

舍脉从症和舍症从脉，即或以症为主，或以脉为主，說起来好象各有所重，实际上切脉本为四診之一，不能代表全面，而有时脉

象却占辨症的主要地位。但其中有一个基本精神，就是整体观点，也就是“治病必求于本”，总以病人的全身情况为判断的。

又古人論脉，每每謂可以决死生，定吉凶，究竟他凭什么能够做到这一点呢？医学源流論上，綜合前人經驗，很充分的答复了这个問題，特再表而出之，使脉診在临床上，可以發揮它的最大效用。它說：

生死于人大矣，而能于两手方寸之地，微末之动，即能决其生死，何其近乎誣耶！然古人往往百不失一者，何哉？其大要則以胃气为本。盖人之所以生，本乎飲食。灵樞云：谷入于胃，乃傳之肺，五藏六府，皆以受气。寸口属肺經，为百脉之所会，故其来也，有生气以行乎其間，融和調暢，得中土之精英，此为有胃气，得者生，失者死，其大較也。其次則推天运之順逆，人气与天气相应，如春气属木，脉宜弦；夏气属火，脉宜洪之类，反是則与天气不应。又其次則审藏府之生尅，如脾病畏弦，木尅土也；肺病畏洪，火尅金也，反是則与藏气无害。又其次則辨病脉之从違，病之与脉，各有宜与不宜，如脫血之后，脉宜靜細，而反洪大，則气亦外脫矣；寒热之症，脉宜洪数，而反細弱，則真元將陷矣；至于真藏之脉，乃因胃气已絕，不营五藏，所以何藏有病則何藏之脉独現。凡此，皆內經、难經等書，言之明白尽詳，学者苟能潜心觀玩，洞然易曉，此其可决者也。

脉与病的关系，大致的介紹到这里。其中給我們很大启发的，就是說明了脉象虽然很多，但是它的出現，是在一定环境之下，有怎样的病，就会有怎样的脉；固然脉学的要求是“从脉测症”，但另一方面，也可以“从症测脉”，这里是有其相互关系的。至于所介紹的舍症从脉、舍脉从症的說法，可以增加我們在临床上的活法，也告訴我們，对脉、症之間的問題，不能过于机械地看待，有常有变，應該灵活从事。最后医学源流論一节，对脉診可以决生死問題，做了具体交代，已不是一句空話了，有它的内容，有它的目标，能够善为运用，是具有重要的診斷价值的。

小 結

脉学一事，我們以客觀态度来分析，的确有它的道理。几十种

的脉象，它是会从病人的身体上表现出来的，如伤寒脉紧、伤风脉缓，就是具体的事实。再以历史知识来谈，历代医工，不仅运用了它，而且也发展了它，经验的积累，历史的成就，都要求我们继承下来，流传下去。同时事实也告诉我们，脉学是可以学会的，浮、沉、迟、数，大家都有些经验，进一步提高，关键是一个功力深浅问题。至学习方法，主要是提高理论，和不断实践，能够把理论与实践一致起来，是没有不成功的道理的。

这里介绍的材料，第一点是着重说明脉学的意义和它所起的作用，是从它的怎样发生搏动以及在波动中能看出邪正两方面问题来谈的。其次是介绍诊脉的部位，举出了三部九候和独取寸口两种学说，一般以独取寸口为最通用。又其次是讨论诊脉的方法和要求，叙述了诊脉的指法，七诊、九候、五十动和时间、态度等问题。第四是提出脉诊的注意点，说明了“必先知经脉，而后知病脉”的精神。第五是介绍脉象学说，当然，这是一个比较困难的关口，但除了一般的认识以外，还运用了分类、提纲等方法，可以帮我们更容易掌握它。只要肯在理论上钻研，并加以日常的锻炼，困难是可以解决的。最后提出脉的主病问题，一方面可以帮助对脉象的认识，另一方面把脉病关系的一般情况和特殊情况，加以反复讨论。这样，对脉学就已作了大体上的介绍。

至如脉学的诊断价值，已如上述，而古人亦把它强调到很重要地位，如内经上说“诊病之始、五决为纪”，又说“微妙在脉，不可不察”等等，似乎要看病，非依靠脉诊不可，其实这是由于前人在实际工作中，运用有心得，能够解决问题，所以爱护与叮嘱，恳切深远。但是，祖国医学，丰富多采，到了近代，在诊断学上的成就，已发展到和形成了它的一个整体系统，望、闻、问、切，积累了很多知能，不仅止于脉学一点了，假如我们能够配合运用，多方面诊察，则临症工作，会做得更好，诊断作用，也起得更大，这是我们应该注意的。即以前人来看，亦是很多种多样的，常常把脉诊与色诊、问诊等结合运用，并且说：“卒持寸口、何病能中？”又说“知一则为工、知二则为神、知三则神且明矣”，于此，我们可以了解，临症上是应该怎样的恰当地去运用脉诊了。

乙、触 診

切診除了切脉之外，尚有診尺肤、按胸腹等，亦属于切診范围之内。其方法亦是利用医生的手，直接接触病人的身体病变部分，探察疾病的反映情况，如或溫、或冷、或硬、或痛等，从而分析病情，帮助診斷，作出更全面的决定。古人在这方面的运用，有很多經驗，茲簡要介紹其中概略，分为診尺肤、診肌表、診手足、診胸腹等四点，总称之为触診。

一、診 尺 肤

診尺肤的触診方法，在古人已很重視，內經上面，早有記載，灵樞里且有专篇討論，如“論疾診尺篇”就是。它的触診方法，主要是候尺肘部形肉的大小緩急滑濇，以及尺肤的寒溫，即方盛衰論所謂“循尺滑濇寒溫”之意。它的診察意义，在灵樞邪气藏府病形篇上，已說得很为具体，它說：“色脉与尺之相应也，如桴鼓影响之相应也，不得相失也。此亦本末根叶之出候也，故根死則叶枯矣，色脉形肉，不得相失也。”張景岳解釋說：“此言色脉形肉，皆当詳察，其于形肉，則当驗于尺之皮肤。”張隱菴也說：“夫胃者，水谷气血之海也，故行于脉中者，至手太阴之两脉口，持其脉，以知藏府之病。血气之行于脉外者，从手阳明之大絡，循經脉之五里而散行于尺肤，故审其尺之緩急大小滑濇、肉之堅脆，而病形定矣，盖太阴主阴，阳明主阳，藏府雌雄相应，气血色脉之相应也。”这是有关診尺肤的理論根据。至于古人的临床运用，大致如下：

灵樞邪气藏府病形篇說：“脉急者，尺之皮肤亦急；脉緩者，尺之皮肤亦緩；脉小者，尺之皮肤亦減而少气；脉大者，尺之皮肤亦實而起；脉滑者，尺之皮肤亦滑；脉濇者，尺之皮肤亦濇。凡此变者，有微有甚，故善調尺者不待于寸，善調脉者不待于色，能參合而行之者，可以为上工。”这是說明了診尺肤与診脉、診色，有同样的价值，假如能够三种方法參合而用之，那就更好了。

又說：“諸急者多寒，緩者多熱，大者多氣少血，小者血氣皆少，滑者陽氣盛，微有熱，濇者多血少氣，微有寒。”这是診尺肤的主要

目标。

灵樞論疾診尺篇說：“尺肤滑而泽脂者，风也；尺肤濇者，风痺也；尺肤粗如枯魚之鱗者，水溢飲也；尺肤热甚，脉甚躁者，病溫也；其脉盛而滑者，病且出也；尺肤寒，其脉小者，泄，少气。”他如“尺濇脉滑，謂之多汗；尺寒脉細，謂之后泄；脉尺粗常热者，謂之热中”等等，都是診尺肤与診脉的合參方法。

至于說，“肘所独热者，腰以上热；手所独热者，腰以下热；肘前独热者，膺前热；肘后独热者，肩背热（外以候外）。臂中独热者，腰腹热；掌中热者，腹中热；掌中寒者，腹中寒（內以候內）”，这又是診尺肤中分部以候病所的方法。

以上是診尺的大概情况，汪石山对此亦是很有体验的，他說：“既診三部，而再試探其尺肤，可以得其身之冷暖、形之肥瘠、肤之疏密，可以知其淺深、內外、久近之病情”。

二、診 肌 表

触診肌表，在临床上亦是很常用的，今述其主要作用如下：

診肌表以知身体的寒热。一般来講，邪气盛的多身热，阳气虛的多身寒。但外邪之中，又有身寒身热之分，以形气互勘，可以分出伤寒或伤暑，如素問刺志論說：“气盛身寒，得之伤寒；气虛身热，得之伤暑。”即阳气方面，亦有身寒身热之分，如逆調論上說：“人身非常溫也，非常热也，为之热而煩滿者，何也？岐伯曰：阴气少而阳气胜，故热而煩滿也。人身非衣寒也，中非有寒气也，阳气少，阴气多，故身寒如从水中出。”这里的寒热，就是所謂“阳虛生外寒，阴虛生內热”的描述。

又有以身寒身热作预后診断的，如通評虛实論上說：“腸澼便血何如？身热則死，寒則生”，这里死生是作预后講，应当活看。事实上，痢且发热的，一般预后确是較差，單痢而不发热的，预后是比較佳良。以上是触診身寒身热的大略。

此外，触診肌表，以輕手循撫，可以察皮肤潤燥，知病員的有汗无汗。重手捫按，可以分腫、脹的不同。如水腫，以手按其腹，隨手而起，如裹水之狀；肤脹，按其腹，腹陷而不起，腹色不变。以腫为

水盛，故按而随起；脹为气滯，故按之陷而不起。此潤燥、腫脹之可从外診而分。

至外科方面，触診肌表运用亦多，如以手按之，腫高而軟的，发于血脉；腫下而坚的，发于筋脉。按之热的为有膿，不热的为无膿。按之便痛的膿淺，大按方痛的膿深。按之陷而不起的，膿未成；按之陷而复起的，膿已成。按之脚軟的，无膿；按之热痛半軟的，当驗其生熟、淺深，而适当开刀出膿。

以上是触診肌表的大概情况，它在临床方面，是都很实用的。

三、診 手 足

触診四肢，在临床上是很重視的，診察目的，亦有多种多样，扼要介紹如下：

触診四肢，可以測候阳气的存亡，为预后性的診斷。如素問通評虛実論上說：“乳子病热，脉悬小者何如？岐伯曰：手足溫則生，寒則死。”灵樞論疾診尺篇上亦說：“大便赤办飧泄脉小者，手足寒难已；飧泄脉小手足溫，泄易已。”伤寒論少阴篇亦說：“少阴病，下利，若利自止，惡寒而蜷臥，手足溫者，可治。”又說：“少阴病，惡寒身蜷而利，手足逆冷者，不治。”以上是触診四肢以决定預后的大略。古人認為四肢为諸阳之本，又为脾所主，如其病虽严重，而四肢犹溫，是阳气尚在，或者脾气未絕，所以尚可不死，或者可治，或者易已。反之，則阳气已亡，或脾气已絕，病就危險了。这是候四肢寒溫的主要意义。

还有候手足寒溫的不同，以診斷病情的属于内外寒热的。如厘正按摩要术上說：“手热足冷，头痛发热者，为挾阴症；手热足冷，汗多妄言者，暑湿病也。”此以手为阳、足为阴，虽然有手热头痛发热的表証，但两足厥冷，病情挾阴，用葯即宜注意，提防阳証轉阴。至暑湿之症，湿属阴邪，其病多足冷，暑病多虛，所以汗出而妄言。

又如“手背热与背上热者，外感；手心热与小腹热者，内伤”，此以外为阳、内为阴，外邪从阳而入，内伤由阴而出之故。

又有候小儿指掌足脛，以决断病情的。如幼科鉄鏡上說：小儿指尖冷，主惊厥；中指独热者，属寒；中指独冷者，分男左女右，为痘

癆发现之象。其或掌心冷，而十指或开或合者，无治。”幼科集成上又說：“是心热，主热；足脛冷，主寒。”

按額部的有热无热，又可以了解病人的发热与否。这种方法，大人小儿，都常应用，尤其小儿多用。这种方法是很有可靠的，額热，可知发热；額不热，可知不发热。并可与手心的热度，进行互勘，假如手心之热甚于額部，这是虚热；反之，額热甚于手心，便是表热。

以上种种，都說明了触診手足，在临証上有很多用处，不仅在病情危急时候要注意，即一般外感内伤亦要注意。不仅大人可用，小儿亦可用。这里不过举其梗概，古人尚有很多經驗，有待于我們进一步钻研。

四、診 胸 腹

胸腹部位，古人謂为五藏六府之宫城，阴阳血气之发源地。触診胸腹，可以探察藏府阴阳虚实的情况，亦是一个临症診察的重点。茲再分节介紹如次。

診虚里：虚里在左乳下，第四、五肋之处，內藏心臟，在此处触診宗气，古人甚为重視。盖因为它可以在迫近部位，探索心臟变化的情况。古人認為虚里为胃之大絡，人以胃气为本，故虚里之动，可以辨病机的輕重；又認為虚里是脉之宗气，为諸脉所宗，宗气應該积于胸中。这种論点，是很可貴的，說明了触診虚里，可以探察血脉的源流变化，它的具体运用如下：

灵樞：五谷入于胃也，其糟粕、津液、宗气，分为三隧，故宗气积于胸中，出于喉嚨，以貫心脉而行呼吸焉。

甲乙經：胃之大絡，名曰虚里，貫膈絡肺，出于左乳下，其动应手，脉宗气也。按之应手，动而不紧，緩而不急者，宗气积于膻中也。其动微而不見，为不及，宗气內虚也；或动而应衣，为太过，宗气外泄也。盛喘数絕者，則病在中；結而橫，有积矣；絕不至，曰死。

魏柳洲說：“凡治小儿，不論諸証，宜先揣虚里穴，若跳甚者，不可攻伐，以其先天不足故也。”王士雄亦說：“大人亦然。小儿則脉候难凭，揣此尤为可据。”

以上是揣虚里的大略情况，以脉診来講，能够揣比，当更多帮

助，尤其是如某些暴厥証，及大虛大實証，往往脉伏不見，如果觸診虛里，動與不動，則一觸可知。此外如虛喘、漫腫、脚氣等証，如能熟練運用，亦可有所幫助。至魏柳洲的說法確是經驗之談，值得我們重視。

診察胸腹的方法，宜按撫數次，或沉或浮，以察胸腹的堅軟以及拒按與否，從而可以揣知虛實。

又，“輕手循撫，自鳩尾至臍下，知皮膚之潤燥，可以辨寒熱；中手尋捫，問疼與不疼，以察邪氣之有無；重手推按，更問疼否，以察藏府之虛實，沉積之何如。即診脉中之浮中沉法也。”

臨床用以觸診積塊的，如“肝之積，名曰肥氣，在左肋下，如覆杯，有頭足；心之積，名曰伏梁，起臍上，大如臂，上至心下；脾之積，名曰痞氣，在胃脘，復如盤；肺之積，名曰息賁，在右肋下，復大如杯；腎之積，名曰黃豚，發于少腹，上至心下，若豚狀，或上或下無時”。

又如用以候痛痞虛實的，金匱有“病者腹滿，按之不痛為虛，痛者為實”，傷寒論有結胸証，心下痛，按之石韌者，用大陷胸湯；虛煩而按之心下濡的，用梔子豉湯；繞臍痛而左腹下按之累累如塊狀，為有燥屎。又有瘀血症的少腹鞭等等，都是通過腹診而指導治療的。

在外科方面，金匱候腸癰的方法，亦頗值得注意，它說：“少腹腫痞，按之則痛如淋，小便自調，其脉迟者，膿未成，可下之。其身甲錯，腹皮急，按之濡，如腫狀，腹無積聚，脉數，膿已成，不可下。”此種診治腸癰方法，對於指導治療，頗具虛實攻守之要。或者懷疑腸癰用大黃牡丹皮湯，有些不放心的，其實在膿已成和未成之間，大黃牡丹皮湯與薏苡附子敗醬散之間，是有嚴格界限的。

又如候虵蟲病變：“診腹有三候，腹有凝結如筋而硬者，以指久按，其硬移他處，又就所移者按之，其硬又移他處，或大腹，或臍旁，或小腹，無定處，是一候也；右手輕輕按腹，為時稍久，潛心候之，有物如蚯蚓蠢動，隱然應手，甚至腹底微鳴，是二候也；高低凹凸，如畎畝狀，熟按之，起伏聚散，上下往來，浮沉出沒，此三候也。”按蛔蟲病變，每每與腹部外症相混，遇有懷疑，上面的三候方法，可以善

为运用。曾見很多場合，病为腹痛，即認作腹部外症，輕易送医院动手术，結果却是蛔虫病，不需用手术而病痊愈了。也有确属腹部外症，誤認作蛔虫病，待至发觉錯誤，病情惡化，送医院亦来不及了。农村方面，尤其是蛔虫病流行地区，往往遇到这些問題，这是值得我們注意的，所以特地把它提出来介紹。

发热疾病的腹候，如与脉診作对照，亦能发现問題。如脉候有热而腹候无热，是表热，其热易去；按腹而热如灼手，是伏热，其热不易去。

小儿暴热，其輕重难以脉辨，而診腹可以得到概念。腹候热重的，其热亦重；腹候热輕的，其热亦輕。若心下动而其热灼手的，尤不可忽。

前人謂診腹要先診臍，因为臍通五臟，是真神往来之門，故名曰“神闕”。按之有力的，为无病；按之无力，如指入香灰中的，病难治。

以上多种多样的腹診，尚不过是一些概略，前人的很多宝贵經驗，还有待于我們作进一步的钻研。其实，很多已是在我們临証中所习用的，逐步总结提高，可以在診斷学上增添許多資料。

小 結

关于切診方面，一般認為切脉是主要的，所以有关于其他各种的触診知識，就并不把它与脉診相提并論。因此，大家就有些忽視，甚至少数同道，認為这門學問，只有日本汉医研究独精，似乎我們反而有些缺如。事实并不是如此，以上我們所講的，絕大部分是散在于祖国医学文献中有关于触診方面的各种知識，同时，也是同道們在临床上所經常运用的。不过，由于祖代相傳，似乎有些“习焉不察”的情况，沒有能够很好地把它单独提出来成为一种專門文献，以致在某些地方，模糊了視听。今后必須进行整理总结，加以发揚和提高，这对于繼承和发揚祖国医学遺產，是有一定作用的。

至于这里面的重点，根据介紹材料，可按人体部位来理解。首先是外表的变态跡象，如診尺肤，它与候脉有同等重要意义，可以从外知內，滑濇、寒溫，是它的重要着眼处；診肌表，有时亦可与診

尺肤联系起来看，它在分別某些症狀的虛实、寒热及腫脹之异，大有可取；診手足，对窺測陽氣的存亡很重要，对外感內傷之辨，亦很可靠。其次是胸腹兩部的探察，如診虛里以候宗氣，是值得很好重視和應用的，它可以輔助診脈所不及，尤其是小兒，在某種情況下，可代替診脈。診腹部，着重在積聚的形狀、部位、痛痞、虛實。蛔蟲診察，亦應作為一個重點，它与腹部外症，每每相混，熟練運用，有很多幫助。腹候寒熱，对診斷寒熱的內外輕重，亦很有價值。當然，这里我們是介紹的一個概略，提供臨床參考而已。至于祖國醫學有关這方面的豐富內容，今后應如何整理發揚和提高，还有待于大家共同的努力。

复 習 題

1. 你对脉象的体会如何？
2. 为什么有是病即有是脉？为什么要舍脉从証、舍証从脉？試举例說明之。
3. 你在临床上常用那些触診？体会如何？

参 考 文 献

1. 素問
2. 灵樞
3. 难經(秦越人)
4. 伤寒論(張仲景)
5. 金匱要略(張仲景)
6. 脉經(王叔和)
7. 甲乙經(皇甫謐)
8. 諸病源候總論(巢元方)
9. 千金方、翼方(孫思邈)
10. 外台秘要(王燾)
11. 东垣內外傷辨、脾胃論(李杲)
- ✓ 12. 診家樞要(滑伯仁)
- ✓ 13. 敖氏伤寒金鏡錄(杜清碧原編，史介生重訂)
- ✓ 14. 类經(張景岳)

15. 医学入門(李挺)
16. 景岳全書(張景岳)
17. 医宗必讀(李士材)
18. 医宗金鑑(吳謙等)
19. 張氏医通(張石頑)
20. 徐灵胎医書全集
21. 医門法律(喻嘉言)
22. 寓意草(喻嘉言)
23. 医学心悟(程鍾齡)
24. 四診抉微(林之翰)
25. 溫疫論(吳又可)
26. 溫病条辨(吳塘)
27. 溫熱經緯(王孟英)
28. 厘正按摩要術(張筱山)
29. 廣瘟疫論(戴北山)
30. 外診察病法(蔣廷錫)
31. 喉痧正的(曹心怡)
32. 医学实在易(陈修园)
33. 脉学正义(張山雷)
34. 圖書集成医部全录(四診部分)
35. 中国医学大辞典(謝觀)
36. 顧氏医鏡(顧靖远)
37. 辨舌指南(曹炳章)
38. 通俗伤寒論(俞根初原著,徐荣斋整理)
39. 时氏診斷学(时逸人)
40. 中医病理与診斷講义(成都中医进修学校)
41. 中医雜誌